Université Jean Moulin Lyon 3
Master 2 Santé, Environnement et Informations Spatio-temporelles

Direction de la Coordination de la Gestion du Risque
Centre-Val de Loire

Mémoire de Master 2

Géographie de la santé

Soutenir l'accès aux soins des personnes en situation de handicap en Centre-Val de Loire

Du démarchage de proximité à la téléconsultation assistée : diagnostic territorial d'une action de gestion du risque

Présenté par :
Gora NDOYE

Sous la direction de :
Pr. Philippe VIDAL
Géraldine VIATOUR
Michel MATAS

Année universitaire 2025-2026

Remerciements

Ce mémoire doit beaucoup à celles et ceux qui l'ont rendu possible, et je tiens à leur exprimer ma reconnaissance.

Mes remerciements vont en premier lieu à Monsieur Philippe VIDAL, directeur de ce mémoire, dont les orientations méthodologiques et la constance de l'accompagnement ont été déterminantes dans la construction de ce travail, comme elles l'avaient été l'an passé. Sa disponibilité et l'exigence de ses relectures en ont façonné la démarche autant que le résultat.

Je remercie Madame Géraldine VIATOUR et Monsieur Michel MATAS, qui ont encadré ce travail au sein de la DCGDR du Centre-Val de Loire. Ils m'ont ouvert l'accès aux données, associé aux instances, et laissé la liberté de conduire le diagnostic selon mes propres hypothèses.

Ma reconnaissance va à l'ensemble de la DCGDR pour l'accueil qui m'a été réservé durant cette année d'alternance.

Je remercie tout particulièrement Madame Délia BOURDIN, chargée de mission à la DCGDR et co-pilote de l'action GDR, dont la connaissance du dispositif et la disponibilité constante ont accompagné ce travail tout au long de l'année, ainsi que les statisticiens, dont les extractions constituent le socle de cette étude.

Je remercie enfin l'équipe pédagogique du master Santé, Environnement et Informations Spatio-temporelles pour la formation reçue au cours de ces deux années.

J'adresse mes derniers remerciements à ma famille et à mes proches pour leur soutien constant, et tout particulièrement à ma mère, ainsi qu'à la mémoire de mon père.

Liste des acronymes

AAH	Allocation aux adultes handicapés
ACP	Analyse en composantes principales
ALD	Affection de longue durée
APL	Accessibilité potentielle localisée
ARS	Agence régionale de santé
CAH	Classification ascendante hiérarchique
C&RT	Classification and Regression Tree, arbre de classification et de régression
CIF	Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé
CIH	Classification internationale des handicaps
CNAM	Caisse nationale de l'assurance maladie
COG	Convention d'objectifs et de gestion
CPAM	Caisse primaire d'assurance maladie
CPTS	Communauté professionnelle territoriale de santé
DAM	Délégué de l'assurance maladie
DCGDR	Direction de la coordination de la gestion du risque
DGOS	Direction générale de l'offre de soins
DMP	Dossier médical partagé
DREES	Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
EHPAD	Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
GDR	Gestion du risque
HAS	Haute Autorité de santé
HCAAM	Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie
HPST	Hôpital, patients, santé et territoires (loi du 21 juillet 2009)
IDEL	Infirmier diplômé d'Etat libéral
INSEE	Institut national de la statistique et des études économiques
IRDES	Institut de recherche et documentation en économie de la santé
JVMALIN	Service régional d'information multimodale du Centre-Val de Loire
MDPH	Maison départementale des personnes handicapées
MISAS	Mission d'accompagnement santé
MMQGIS	Extension de géocodage et d'analyse spatiale pour QGIS
MSP	Maison de santé pluriprofessionnelle
NGAP	Nomenclature générale des actes professionnels
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OMS	Organisation mondiale de la santé
ONU	Organisation des Nations unies
ORS	Observatoire régional de la santé
ORS Tools	Extension QGIS d'appel à l'interface OpenRouteService (à ne pas confondre avec l'ORS)
ReSHa	Recours aux soins des personnes handicapées (projet de recherche IReSP-CNSA)
RPPS	Répertoire partagé des professionnels de santé
SIAM ERASME	Système d'information de l'assurance maladie
SNCF	Société nationale des chemins de fer français
SNDS	Système national des données de santé
SNIIRAM	Système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie
SPF	Santé publique France
TC	Transport en commun
TLD, TLL, TLS	Codes de cotation de l'accompagnement infirmier à la téléconsultation
URPS	Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux
WGS 84	World Geodetic System 1984, système géodésique de référence
XLSTAT	Extension d'analyse statistique pour tableur

Table des matières

Introduction générale 8

Chapitre 1. Le handicap : construction conceptuelle, définition juridique et opérationnalisation statistique 11

1.1. Du modèle médical au modèle social : une trajectoire conceptuelle 11

1.2. La définition juridique française et la question du dénombrement 12

1.3. L'opérationnalisation retenue dans l'action GDR 13

Chapitre 2. L'accès aux soins des personnes en situation de handicap : état de la littérature 15

2.1. Un moindre recours aux soins courants et préventifs 15

2.2. La typologie des obstacles 16

2.3. Renoncement, non-recours et vulnérabilité : clarifications conceptuelles 17

2.4. Handicap, vieillissement et ruralité : le cumul des vulnérabilités 18

Chapitre 3. L'« aller-vers » : généalogie d'un paradigme et inscription institutionnelle 20

3.1. Une notion issue du travail social 20

3.2. L'inscription dans la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027 20

3.3. La gestion du risque : cadre institutionnel et chaîne de décision 21

3.4. La téléconsultation assistée : cadre juridique, conventionnel et économique 22

Chapitre 4. Démarche, sources et traitements 25

4.1. Le type de démarche 25

4.2. Les sources de données 26

4.3. La population étudiée et son géocodage 26

4.4. Les outils et les traitements 27

4.4.1. Les traitements statistiques 27

4.4.2. Les traitements cartographiques 28

4.4.3. Les indicateurs d'accessibilité mobilisés 28

4.4.4. La recherche bibliographique 29

4.5. La mesure des temps de trajet 29

4.5.1. Deux seuils de praticabilité 31

4.6. La restitution : un portail cartographique à destination des caisses 31

4.7. Limites et précautions d'interprétation 32

Chapitre 5. L'armature territoriale du Centre-Val de Loire 34

5.1. Une région dominée par le rural à habitat dispersé 34

5.2. L'offre de proximité identifiée comme accessible 36

Chapitre 6. Une typologie territoriale des usages et des contraintes 38
Chapitre 7. Le public cible : localisation, structure et caractérisation 40
7.1. Une population de 535 assurés géolocalisés 40
7.2. Recours à la téléconsultation et présence du public cible : une relation inverse 41
Chapitre 8. L'accès routier : une contrainte apparemment modérée 43
8.1. La distribution régionale des temps de trajet routiers 43
8.2. La ventilation départementale 45
8.3. Une accessibilité routière trompeuse 45
Chapitre 9. L'accès en transport en commun : le renversement du diagnostic 47
9.1. Un tiers du public sans solution de transport collectif 47
9.2. Une durée de déplacement multipliée par 2,7 48
9.3. Structure des itinéraires : un réseau conçu pour d'autres usages 49
9.4. Une segmentation opérationnelle du public cible 50
Chapitre 10. Les conditions de faisabilité : accompagnant de proximité et accessibilité des lieux de soins 53
10.1. L'infirmier libéral, pivot naturel du dispositif 53
10.2. Une couverture régionale partielle et très inégale 53
10.3. Deux configurations de déploiement 55
Chapitre 11. Configurations départementales : trois cas révélateurs 57
11.1. L'Indre : le transport plutôt que l'offre 57
11.2. Le Loiret : la concentration du niveau 3 61
11.3. L'Eure-et-Loir : le contre-exemple 65
11.4. Trois configurations intermédiaires : le Cher, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher 69
Chapitre 12. Ce que le diagnostic établit et ce qu'il ne peut établir 73
12.1. Les limites du diagnostic 73
12.2. Ce que le diagnostic ne peut pas dire 74
Chapitre 13. Priorisation, conditions de réussite et évaluation 75
13.1. Une grille de priorisation opérationnelle 75
13.2. Conditions de réussite, risques et points de vigilance 76
13.2.1. Quatre conditions de réussite 76
13.2.2. Quatre risques identifiés 77
13.3. Propositions pour l'évaluation du dispositif 77
Conclusion générale 79

Bibliographie.....82
Annexes 85

Liste des figures

Figure 1 : Grille communale de densité, Centre-Val de Loire 35
Figure 2 : Localisation des cabinets de médecins généralistes et d'infirmiers référencés comme accessibles, Centre-Val de Loire 36
Figure 3 : Typologie communale issue de la classification ascendante hiérarchique, Centre-Val de Loire 38
Figure 4 : Nombre d'assurés en situation de handicap sans médecin traitant par communauté professionnelle territoriale de santé 40
Figure 5 : Temps de trajet routier vers les cabinets et localisation des assurés en situation de handicap, Centre-Val de Loire 44
Figure 6 : Typologie communale issue de la classification ascendante hiérarchique dans l'Indre 58
Figure 7 : Distance au cabinet accessible le plus proche dans l'Indre 59
Figure 8 : Temps de trajet routier des assurés en situation de handicap dans l'Indre 60
Figure 9 : Typologie communale issue de la classification ascendante hiérarchique dans le Loiret 61
Figure 10 : Distance au cabinet accessible le plus proche dans le Loiret 62
Figure 11 : Grille communale de densité dans le Loiret 63
Figure 12 : Temps de trajet routier des assurés en situation de handicap dans le Loiret 64
Figure 13 : Typologie communale issue de la classification ascendante hiérarchique en Eure-et-Loir 66
Figure 14 : Distance au cabinet accessible le plus proche en Eure-et-Loir 67
Figure 15 : Temps de trajet routier des assurés en situation de handicap en Eure-et-Loir 68
Figure 16 : Temps de trajet routier des assurés en situation de handicap dans le Cher 70
Figure 17 : Temps de trajet routier des assurés en situation de handicap en Indre-et-Loire 71
Figure 18 : Temps de trajet routier des assurés en situation de handicap en Loir-et-Cher 72

Liste des tableaux

Tableau 1 : Fiche synthétique de l'action de gestion du risque.....21
Tableau 2 : Répartition des communes et de la population selon la grille communale de densité, Centre-Val de Loire 34
Tableau 3 : Caractérisation des cinq classes de la typologie communale.....38
Tableau 4 : Distribution des temps de trajet routiers vers le cabinet accessible le plus proche43
Tableau 5 : Temps de trajet routiers vers le cabinet accessible le plus proche, par département 45
Tableau 6 : Desserte en transport en commun du public cible, par département.....47
Tableau 7 : Ecart entre les temps de trajet routier et en transport en commun (trajets comparables) 48
Tableau 8 : Segmentation du public cible selon l'accessibilité d'une solution de proximité ...50
Tableau 9 : Répartition départementale des trois niveaux d'intervention 51
Tableau 10 : Couverture du public cible par un infirmier référencé accessible situé à moins de 8 km 53
Tableau 11 : Principaux trajets routiers supérieurs à 25 minutes, Indre (36).....60
Tableau 12 : Principaux trajets routiers supérieurs à 25 minutes, Loiret (45) 64
Tableau 13 : Principaux trajets routiers supérieurs à 25 minutes, Eure-et-Loir (28) 68
Tableau 14 : Grille de priorisation départementale du déploiement selon les niveaux d'intervention 75

Introduction générale

L'accès aux soins constitue, en France, un droit dont la portée est affirmée avec constance par le législateur et dont l'effectivité demeure pourtant inégalement garantie selon les personnes et selon les lieux. Le code de la santé publique dispose, en son article L. 1110-1[1], que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne, et que les professionnels, les établissements et les organismes d'assurance maladie contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, à garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et à assurer la continuité des soins. Cette formulation juridique installe une exigence d'égalité qui se heurte, dans les faits, à deux ordres de contraintes dont l'articulation constitue l'objet de ce mémoire : la contrainte territoriale, qui tient à la distribution inégale de l'offre de soins dans l'espace, et la contrainte capacitaire, qui tient à l'inadaptation des dispositifs de soins aux personnes dont les capacités fonctionnelles sont limitées.

La première contrainte est aujourd'hui bien documentée. Dès 2011, l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) établissait, sur des données de 2007, que si un quart de la population des communes françaises disposait d'un praticien dans sa commune de résidence, un autre quart devait parcourir de 10 à 23 km pour accéder à un spécialiste, et que les populations les plus éloignées des soins spécialisés étaient également les plus éloignées des soins de proximité (Coldefy et al., 2011). Ce diagnostic a été régulièrement confirmé depuis, jusqu'aux travaux les plus récents de l'IRDES sur les inégalités spatiales d'accessibilité aux médecins spécialistes, qui proposent une refonte des indicateurs de type accessibilité potentielle localisée (APL) intégrant la dimension tarifaire de l'accès et les pratiques différenciées de déplacement selon les espaces (Lucas-Gabrielli et al., 2025).

La seconde contrainte est plus rarement traitée dans une perspective géographique. La littérature consacrée à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, structurée en France autour de l'exploitation des enquêtes Handicap-Santé conduites par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en 2008-2009, a principalement documenté les obstacles physiques, informationnels, financiers et relationnels qui s'opposent au recours aux soins courants et préventifs (Lengagne et al., 2015; Safon & Suhard, 2023). Elle a comparativement peu interrogé la dimension proprement spatiale de ces obstacles, c'est-à-dire la manière dont la localisation résidentielle des personnes concernées et la configuration des

[1] « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. »

réseaux de transport transforment une distance kilométrique apparemment modeste en une barrière effective. Or c'est précisément à l'intersection de ces deux contraintes que se situe la population qui fait l'objet de ce travail : des assurés vivant avec un handicap moteur, résidant majoritairement dans des espaces ruraux ou périurbains faiblement dotés, et dépourvus de médecin traitant déclaré.

La région Centre-Val de Loire offre à cette question un terrain d'observation particulièrement démonstratif. Elle demeure la région métropolitaine où la densité médicale est la plus faible (*Cf. annexe 1*), et les zonages conventionnels y classent aujourd'hui la quasi-totalité du territoire en situation de sous-dotation. Cette rareté de l'offre de soins s'ajoute à plusieurs difficultés territoriales : un habitat rural dispersé, un vieillissement plus marqué dans les zones les plus isolées et des difficultés d'accès au numérique qui touchent également ces territoires. Le cumul de ces facteurs place certaines communes dans une situation doublement défavorable : elles sont à la fois éloignées des professionnels de santé et disposent de moins de moyens pour utiliser les solutions numériques permettant de faciliter l'accès aux soins[2].

C'est dans ce contexte qu'a été construite, au sein de la direction de la coordination de la gestion du risque (DCGDR) du Centre-Val de Loire, l'action intitulée « Soutenir l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap ». Cette action procède d'une logique d'aller-vers, c'est-à-dire d'une démarche par laquelle l'institution ne se contente plus d'ouvrir un droit et d'attendre que l'assuré le mobilise, mais identifie activement les personnes en situation de non-recours et organise leur parcours. Son objet premier est de restaurer une relation de soin ordinaire : il s'agit, par un démarchage individuel conduit par les conseillers accompagnement santé, d'aider chaque assuré repéré à trouver un médecin disponible à proximité de son domicile, et si possible à déclarer un médecin traitant. Ce n'est qu'à défaut, lorsque aucune solution de proximité n'est atteignable ou disponible, que l'action mobilise un second levier, la téléconsultation assistée, dans laquelle le patient est accompagné par un professionnel de proximité, qui garantit la qualité de l'examen clinique et compense la perte d'autonomie. L'articulation de ces deux niveaux, le démarchage de proximité d'abord et la téléconsultation assistée ensuite, constitue l'architecture même du dispositif et commande l'organisation de cette étude.

[2] Cette situation régionale s'inscrit dans un contexte national lui-même dégradé : avec environ 3,2 médecins en exercice pour 1 000 habitants en 2022, la France figure parmi les pays de l'Union européenne à la densité médicale la plus faible, et cette densité est restée stable depuis 20 ans alors que la moyenne européenne progressait d'un tiers (Or et Parry, 2026, d'après OCDE, 2024).

Le dispositif n'étant pas déployé au moment de la rédaction, ce mémoire n'en évalue pas les résultats : il en fonde le ciblage. La question principale peut ainsi être formulée de la manière suivante :

Dans quelle mesure un démarchage individuel conduit par l'assurance maladie permet-il aux personnes en situation de handicap moteur dépourvues de médecin traitant d'accéder à un médecin disponible à proximité de leur domicile en Centre-Val de Loire, et dans quels territoires cette solution de proximité se révèle-t-elle hors d'atteinte, justifiant le recours à la téléconsultation assistée comme levier subsidiaire ?

Cette problématique se décline en quatre objectifs de recherche. Le premier objectif est d'identifier, à l'échelle des communes et des territoires, les zones où plusieurs facteurs de vulnérabilité se cumulent : éloignement des soins, difficultés d'accès au numérique, ruralité et vieillissement de la population. Le deuxième est de mesurer les difficultés réelles de déplacement rencontrées par ces personnes. Pour cela, les temps de trajet sont calculés à partir de l'adresse de chaque assuré jusqu'au cabinet le plus proche, en voiture et en transports en commun. Cette approche permet de mesurer plus précisément les contraintes de mobilité que les indicateurs d'accessibilité théorique appliqués à l'ensemble de la population. Le troisième consiste à classer les personnes identifiées selon leur niveau d'accès aux soins de proximité. On distingue les personnes pouvant accéder facilement aux soins, celles pouvant y accéder avec un accompagnement pour leurs déplacements, et celles pour lesquelles cet accès reste difficile ou impossible. Cette classification permet de déterminer le levier d'action le plus adapté à chaque personne. Enfin, le quatrième objectif est d'évaluer la faisabilité de la solution alternative pour les personnes les plus éloignées. Il s'agit notamment de vérifier la possibilité de bénéficier d'un accompagnement, la qualité de la connexion numérique et l'accessibilité physique des lieux où les soins sont proposés.

Le mémoire s'organise en 6 parties. La première présente le cadre conceptuel et institutionnel de l'étude, tandis que la suivante décrit la méthodologie. La troisième établit le diagnostic territorial à l'échelle régionale. La quatrième analyse les contraintes de mobilité et permet de répartir le public en trois niveaux d'intervention. L'analyse est ensuite déclinée à l'échelle des 6 départements de la région. Enfin, la dernière partie discute la portée et les limites du dispositif, propose une priorisation des interventions et formule des recommandations pour son évaluation.

PREMIÈRE PARTIE

CADRE CONCEPTUEL ET INSTITUTIONNEL : LE HANDICAP, L'ACCÈS AUX SOINS ET LA DÉMARCHE D'ALLER-VERS

« Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi du 11 février 2005

Chapitre 1. Le handicap : construction conceptuelle, définition juridique et opérationnalisation statistique

La définition retenue du handicap détermine la population que l'on dénombre, et par conséquent les obstacles que l'on identifie et les politiques que l'on juge justifiées. Les travaux consacrés aux méthodes de délimitation de la population handicapée l'établissent de longue date (Ravaud et al., 2002), et l'absence de consensus français sur ce dénombrement demeure une limite reconnue du champ (Safon & Suhard, 2023). Il est donc nécessaire, avant d'aborder la question de l'accès, de restituer brièvement la trajectoire conceptuelle qui a conduit du modèle médical au modèle social, puis d'exposer la définition juridique retenue en droit français et enfin de préciser la manière dont l'action GDR opérationnalise cette définition à partir des données de remboursement de l'assurance maladie.

1.1. Du modèle médical au modèle social : une trajectoire conceptuelle

D'origine anglaise, le terme de handicap, *hand in cap*, appartient initialement au vocabulaire des courses hippiques, où il désigne la technique consistant à rétablir l'égalité entre les chevaux en pénalisant les mieux classés ; sa signification s'est ensuite inversée pour désigner un désavantage, qu'il soit économique, social ou physique (Safon & Suhard, 2023). A partir des années 60, deux manières de penser le handicap se distinguent (Ravaud et al., 2002), reposant sur une conception différente du lien entre l'état de santé d'un individu et son environnement. Le modèle médical rapporte le handicap à la déficience individuelle, tandis que le modèle social l'interprète comme le produit de l'interaction entre une limitation et des obstacles environnementaux et sociaux (Winance, 2024).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) adopte en 1980 une Classification internationale des handicaps (CIH), construite à partir du modèle du docteur Philip Wood[3] (OMS, 1976), qui

[3] Wood, P.H.N. (1975) Classification of impairments and handicaps

articule trois dimensions en cascade : la déficience, altération d'une fonction ou d'une structure ; l'incapacité, réduction de la capacité d'accomplir une activité ; et le désavantage, préjudice qui limite l'accomplissement d'un rôle social compte tenu de l'âge, du sexe et des facteurs socioculturels. Cette construction introduit l'environnement comme créateur de handicap, mais conserve une logique linéaire qui part de la déficience.

La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, adoptée en 2001 (Chapireau, 2001), remplace la précédente et unifie les modèles biomédical, psychologique et social autour de la notion de fonctionnement. Elle distingue quatre dimensions : les fonctions organiques, les structures anatomiques, l'activité et la participation, et les facteurs environnementaux. La situation de handicap y résulte de la rencontre entre une déficience et une situation de la vie courante, et des incompatibilités que produit un environnement inadapté. La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée en 2006, consacre cette approche en définissant les personnes handicapées comme des personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles et sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société (ONU, 2006)[4].

Cette évolution conceptuelle n'est pas sans conséquence pour la présente étude. Si le handicap résulte de la rencontre entre une déficience et un environnement, alors la distance à parcourir pour atteindre un cabinet médical, la présence ou l'absence d'une ligne de transport en commun, la hauteur d'un ressaut à l'entrée d'un local professionnel ou la qualité de la connexion internet disponible au domicile ne sont pas des circonstances extérieures au handicap : elles en sont des composantes constitutives. C'est cette conception qui justifie qu'un travail de géographie de la santé puisse prétendre éclairer une politique d'accès aux soins destinée aux personnes handicapées, et qui fonde l'hypothèse selon laquelle un dispositif organisationnel supprimant le déplacement agit sur le handicap lui-même et non seulement sur ses conséquences.

1.2. La définition juridique française et la question du dénombrement

En France, c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui fournit, pour la première fois, une définition légale du handicap. L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable

[4] La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 12 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010. Son article 25 reconnaît explicitement le droit des personnes handicapées de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap.

ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Cette définition, qui articule explicitement l'altération et l'environnement, s'inscrit dans la filiation de la Classification internationale du fonctionnement (CIF).

La traduction statistique de cette définition demeure toutefois problématique. Il n'existe pas, en France, de consensus sur le dénombrement des personnes handicapées, et les ordres de grandeur varient considérablement selon que l'on retient une approche déclarative, une approche administrative fondée sur la reconnaissance d'un droit, ou une approche fonctionnelle fondée sur les limitations mesurées. Selon l'édition 2024 du panorama de la DREES consacré au handicap (Bellamy, 2024), 14,5 millions de personnes âgées de 15 ans ou plus vivant à domicile en France métropolitaine, soit 28 % de cette population, déclaraient en 2022 une limitation fonctionnelle sévère, tandis que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) concernait, fin 2022, 1,29 million de bénéficiaires, dont la moitié présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. L'écart entre ces deux ordres de grandeur illustre à lui seul la difficulté : le handicap déclaré et le handicap administrativement reconnu ne recouvrent ni les mêmes personnes ni les mêmes situations.

Cette difficulté est importante pour une politique d'aller-vers. Pour identifier les personnes qui renoncent aux soins ou rencontrent des difficultés d'accès, il faut disposer d'un critère de repérage concret, utilisable dans les systèmes d'information de l'organisme. Ce critère doit être suffisamment précis pour cibler les personnes les plus concernées, tout en permettant de ne pas exclure les situations les plus difficiles. Le choix de ce critère est donc une étape essentielle de la méthode, car il détermine directement les personnes qui pourront être ciblées par le dispositif.

1.3. L'opérationnalisation retenue dans l'action GDR

L'action GDR retient une définition opératoire volontairement restrictive, construite par croisement de trois critères mobilisables dans les bases de l'assurance maladie. Le premier est le remboursement de matériel relevant du handicap moteur, qui atteste d'une limitation fonctionnelle objectivée et prise en charge. Le deuxième est l'absence de médecin traitant déclaré, qui signale une rupture dans l'organisation du parcours de soins coordonné. Le troisième est l'absence de consommation d'acte, qui atteste non pas d'un risque de non-recours mais d'un non-recours déjà installé.

Cette construction appelle deux remarques. D'une part, elle restreint délibérément le champ au handicap moteur, alors même que la littérature établit que les obstacles à l'accès aux soins concernent tout autant, et parfois davantage, les personnes présentant un handicap intellectuel,

psychique ou sensoriel. Ce choix se justifie par la nature du levier mobilisé : la téléconsultation assistée agit d'abord sur la contrainte de déplacement, laquelle constitue la barrière première pour les limitations motrices, tandis que les handicaps cognitifs et psychiques appellent des réponses relevant davantage de l'adaptation de la communication et de l'accompagnement relationnel. D'autre part, la combinaison des 3 critères produit une population de petite taille mais de forte intensité : il ne s'agit pas d'un public à risque de renoncement, mais d'un public déjà sorti du système de soins. Le repérage identifie ainsi 535 assurés géolocalisés à l'échelle régionale, effectif qui peut sembler modeste rapporté aux 2,58 millions d'habitants de la région, mais qui correspond à un ciblage de précision bien déterminé.

Il faut souligner la particularité de cette méthode de repérage. Contrairement aux approches déclaratives, qui reposent sur les réponses des personnes à une enquête, et aux approches administratives, qui nécessitent une démarche préalable auprès d'une maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le recours aux données de remboursement permet d'identifier des personnes sans qu'elles aient eu à effectuer une démarche particulière. Cette méthode permet ainsi de repérer des personnes qui peuvent ne pas être connues des dispositifs existants et qui risquent donc de ne pas être atteintes par les actions reposant sur une demande de leur part. Elle constitue ainsi un outil particulièrement adapté à une démarche d'aller-vers.

Chapitre 2. L'accès aux soins des personnes en situation de handicap : état de la littérature

2.1. Un moindre recours aux soins courants et préventifs

L'état des connaissances relatives à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap en France est longtemps demeuré lacunaire, faute de sources statistiques appropriées. Les enquêtes Handicap-Santé Ménages et Handicap-Santé Institution[5], réalisées par la DREES et l'INSEE en 2008-2009, ont comblé une part importante de ce manque et ont servi de base à l'étude de l'INSEE conduite dans le cadre du projet ReSHa[6], laquelle dresse un état des lieux du recours aux soins courants et à la prévention des personnes en situation de handicap, en ménage ordinaire comme en institution (Lengagne et al., 2015).

Le constat central de ces travaux tient en un paradoxe apparent : les personnes en situation de handicap déclarent plus souvent que la population générale du même âge avoir besoin de soins, et sont pourtant plus nombreuses à y renoncer. Ce paradoxe se manifeste avec une netteté particulière sur les soins qui ne relèvent pas directement du traitement de la déficience. Ainsi, seules 48 % des personnes présentant des limitations motrices accèdent aux soins dentaires, contre 56 % dans la population générale, et cette proportion tombe à 44 % pour les personnes utilisant un fauteuil roulant (Lengagne et al., 2015). Le même constat vaut pour la prévention, les personnes en situation de handicap vivant à domicile ayant un moindre accès aux soins préventifs que les personnes sans handicap (Penneau et al., 2015a). Ce différentiel illustre un mécanisme fondamental : la prise en charge spécialisée du handicap, souvent bien organisée, s'accompagne d'un décrochage sur les soins courants et préventifs, comme si l'intensité du suivi spécifique venait paradoxalement masquer, y compris aux yeux des professionnels, le besoin de soins généralistes.

Un enseignement complémentaire, particulièrement éclairant pour notre objet, est apporté par les travaux comparant le recours selon le mode de vie. L'hébergement en institution favorise l'accès aux soins des personnes de moins de 60 ans en situation de handicap (Penneau et al., 2015b), ce qui signifie, a contrario, que le maintien à domicile, pourtant valorisé par les politiques publiques au nom de l'autonomie et de l'inclusion, s'accompagne d'un risque accru de non-recours lorsqu'il n'est pas assorti d'une organisation du parcours. Or la population

[5] Ces deux enquêtes constituent, à ce jour, la principale source française permettant d'analyser conjointement le handicap et le recours aux soins ; leur ancienneté relative constitue une limite reconnue de la littérature du domaine.
[6] Le projet ReSHa (Inégalités d'accès aux soins des personnes en situation de handicap) vise à répondre à la question récurrente des inégalités d'accès au système de soins en l'appli quant à la population particulièrement vulnérable des personnes en situation de handicap.

identifiée par l'action GDR étudiée ici est précisément une population à domicile, non institutionnalisée, et donc dépourvue de l'effet protecteur que produit l'encadrement collectif.

Cette absence de suivi est également associée, dans ce cas, à l'absence de médecin traitant. Pourtant, le médecin traitant joue un rôle central dans le parcours de soins coordonné, en assurant le suivi du patient et en facilitant son orientation vers les autres professionnels de santé. Son absence ne signifie donc pas seulement que l'assuré n'a pas de médecin référent. Elle peut aussi limiter l'accès aux soins spécialisés, aux examens de dépistage et au suivi des affections de longue durée (ALD). Ce mécanisme rejoint la notion d'accès secondaire aux soins, qui désigne la capacité effective à circuler dans le système une fois le premier contact établi (Lombrail et al., 2004). Le cumul du handicap moteur, du maintien à domicile et de l'absence de médecin traitant définit ainsi une configuration de vulnérabilité cumulative dont la sévérité justifie une intervention proactive.

2.2. La typologie des obstacles

La littérature met en évidence quatre grandes catégories d'obstacles à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Ces difficultés peuvent se cumuler et renforcer les inégalités d'accès aux soins.

Les premiers obstacles sont physiques et matériels. Ils concernent notamment l'accessibilité des cabinets, la disponibilité de matériel adapté et les conditions de transport. Ils ne se limitent pas à l'accès aux locaux pour les personnes en fauteuil roulant. Ils peuvent également concerner l'absence de table d'examen réglable, des sanitaires inadaptés ou encore l'absence de stationnement adapté à proximité. Le transport constitue également une difficulté importante, car il représente la première étape pour accéder aux soins.

Les obstacles informationnels et communicationnels[7] concernent les difficultés à obtenir, comprendre ou transmettre les informations nécessaires aux soins. Ils sont particulièrement importants avec le développement des démarches administratives et de la prise de rendez-vous en ligne. Ces outils facilitent les démarches pour une grande partie de la population, mais peuvent créer des difficultés supplémentaires pour les personnes qui ne disposent pas d'un équipement adapté, d'une connexion suffisante ou des compétences numériques nécessaires.

Les obstacles financiers concernent notamment les restes à charge et les dépassements d'honoraires. Ils peuvent également être liés aux changements de prise en charge et aux difficultés économiques plus générales rencontrées par certaines personnes en situation de

[7] La littérature récente insiste sur la dimension cumulative de ces obstacles : voir « L'accès aux soins des personnes confrontées à de multiples facteurs de vulnérabilité », communication déposée sur HAL, 2016.

handicap. Le lien entre handicap et précarité financière est d'ailleurs largement étudié dans la littérature.

Enfin, les obstacles relationnels et liés aux pratiques des professionnels concernent la relation entre le patient et le professionnel de santé. Ils peuvent se traduire par une durée de consultation insuffisante, une connaissance limitée du handicap, une tendance à attribuer certains symptômes au handicap déjà connu ou encore des difficultés à garantir une participation pleine et éclairée du patient aux décisions concernant ses soins. L'ensemble de ces obstacles peut se cumuler et rendre l'accès aux soins particulièrement difficile. Le Défenseur des droits a documenté ces mécanismes sous l'angle des discriminations dans les parcours de soins, montrant qu'ils relèvent moins d'une intention de refus que d'une inadaptation ordinaire des pratiques (Défenseur des Droits, 2025). L'audition publique conduite par la Haute Autorité de santé (HAS) avait déjà établi ce diagnostic, en relevant que les obstacles aux soins courants et préventifs demeuraient multiples et complexes alors même que les soins spécifiques au handicap avaient progressé (HAS, 2009), constat que le rapport Jacob a prolongé en soulignant la persistance des difficultés d'accès aux spécialistes hors parcours de soins (Jacob & Jousserandot, 2013).

2.3. Renoncement, non-recours et vulnérabilité : clarifications conceptuelles

Le renoncement aux soins et le non-recours sont deux notions proches, mais qui désignent des situations différentes. Il est donc important de les distinguer pour bien interpréter les données utilisées dans ce mémoire. Le renoncement correspond à une situation dans laquelle une personne a identifié un besoin de soins, mais décide ou est contrainte de ne pas y répondre. Cette situation peut notamment être mesurée à partir d'enquêtes dans lesquelles les personnes déclarent elles-mêmes avoir renoncé à des soins. Le non-recours désigne la situation d'une personne qui ne bénéficie pas d'une prestation ou d'un service auquel elle pourrait prétendre, indépendamment de la conscience qu'elle en a (Roduit, 2020) ; il se mesure par confrontation entre l'éligibilité et le recours effectif. La population repérée par l'action GDR relève de la seconde catégorie : l'absence de consommation d'acte constitue un indicateur de non-recours objectivé, dont on ignore s'il procède d'un renoncement conscient, d'un défaut d'information, d'une impossibilité pratique ou d'une combinaison de ces facteurs.

Cette distinction a des conséquences concrètes pour l'action publique. Une politique visant le renoncement aux soins peut principalement agir sur l'information, l'accompagnement et les coûts restant à la charge des personnes. En revanche, une politique visant le non-recours doit aller directement vers les personnes concernées, puisqu'elles ne formulent pas nécessairement de demande. C'est dans cette logique que s'inscrit la démarche d'aller-vers présentée dans le

chapitre suivant. Cette exigence de clarification n'est pas seulement terminologique, car elle commande la mesure : les travaux consacrés à la définition, à l'évaluation et à la compréhension de la santé, de l'accès aux soins et du bien-être des populations vulnérables montrent que le choix des indicateurs retenus détermine largement l'ampleur des écarts observés et, par voie de conséquence, la nature des politiques qu'ils appellent (Bussière, 2023).

La notion de vulnérabilité doit également être utilisée avec prudence. Qualifier une population de « vulnérable » permet de justifier une attention particulière, mais peut aussi donner l'impression que cette vulnérabilité est une caractéristique propre aux personnes concernées. Dans ce mémoire, la vulnérabilité est donc considérée comme le résultat d'une interaction entre une personne et son environnement. Elle ne dépend pas uniquement de la limitation fonctionnelle, mais aussi des conditions dans lesquelles la personne vit. Ainsi, c'est le cumul d'une limitation fonctionnelle, d'un éloignement des soins, d'une faible desserte en transports et de difficultés d'accès au numérique qui peut créer une situation de vulnérabilité. La vulnérabilité est donc ici liée à l'environnement et aux conditions d'accès aux soins, plutôt qu'au handicap pris isolément. Cette conception rejoint celle qu'a imposée la littérature consacrée aux déterminants sociaux de la santé : les écarts observés ne procèdent pas de propriétés individuelles mais de la position occupée dans un ensemble de rapports sociaux et de conditions matérielles d'existence (Fassin et al., 2000). Le cadre conceptuel élaboré pour la Commission des déterminants sociaux de la santé distingue à cet égard les déterminants structurels, qui relèvent de l'organisation sociale et des politiques publiques, et les déterminants intermédiaires, qui décrivent les circonstances concrètes dans lesquelles les personnes vivent et se soignent (Solar & Irwin, 2010). Appliquée à l'accès aux soins, cette distinction invite à traiter l'éloignement, la desserte en transport et la disponibilité d'un accompagnant comme des déterminants intermédiaires modifiables par l'action publique, et non comme des données inertes du contexte.

2.4. Handicap, vieillissement et ruralité : le cumul des vulnérabilités

Un dernier ensemble de travaux s'intéresse au lien entre handicap, vieillissement et territoire. Avec l'âge, les limitations fonctionnelles deviennent plus fréquentes, ce qui rend parfois difficile la distinction entre les situations de handicap et les difficultés liées à la perte d'autonomie. L'action GDR tient compte de cette proximité en ciblant, en plus des personnes en situation de handicap moteur, les seniors isolés vivant en milieu rural et n'ayant pas consommé de soins. Dans les deux situations, la difficulté de se déplacer peut en effet constituer un facteur important d'éloignement des soins.

L’inscription territoriale ajoute une dimension supplémentaire. Les travaux de la DREES relatifs au renoncement aux soins établissent que la faible densité médicale en constitue un facteur aggravant, indépendamment des caractéristiques individuelles (Lapinte & Blandine, 2021). Autrement dit, à caractéristiques et ressources comparables, une personne peut rencontrer davantage de difficultés d’accès aux soins lorsqu’elle vit dans un territoire où l’offre de soins est insuffisante. Le territoire n’est donc pas seulement un espace où les inégalités se manifestent ; il contribue lui-même à les créer et à les renforcer. Ce constat constitue l’un des acquis de la géographie de la santé française. Les travaux consacrés aux territoires français établissent que les inégalités de soins se surimposent aux inégalités de santé selon une géographie qui leur est propre, l’organisation de l’offre et les distances d’accès produisant leurs propres écarts (Vigneron, 2013) ; ils rappellent également que ces différenciations spatiales ne se réduisent pas à la composition sociale des populations concernées et engagent les dynamiques territoriales elles-mêmes (Rican et al., 2014). Le raisonnement conduit dans ce mémoire s’inscrit dans cette filiation : le territoire n’y est pas traité comme une simple maille d’observation, mais comme une composante de l’inégalité d’accès.

Chapitre 3. L'« aller-vers » : généalogie d'un paradigme et inscription institutionnelle

3.1. Une notion issue du travail social

La démarche d'aller-vers ne vient pas à l'origine de l'Assurance Maladie. Elle trouve ses origines dans le travail social et repose sur une idée simple : au lieu d'attendre que les personnes viennent demander de l'aide, les professionnels vont directement à leur rencontre, dans leurs lieux de vie. Cette démarche permet d'établir progressivement une relation avec des personnes qui ne formulent pas nécessairement de demande. Elle s'est notamment développée dans la prévention spécialisée, la réduction des risques et les actions de maraude, avant d'être progressivement utilisée dans d'autres domaines de l'action publique[8].

Ces démarches reposent sur trois changements. Le premier est spatial : au lieu de rester dans l'institution, l'intervention se rapproche des lieux de vie des personnes. Le deuxième est temporel : la relation se construit progressivement, sur une durée plus longue qu'un simple rendez-vous. Le troisième est relationnel : le professionnel prend davantage l'initiative pour aller vers la personne, plutôt que d'attendre qu'elle fasse elle-même une demande. Cette démarche présente toutefois certains risques, notamment celui de devenir intrusive, ce qui nécessite de respecter le consentement de la personne. Cette attention au consentement est également présente dans l'action étudiée ici, dont la mise en œuvre dépend de trois conditions : l'accès au numérique, l'accord du professionnel de santé et l'acceptation du patient. Le repérage des personnes est donc réalisé de manière proactive, mais leur participation reste volontaire.

3.2. L'inscription dans la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027

La convention d'objectifs et de gestion (COG) signée entre l'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) pour la période 2023-2027 (CNAM, 2023) constitue le cadre stratégique dans lequel s'inscrit l'action. Ce document, qui fixe pour 5 ans les orientations et les moyens de la branche maladie, retient l'accès aux soins et à la prévention comme priorité et y associe explicitement une politique d'aller-vers déployée sur les territoires pour lutter contre l'absence de médecin traitant. Il prévoit également que les assurés éloignés du numérique fassent l'objet d'un accompagnement attentionné mobilisant des actions d'aller-vers spécifiques, et que l'accessibilité des services numériques de l'assurance maladie soit garantie aux personnes en situation de handicap.

[8] Sur la généalogie de cette notion et sur les tensions qu'elle recèle, voir « Les démarches d'« aller vers » dans le travail social : une mise en perspective », *Cahiers de l'action*, n° 2, 2022.

Cette inscription conventionnelle n'est pas une simple caution : elle produit des effets concrets sur l'organisation des caisses. Les missions d'accompagnement santé, qui portent les conseillers chargés du repérage, ont vu leur activité progresser fortement, avec 217 449 personnes accompagnées en 2023, soit une hausse de 22,3 % par rapport à l'année précédente[9]. La convention prévoit par ailleurs la désignation d'un professionnel référent handicap dans chaque établissement de santé, signe que la question de l'accès des personnes handicapées est désormais traitée comme un objet de politique publique transversal et non comme une préoccupation sectorielle.

L'action régionale s'inscrit donc dans une double filiation. Elle applique une orientation nationale relative à l'aller-vers et à l'absence de médecin traitant ; elle la territorialise en identifiant, à l'échelle du Centre-Val de Loire, le sous-ensemble de la population pour lequel le cumul de l'absence de médecin traitant, du handicap moteur et de l'éloignement produit la situation la plus critique.

3.3. La gestion du risque : cadre institutionnel et chaîne de décision

La gestion du risque désigne l'ensemble des actions visant à améliorer l'efficience du système de soins en agissant sur les comportements des assurés, des professionnels et des établissements. Elle se distingue de la liquidation des prestations en ce qu'elle mobilise l'organisme comme acteur de la structuration de l'offre et de la demande, et non comme simple payeur. A l'échelle régionale, elle est portée par une direction de la coordination qui articule les priorités nationales avec les caractéristiques du territoire.

Tableau 1 : Fiche synthétique de l'action de gestion du risque

Rubrique	Contenu
Titre de l'action	Soutenir l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap
Pôle de rattachement	Comité opérationnel Offre de soins
Date de soumission	28 avril 2026 (groupe d'expertise)
Etat d'avancement	En cours
Caisses concernées	CPAM du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret (adhésion volontaire)
Public cible	Personnes vivant avec un handicap moteur sans médecin traitant ; seniors en rural isolé sans consommation d'acte
Objectif général	Réduire les écarts d'inégalité d'accès aux soins par un suivi des populations vulnérables
Objectif opérationnel 1	Diminuer le taux de non-recours aux soins du public cible
Objectif opérationnel 2	Organiser le parcours de soins par la téléconsultation assistée, sans que le handicap ou le lieu de résidence constitue un obstacle
Levier principal	Démarchage individuel : accompagner l'assuré vers un médecin disponible à proximité de son domicile

[9] Ces missions constituent le principal vecteur opérationnel de l'aller-vers dans le réseau de l'assurance maladie ; c'est à elles qu'est confié le repérage du public visé par l'action étudiée.

Rubrique	Contenu
Levier subsidiaire	Téléconsultation assistée par un professionnel de santé de proximité, à défaut de solution locale
Indicateur principal	(Nombre d'assurés accompagnés / total du public vulnérable défini) × 100
Financement	Droit commun de la téléconsultation assistée ; rémunération du professionnel accompagnant à la prestation

Le dispositif opérationnel se structure en quatre volets. Le repérage, confié aux conseillers accompagnement santé, procède par requête interne croisant le remboursement de matériel lié au handicap moteur, l'absence de médecin traitant déclaré et l'absence de consommation d'acte, avec priorité donnée aux assurés en rupture de soins. L'orientation constitue le cœur de l'action et procède en deux temps. Le conseiller prend contact avec l'assuré repéré, établit avec lui la nature de son besoin, puis démarche les médecins généralistes exerçant à proximité de son domicile afin d'identifier un praticien acceptant de nouveaux patients ; l'objectif recherché est la déclaration d'un médecin traitant, seule à même de restaurer durablement le parcours de soins coordonné. Ce n'est que lorsque ce démarchage n'aboutit pas, faute de praticien disponible ou faute de solution de déplacement praticable, que la seconde voie est ouverte : la téléconsultation assistée, mobilisée sous réserve de l'accès numérique, de la décision du professionnel de santé, de l'acceptation du patient et de la disponibilité d'un accompagnant. La mobilisation des caisses repose sur l'adhésion volontaire, les délégués de l'assurance maladie assurant la promotion du dispositif auprès des professionnels et la sensibilisation au répertoire des locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le suivi et l'évaluation reposent enfin sur un indicateur de couverture et sur l'observation des indicateurs du baromètre Handifaction[10].

3.4. La téléconsultation assistée : cadre juridique, conventionnel et économique

Le levier subsidiaire mobilisé par l'action appelle un examen de son cadre juridique et économique, car sa disponibilité conditionne la faisabilité du second temps du dispositif. La téléconsultation est l'un des 5 actes de télémédecine définis à l'article R. 6316-1 du code de la santé publique, aux côtés de la téléexpertise, de la télésurveillance médicale, de la téléassistance médicale et de la régulation médicale. Elle a été introduite dans le droit français par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme HPST, puis précisée par le décret du 19 octobre 2010[11]. Son inscription dans le droit commun du remboursement, à compter de septembre 2018, a marqué le passage d'un régime d'expérimentation à un régime de prise en charge ordinaire.

[10] Handifaction est un baromètre national qui mesure l'accès aux soins des personnes en situation de handicap en France grâce à un questionnaire anonyme et participatif.
[11] Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article R. 6316-1 du code de la santé publique, modifié par le décret n° 2021-707 du 3 juin 2021.

La téléconsultation assistée se distingue de la téléconsultation classique par la présence, aux côtés du patient, d'un professionnel de santé pendant la consultation. Cette présence facilite la réalisation de certains examens ou mesures que le médecin à distance ne peut pas effectuer directement. Elle permet également d'aider le patient à utiliser les outils numériques et de maintenir un lien de proximité avec un professionnel qu'il connaît. Les travaux de sociologie des usages ont montré que cette configuration modifie en profondeur le travail clinique, l'examen devenant une opération distribuée entre le médecin distant et le professionnel présent (Gaglio & Mathieu-Fritz, 2018). L'avenant 9[12] à la convention nationale des infirmiers libéraux, conclu en 2022, en a organisé les modalités : l'infirmier peut assister un patient lors d'une téléconsultation réalisée à la demande d'un médecin ou d'une sage-femme, sans que cet acte fasse l'objet d'une prescription médicale préalable.

La rémunération de cet accompagnement est graduée selon les conditions de réalisation, et trois cotations coexistent. Lorsque la téléconsultation s'insère dans une séance de soins infirmiers déjà programmée, l'accompagnement relève de la cotation TLS, valorisée 10 euros ; il est alors cumulable à taux plein avec les autres actes réalisés au cours de la même séance, par application de l'article 11B.4.c de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Lorsqu'il donne lieu à une organisation spécifique dans un lieu dédié aux téléconsultations, il relève de la cotation TLL, valorisée 12 euros, les indemnités de déplacement devenant applicables par dérogation à l'article 13 des dispositions générales de la nomenclature, dans la limite de deux déplacements facturables par jour. Lorsqu'il suppose enfin un déplacement spécifique au domicile du patient, il relève de la cotation TLD, valorisée 15 euros, les indemnités de déplacement s'appliquant également. Cette dernière configuration est celle qu'appelle le public visé par l'action, dont les difficultés de mobilité rendent peu probable le déplacement vers un lieu tiers. Il convient de préciser que le plafond de 20 % d'activité conventionnelle réalisable à distance, fixé par la convention nationale, s'applique au télésoin et non à l'accompagnement à la téléconsultation, pour lequel l'infirmier est physiquement présent auprès du patient (Légifrance, 2022).

Ce cadre permet de faire deux constats sur la faisabilité du dispositif. D'une part, la téléconsultation assistée relève du fonctionnement habituel du système de soins. Elle ne nécessite donc ni expérimentation, ni financement particulier, ni convention spécifique. La principale difficulté est ainsi davantage organisationnelle que juridique. D'autre part, l'intervention du professionnel accompagnant repose sur une rémunération à l'acte. Celle-ci peut toutefois être peu incitative au regard du temps nécessaire à l'accompagnement et des

[12] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046572815

déplacements, notamment en milieu rural. Cette question est d'autant plus importante lorsque les professionnels de santé disposent déjà de peu de temps. La différence entre un dispositif juridiquement possible et un dispositif réellement réalisable constitue donc un enjeu important de la discussion finale.

Une dernière remarque concerne le lien entre la téléconsultation et le parcours de soins. Les téléconsultations s'inscrivent normalement dans le parcours de soins coordonné et reposent notamment sur l'intervention du médecin traitant. Or, le public ciblé par cette action est précisément constitué de personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Des exceptions existent lorsque le patient n'en a pas ou lorsque celui-ci n'est pas disponible dans un délai adapté à son état de santé. Dans ce contexte, l'organisation territoriale joue un rôle important pour permettre la mise en relation entre le patient et un médecin. Les CPTS peuvent ainsi faciliter la recherche d'un médecin, que la consultation soit réalisée en présentiel ou à distance. La téléconsultation assistée ne remplace donc pas la démarche d'aller-vers. Elle intervient lorsque l'accès direct à un médecin est difficile et constitue une solution complémentaire, à condition qu'un médecin puisse être mobilisé. Ces conditions organisationnelles ont été documentées à propos d'un dispositif comparable. L'examen de la téléconsultation dite territoriale, c'est-à-dire adossée à une organisation locale et à la présence d'un professionnel accompagnant, conduit en Normandie, pose explicitement la question de savoir dans quelle mesure ce type de recours peut amortir la crise de l'offre de soins ; les premiers enseignements qui en sont tirés soulignent la dépendance du dispositif à l'égard des conditions d'organisation locales (Vidal & Le Hir, 2023).

DEUXIÈME PARTIE

MÉTHODOLOGIE ET CONSTRUCTION DES DONNÉES

Chapitre 4. Démarche, sources et traitements

La démonstration conduite dans les parties suivantes repose sur un appareil méthodologique qu'il convient d'exposer avec précision, non par souci formel mais parce que plusieurs des résultats obtenus dépendent étroitement des choix opérés : le périmètre de l'offre retenue, le mode de rattachement des assurés aux cabinets et les seuils de praticabilité déterminent directement l'ampleur de la contrainte mesurée. Ce chapitre expose successivement le type de démarche, les sources mobilisées, la population étudiée, les outils de traitement, la mesure des temps de trajet, le dispositif de restitution et les limites de l'ensemble.

4.1. Le type de démarche

La démarche adoptée est de nature quantitative et exploratoire. Elle ne procède pas d'un protocole d'évaluation, le dispositif étudié n'étant pas déployé au moment de la rédaction, mais d'un diagnostic territorial destiné à fonder un ciblage opérationnel. Elle articule trois niveaux d'analyse complémentaires : un niveau régional, mobilisé pour le cadrage ; un niveau communal, qui permet de caractériser finement l'armature du peuplement et l'offre de soins ; et un niveau individuel, constitué par les assurés géolocalisés, sur lequel repose la mesure de la contrainte de mobilité. Le passage du niveau communal au niveau individuel constitue l'apport principal de ce travail par rapport au diagnostic conduit l'année précédente à l'échelle des CPTS (Ndoye, 2025) : il permet de substituer à une accessibilité moyenne, calculée pour une population théorique, une contrainte effectivement subie par des personnes identifiées.

Le choix du Centre-Val de Loire comme terrain procède de trois considérations. La première est institutionnelle : l'action est portée par la DCGDR Centre-Val de Loire, au sein de laquelle j'ai conduit ce travail dans le cadre de mon alternance, les 6 caisses primaires de la région en constituant les opérateurs potentiels. La deuxième est heuristique : la région cumule, à un degré rarement observé en France métropolitaine, une densité médicale minimale, un rural très étendu et un vieillissement prononcé. La troisième est de continuité avec le travail engagé au sein de l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux (URPS), dont ce mémoire prolonge la problématique en la déplaçant de la population générale vers le public vulnérable.

4.2. Les sources de données

L'étude repose sur deux ensembles de sources complémentaires, auxquels s'ajoute un référentiel de l'offre accessible.

Le premier ensemble est constitué des données quantitatives issues du Système national des données de santé (SNDS), et plus particulièrement du système SIAM ERASME de l'assurance maladie et du SNIIRAM, qui permettent d'analyser les consommations d'actes. Ce sont ces bases qui fournissent les volumes d'actes de téléconsultation, la part de patients dépourvus de médecin traitant et les effectifs de patients en ALD. C'est également par requête interne dans ces bases qu'est constitué le fichier du public cible.

Le second ensemble correspond à une base de données communale couvrant l'ensemble des communes de la région, soit 1 754 unités, constituée à partir de plusieurs plateformes : CartoSanté, l'Observatoire des territoires et les Statistiques locales de l'INSEE. Cette base croise des indicateurs d'accessibilité aux soins, des indicateurs socio-démographiques et des indicateurs économiques. S'y ajoute la grille communale de densité de l'INSEE.

Le troisième référentiel, spécifique à ce travail, est constitué du répertoire des locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite, qui recense les professionnels ayant renseigné les caractéristiques d'accueil de leur cabinet dans l'annuaire santé. Il comporte 315 professionnels, dont 225 exerçant en Centre-Val de Loire et 90 dans les départements limitrophes situés à moins de 15 km de la limite régionale. Sur ces 315 cabinets, seuls les médecins généralistes et les infirmiers ont été retenus pour le calcul des trajets, soit 88 médecins généralistes et 71 infirmiers, les autres professions ayant été écartées du champ de l'étude dans la mesure où elles ne constituent pas la porte d'entrée du parcours de soins.

Deux difficultés ont dû être traitées lors de la constitution de la base communale. Certaines données étaient soumises au secret statistique, les cellules concernées étant renseignées en « *NA-secret statistique* », ce qui a légèrement réduit la taille de l'échantillon exploitable pour quelques variables. Par ailleurs, les fusions de communes intervenues ces dernières années ont nécessité un travail de filtrage et de nettoyage afin d'harmoniser les périmètres géographiques entre les différentes sources.

4.3. La population étudiée et son géocodage

Le public cible est identifié par une requête interne croisant 3 critères : le remboursement antérieur de matériel relevant du handicap moteur, l'absence de médecin traitant déclaré et l'absence de consommation d'acte. Cette requête aboutit à un fichier de 546 enregistrements.

Les adresses de ces assurés ont été géocodées sous QGIS au moyen de l'extension MMQGIS, dont la fonction *geocode CSV with web service* mobilise le service Nominatim d'OpenStreetMap. L'opération aboutit à 535 points localisés dans les 6 départements de la région, 11 enregistrements correspondant à des adresses situées hors région ou à des libellés non géocodables avec une précision suffisante. C'est sur ces 535 points que reposent l'ensemble des calculs d'itinéraires. Après contrôle, les 535 assurés et les cabinets retenus disposent tous de coordonnées valides et situées dans l'emprise régionale ; aucune ligne n'a été écartée à ce stade.

Une précaution d'interprétation s'impose : une part des adresses correspond à des boîtes postales ou à des libellés de courrier d'entreprise, identifiables par les mentions de type « *BP* » ou « *CS* ». Ces adresses sont géocodées au centroïde de la commune de distribution, ce qui atténue légèrement les temps calculés pour les communes concernées, généralement des pôles urbains. Cette imprécision est signalée dans les tableaux de résultats par le maintien du libellé d'origine.

4.4. Les outils et les traitements

4.4.1. Les traitements statistiques

Les traitements statistiques ont été réalisés sous Excel, complété par l'extension XLSTAT, qui permet de conduire des analyses multivariées. Quatre méthodes ont été mobilisées : l'analyse en composantes principales (ACP) *(Cf. annexe 3)*, destinée à réduire la dimensionnalité des données initiales tout en conservant l'essentiel de l'information statistique ; la classification ascendante hiérarchique (CAH) selon la méthode de Ward, qui minimise l'augmentation de l'inertie intraclasse à chaque agrégation et, par conséquent en vertu du théorème de Huygens, maximise l'inertie interclasse[13] ; l'arbre de régression de type C&RT, utilisé pour hiérarchiser les variables discriminantes ; et l'analyse factorielle des correspondances. L'unité d'analyse principale des traitements multivariés est la CPTS (n = 33), complétée par la base communale pour la caractérisation socio-démographique fine.

J'ai retenu une coupure du dendrogramme à 5 classes, arbitrage entre la qualité statistique de la partition et son interprétabilité opérationnelle : au-delà, les classes obtenues perdaient en lisibilité sans gain d'inertie interclasse significatif. La caractérisation des classes repose sur une échelle qualitative exprimant l'écart à la moyenne régionale, selon la convention retenue dans la légende des cartes.

[13] Inertie totale = inertie interclasse + inertie intraclasse. Minimiser l'augmentation de l'inertie intraclasse revient donc à maximiser celle de l'inertie interclasse.

4.4.2. Les traitements cartographiques

Les analyses cartographiques ont été effectuées sous QGIS. Deux algorithmes ont été mobilisés de manière complémentaire.

Les isochrones ont été produits au moyen de l'extension ORS Tools, qui interroge l'interface de programmation d'OpenRouteService et calcule automatiquement les temps de trajet vers les cabinets. La fonction *Isochrones from layer* a été retenue, avec des paliers échelonnés de 5 minutes, valeur minimale, à plus d'une heure selon l'éloignement du cabinet. Ces surfaces interpolées constituent le fond des cartes de temps de trajet présentées dans la cinquième partie.

Là où les isochrones décrivent une accessibilité de proximité en tout point de l'espace, l'algorithme « Ligne la plus courte entre les entités » établit le lien entre chaque assuré et le cabinet qui le dessert. Les couches de polygones ont été transformées en centroïdes. Cet algorithme crée une couche de lignes correspondant à la ligne la plus courte entre la couche source et la couche de destination ; par défaut, seule l'entité la plus proche de la couche de destination est retenue, mais il est possible de spécifier un nombre d'entités et une distance maximale au-delà de laquelle les entités sont écartées. Les entités produites contiennent les attributs de la couche source, ceux des entités les plus proches et un champ additionnel de distance. Il convient de noter que cet algorithme repose sur un calcul purement cartésien et ne prend en compte ni les propriétés géodésiques ni celles de l'ellipsoïde : c'est précisément cette limite qui a conduit à lui substituer, pour la mesure de la contrainte, le calcul d'itinéraires exposé au paragraphe suivant.

4.4.3. Les indicateurs d'accessibilité mobilisés

Trois indicateurs composites, produits par des organismes tiers, sont mobilisés de manière récurrente dans les parties suivantes et méritent d'être présentés, car leur construction conditionne l'interprétation des résultats.

L'accessibilité potentielle localisée est un indicateur de type *floating catchment area* fondé sur le modèle *two-step floating catchment area* (Radke & Mu, 2000; Luo & Wang, 2003; Wang & Luo, 2005), développé au début des années 2010 par la DREES et l'IRDES (Barlet et al., 2012). Il rapporte l'offre disponible à la demande potentielle en tenant compte de la distance entre communes : une aire de patientèle est délimitée autour de chaque offre médicale à partir d'une fonction de décroissance de la probabilité de recours selon la distance, puis l'offre est répartie entre les patients potentiels de cette aire. Sa supériorité sur la densité brute tient à ce qu'il prend en compte l'activité effective des professionnels, intègre les flux entre communes voisines et

pondère la demande par la structure d'âge de la population ; cette méthodologie sert aujourd'hui de socle au cadre réglementaire de définition des zonages déficitaires.

Les travaux les plus récents rappellent toutefois que cet indicateur repose sur des choix paramétriques dont l'effet n'est pas neutre, qu'il s'agisse de la borne d'âge des professionnels, de la mesure de l'offre, du seuil de distance maximale ou de la forme de la fonction de décroissance, et montrent notamment que fixer ce seuil à une heure trente plutôt qu'à 60 minutes masque en partie les disparités locales (Lucas-Gabrielli et al., 2025). Ces mêmes auteurs, prolongeant des travaux menés avec l'Observatoire régional de la santé (ORS) d'Île-de-France, ont fait évoluer l'indicateur dans trois directions : réduction de l'échelle géographique d'observation, prise en compte de la dimension sociale des besoins et, surtout, intégration des pratiques de déplacement différenciées selon les espaces et les caractéristiques sociales des populations (Lucas-Gabrielli & Mangeney, 2019, 2021). Cette dernière évolution est directement pertinente pour notre objet. L'APL est donc mobilisée ici comme indicateur de cadrage, et non comme mesure de la contrainte effectivement subie par le public cible, laquelle est appréhendée par le calcul d'itinéraires individuels exposé plus loin.

La grille communale de densité de l'INSEE, enfin, classe les communes en 7 catégories, des grands centres urbains au rural à habitat très dispersé, à partir de la répartition de la population. Elle présente pour notre objet l'avantage de saisir la morphologie du peuplement plutôt que le seul volume de population : deux communes de même effectif peuvent relever de catégories différentes selon que leur population est concentrée dans un bourg ou dispersée en hameaux, ce qui détermine directement la faisabilité d'une desserte en transport collectif et la longueur des trajets vers les équipements.

4.4.4. La recherche bibliographique

La recherche bibliographique a été conduite à l'aide du logiciel *Harzing's Publish or Perish*, qui interroge plusieurs bases de citations et facilite l'identification des articles pertinents ainsi que l'appréciation de leur audience. Les requêtes ont porté sur les couples de termes associant handicap, accès aux soins, vulnérabilité, non-recours, ruralité et télémédecine. Cette recherche a été complétée par des rapports institutionnels de l'IRDES, de la DREES et de la HAS. Cette bibliographie a été organisé à l'aide du logiciel Zotero.

4.5. La mesure des temps de trajet

La mesure de la contrainte de mobilité constitue le cœur méthodologique de ce travail. La question posée n'est pas de savoir quel cabinet est le plus proche à vol d'oiseau, mais combien

de temps et sur quelle distance l'assuré doit réellement se déplacer, en voiture comme en transport en commun.

Deux professions ont été retenues, parce qu'elles constituent la porte d'entrée du parcours de soins, mais elles relèvent de deux logiques opposées qui commandent un traitement distinct. Pour le médecin généraliste, c'est le patient qui se déplace vers le cabinet ; pour l'infirmier, c'est le professionnel qui se rend au domicile du patient.

Une première version du calcul rattachait chaque assuré au cabinet le plus proche à vol d'oiseau. Cette approche a été abandonnée : elle ignore la réalité du terrain, qu'il s'agisse d'une rivière sans pont, de l'absence de route directe ou d'une desserte inégale en transport collectif. Le contrôle a montré qu'environ 18 % des assurés disposaient en réalité d'un cabinet plus accessible que le plus proche géographiquement. Le rattachement s'effectue donc sur le trajet réellement parcouru, et il est établi séparément pour chaque mode, le cabinet le plus accessible en voiture n'étant pas nécessairement le même qu'en transport en commun.

Trois grandeurs sont systématiquement produites pour chaque trajet : la distance euclidienne, calculée selon la formule de haversine[14] ; la distance effectivement parcourue sur le réseau ; et la durée porte-à-porte, qui correspond au temps de conduite pour la voiture et, pour le transport en commun, à la somme de la marche, de l'attente et du temps passé à bord.

Deux moteurs de calcul ont été mobilisés, chacun adapté à son mode. Les itinéraires routiers reposent sur l'interface de programmation d'OpenRouteService, appuyée sur le réseau routier d'OpenStreetMap : pour chaque assuré, une matrice de distances et de durées est calculée vers l'ensemble des cabinets éligibles, le cabinet minimisant le critère retenu est sélectionné, puis l'itinéraire détaillé est calculé et enregistré comme géométrie linéaire.

Les itinéraires en transport en commun ont exigé une installation spécifique. Un premier essai s'appuyait sur l'interface de la SNCF, mais celle-ci ne couvre que le réseau ferroviaire : les réseaux de bus urbains et interurbains en étaient absents, ce qui sous-estimait fortement l'offre réelle. J'ai donc installé en local un serveur OpenTripPlanner en version 2.7, qui permet d'assembler dans un même graphe de calcul l'ensemble de l'offre régionale : d'une part JVMALIN, agrégat officiel réunissant 19 réseaux, parmi lesquels TAO à Orléans, Fil Bleu à Tours, Azalys à Blois, Filibus à Chartres, Agglobus à Bourges, Horizon à Châteauroux et le réseau interurbain Rémi des 6 départements ; d'autre part les horaires SNCF pour les liaisons TER, Intercités et à grande vitesse. Le graphe final comprend 1 316 lignes, dont 705 de bus, 7

[14] La formule de haversine est utilisée pour calculer la distance entre deux points sur une sphère, en tenant compte de leurs coordonnées de latitude et de longitude.

de tramway et 604 ferroviaires, ainsi qu'environ 10 300 arrêts, ce qui rend les itinéraires réellement multimodaux : marche, bus, tramway et train peuvent être combinés au sein d'un même trajet. Seuls les itinéraires comportant au moins un tronçon en transport collectif sont conservés, un trajet entièrement pédestre ne constituant pas une desserte.

Les calculs ont été effectués pour un départ à 8 heures, un mardi, jour ouvré représentatif d'un déplacement vers un cabinet médical.

4.5.1. Deux seuils de praticabilité

Deux seuils ont été introduits, dont la justification est organisationnelle et non statistique.

Le premier concerne les infirmiers. Le soin infirmier s'effectue au domicile du patient et s'inscrit dans une tournée, souvent répétée plusieurs fois par jour ; au-delà d'un certain rayon, cette tournée cesse d'être réalisable dans des conditions normales d'exercice. Un seuil de 8 km de trajet routier, et non de distance à vol d'oiseau afin de correspondre au kilométrage effectivement parcouru, a donc été appliqué : lorsque l'infirmier le plus proche se situe au-delà, aucun trajet n'est produit et l'assuré est écarté du livrable. Sur les 535 assurés, 243 disposent d'un infirmier référencé à 8 km ou moins et sont retenus ; 292 sont écartés faute d'infirmier suffisamment proche. Parmi les trajets conservés, la distance médiane s'établit à 3,1 km, soit 6,6 minutes, la plus longue atteignant très exactement le seuil de 8 km.

Le second concerne le transport en commun. Le calcul faisait apparaître des durées manifestement excessives, allant jusqu'à 5 heures. Vérification faite, il ne s'agissait pas d'erreurs : ces itinéraires existent bel et bien, mais reposent sur des correspondances entre cars ruraux très peu fréquents, un cas typique cumulant 40 minutes de marche, 2 heures 20 minutes d'attente et 2 heures de trajet à bord. Théoriquement valides, ces trajets ne décrivent aucun déplacement praticable, en particulier pour une personne en situation de handicap se rendant à une consultation. Un seuil de praticabilité de 90 minutes a donc été retenu : au-delà, le trajet est signalé comme non praticable, sans durée affichée ni tracé cartographique, plutôt que de faire figurer un temps qui donnerait une image trompeuse de l'accessibilité. Les assurés situés dans des secteurs réellement dépourvus de transport collectif sont, quant à eux, laissés en l'état avec la mention « aucun transport en commun atteignable » : cette absence de desserte constitue un résultat en soi et n'appelle aucune correction.

4.6. La restitution : un portail cartographique à destination des caisses

Un diagnostic territorial n'a d'utilité opérationnelle que s'il est appropriable par ceux qui conduisent l'action. Les livrables produits, fichiers tabulaires comportant une ligne par assuré et couches GeoPackage contenant le tracé de chaque trajet au système de coordonnées WGS

84, sont directement exploitables sous QGIS, mais supposent la maîtrise d'un système d'information géographique dont les conseillers accompagnement santé et les délégués de l'assurance maladie (DAM) ne disposent pas nécessairement.

C'est pourquoi j'ai développé, en complément du présent travail, un portail cartographique en ligne dédié à l'action, accessible à l'adresse ***https://ala-ji.github.io/GDR-Portal/***. Ce portail restitue dans un navigateur, sans installation préalable ni compétence technique particulière, l'ensemble des couches mobilisées dans le diagnostic : localisation des assurés repérés, cabinets référencés accessibles, tracés des trajets routiers et en transport collectif et distance au cabinet le plus proche. Il propose deux fonds de plan, OpenStreetMap et une vue satellitaire, un gestionnaire de couches avec légende dépliable, ainsi qu'un module de filtrage par attribut permettant d'interroger n'importe quelle couche selon un champ, un opérateur et une valeur.

Cette dernière fonction constitue l'apport opérationnel principal du portail. Elle permet en effet à une caisse de sélectionner, en quelques manipulations, les seuls assurés de son département dont le temps de trajet excède un seuil donné, ou les seules communes cumulant un éloignement supérieur à 15 km. Autrement dit, elle transforme le diagnostic en outil de ciblage : là où le présent mémoire établit une géographie de la priorité à l'échelle régionale, le portail permet à chaque caisse et au service des missions d'accompagnement santé de descendre à l'échelle de leur ressort et de constituer leurs propres listes d'assurés à contacter. Il est également conçu comme un support de dialogue avec les professionnels de santé et les CPTS, la visualisation cartographique rendant immédiatement lisible une contrainte que les tableaux statistiques peinent à faire percevoir.

4.7. Limites et précautions d'interprétation

Plusieurs limites doivent être prises en compte dans l'interprétation des résultats. Tout d'abord, les temps de trajet ont été calculés vers les cabinets référencés dans le répertoire des locaux accessibles, et non vers l'ensemble des cabinets existants. Ce choix est cohérent avec l'objectif de l'étude, puisqu'un cabinet dont l'accessibilité n'est pas connue ne peut pas être considéré comme une solution certaine pour une personne à mobilité réduite. Les résultats mesurent donc l'accès à l'offre accessible identifiée, et non à l'ensemble de l'offre de soins.

L'heure de départ constitue également un élément à prendre en compte. Contrairement aux trajets en voiture, les temps de trajet en transport en commun varient selon l'heure de départ et les horaires disponibles. Les résultats présentés correspondent donc à un départ le matin, un jour ouvré.

Les services de transport à la demande constituent une autre limite. Ces dispositifs sont relativement présents dans les zones rurales, mais leurs horaires n'étaient pas intégrés aux données utilisées. Certains assurés classés comme ne disposant pas de desserte en transport en commun peuvent donc bénéficier d'une solution de transport à la demande.

Par ailleurs, l'étude mesure uniquement l'accessibilité géographique des cabinets. Elle ne permet pas de savoir si les professionnels peuvent réellement accueillir de nouveaux patients, ni de connaître les délais pour obtenir un rendez-vous. Elle ne permet pas non plus de vérifier l'accessibilité réelle des véhicules, des arrêts ou des cabinets pour les personnes à mobilité réduite. Les résultats doivent donc être considérés comme une estimation minimale de la contrainte réelle d'accès aux soins.

Enfin, les positions géographiques utilisées reposent sur le géocodage des adresses. Une légère imprécision peut donc exister pour certains points, pouvant aller jusqu'à l'échelle de la parcelle.

TROISIÈME PARTIE

DIAGNOSTIC TERRITORIAL : OÙ SE SITUENT LES SITUATIONS DE VULNÉRABILITÉ CUMULÉE ?

Chapitre 5. L'armature territoriale du Centre-Val de Loire

Le diagnostic d'un dispositif destiné à compenser une contrainte de mobilité suppose d'établir préalablement la morphologie du territoire sur lequel cette contrainte s'exerce. Ce chapitre caractérise successivement la structure de peuplement de la région, la géographie de son vieillissement, le degré de ruralité de ses territoires de coordination et la distribution de son offre de soins de proximité.

5.1. Une région dominée par le rural à habitat dispersé

Sur les 1 754 communes de la région, 1 357 relèvent des deux catégories les plus rurales, soit 77,4 % des communes, mais elles ne rassemblent que 721 359 habitants, c'est-à-dire 27,9 % de la population régionale. A l'inverse, les 22 communes classées en grands centres urbains, soit 1,3 % des communes, concentrent 615 704 habitants, c'est-à-dire 23,8 % de la population. Cette dissymétrie entre l'occupation de l'espace et la répartition de la population constitue la donnée structurante de tout raisonnement sur l'accès aux soins en Centre-Val de Loire[15]. Cette configuration relève de ce que la géographie de la santé analyse comme un effet de structure : l'inégalité d'accès ne procède pas seulement du nombre de professionnels rapporté à la population, mais de la manière dont l'offre et les habitants se distribuent l'un par rapport à l'autre dans l'espace (Vigneron, 2013).

Tableau 2 : Répartition des communes et de la population selon la grille communale de densité, Centre-Val de Loire

Catégorie de densité	Communes	Part des communes (%)	Population	Part de la population (%)
Grands centres urbains	22	1,3	615 704	23,8
Centres urbains intermédiaires	15	0,9	254 357	9,9
Ceintures urbaines	47	2,7	208 592	8,1
Petites villes	55	3,1	260 408	10,1
Bourgs ruraux	258	14,7	521 177	20,2
Rural à habitat dispersé	992	56,6	624 623	24,2
Rural à habitat très dispersé	365	20,8	96 736	3,7
Ensemble	**1 754**	**100,0**	**2 581 597**	**100,0**

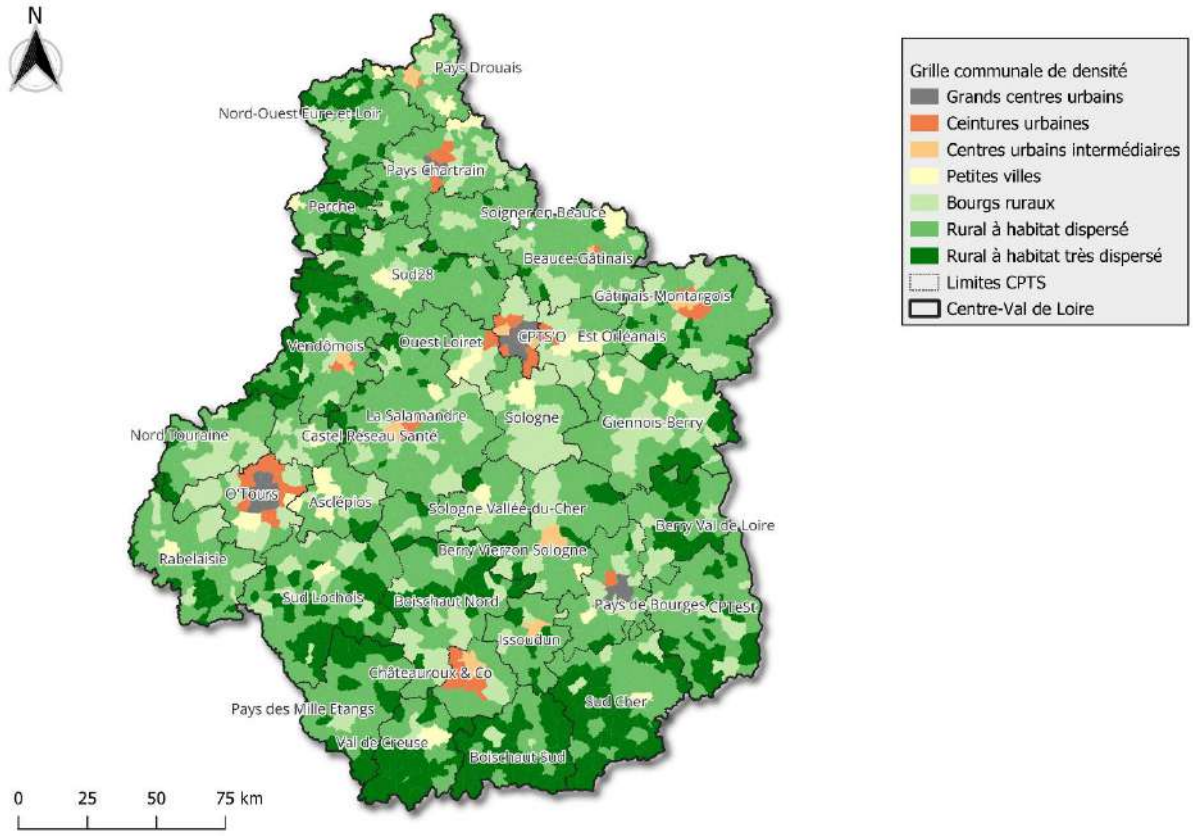
Source : INSEE, grille communale de densité 2025.

Réalisation : Gora NDOYE

[15] La grille communale de densité repose sur la répartition de la population au sein de carreaux d'un km de côté, ce qui permet de distinguer deux communes de même effectif selon que leur peuplement est aggloméré ou dispersé.

Cette structure de peuplement commande directement les conditions du recours aux soins, et pas seulement par la distance. Les espaces ruraux à habitat dispersé cumulent en effet une offre physique rare et un équipement numérique plus faible, de sorte que la solution à distance y est la moins disponible là où elle serait la plus utile. Le constat vaut à l'échelle nationale : une étude récente établit que 52 % des patients ne pouvaient pas réaliser de téléconsultation faute d'un équipement suffisant, et une enquête de Santé publique France que 72 % des adultes rencontrent des difficultés à accéder à l'information en santé en ligne, à la comprendre et à l'utiliser, les difficultés d'accès aux équipements constituant un obstacle majeur dans les zones défavorisées (SPF, 2024; Goupil de Bouillé et al., 2025). Cette limite pèse sur le levier subsidiaire de l'action et sera retrouvée au moment d'en examiner les conditions de faisabilité.

Figure 1 : Grille communale de densité, Centre-Val de Loire



Source : INSEE, grille communale de densité 2025 ;

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

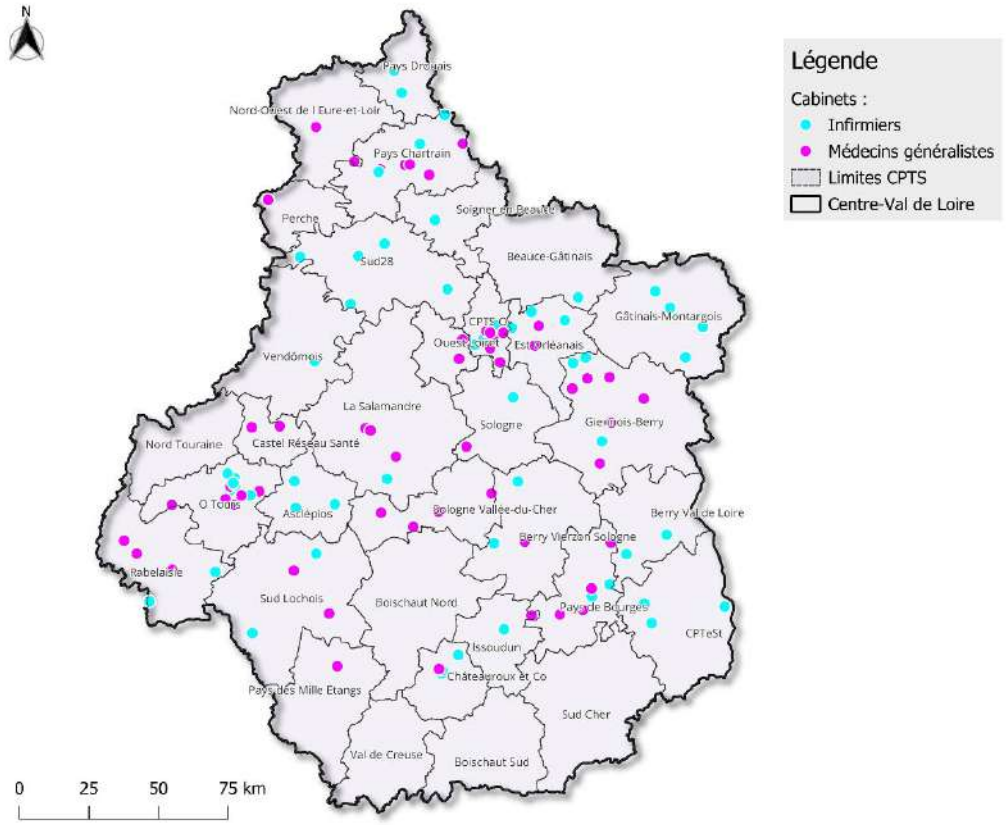
Les grands centres urbains apparaissent sous la forme de taches ponctuelles correspondant aux agglomérations d'Orléans, de Tours, de Bourges, de Chartres, de Blois et de Châteauroux, entourées de leurs ceintures urbaines ; le reste du territoire est occupé, dans une continuité quasi ininterrompue, par le rural à habitat dispersé et très dispersé. Les concentrations de rural très dispersé dessinent des ensembles cohérents qui constitueront, tout au long de l'analyse, les espaces de concentration des difficultés : la Brenne et le Boischaut dans l'Indre, la Sologne à

cheval sur le Loir-et-Cher, le Cher et le Loiret, le Perche à l'ouest de l'Eure-et-Loir, le Pays-Fort au nord du Cher et l'est gâtinais dans le Loiret.

Les espaces les plus contraints ne sont pas systématiquement les plus éloignés des métropoles : la Sologne, située à moins de 40 km d'Orléans et de Blois, présente des caractéristiques comparables à celles du sud de l'Indre. Il en résulte que le ciblage d'une action ne peut se fonder sur la distance aux pôles régionaux mais doit s'appuyer sur des indicateurs communaux.

5.2. L'offre de proximité identifiée comme accessible

Figure 2 : Localisation des cabinets de médecins généralistes et d'infirmiers référencés comme accessibles, Centre-Val de Loire



Source : Santé.fr 2026, annuaire de l'accessibilité des cabinets

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

Cette carte est fondamentale pour comprendre les conditions de faisabilité du dispositif, mais elle doit être lue avec une précaution méthodologique : elle ne représente pas l'ensemble de l'offre régionale, mais les seuls professionnels ayant renseigné les caractéristiques d'accessibilité de leur local dans le répertoire dédié. Elle constitue à ce titre moins une cartographie de l'offre qu'une cartographie de l'information disponible sur l'accessibilité de cette offre, statut qui ne diminue pas son intérêt, puisque pour une personne à mobilité réduite sans médecin traitant, un cabinet dont les conditions d'accueil ne sont pas documentées constitue une incertitude, et l'incertitude est en soi un frein au recours.

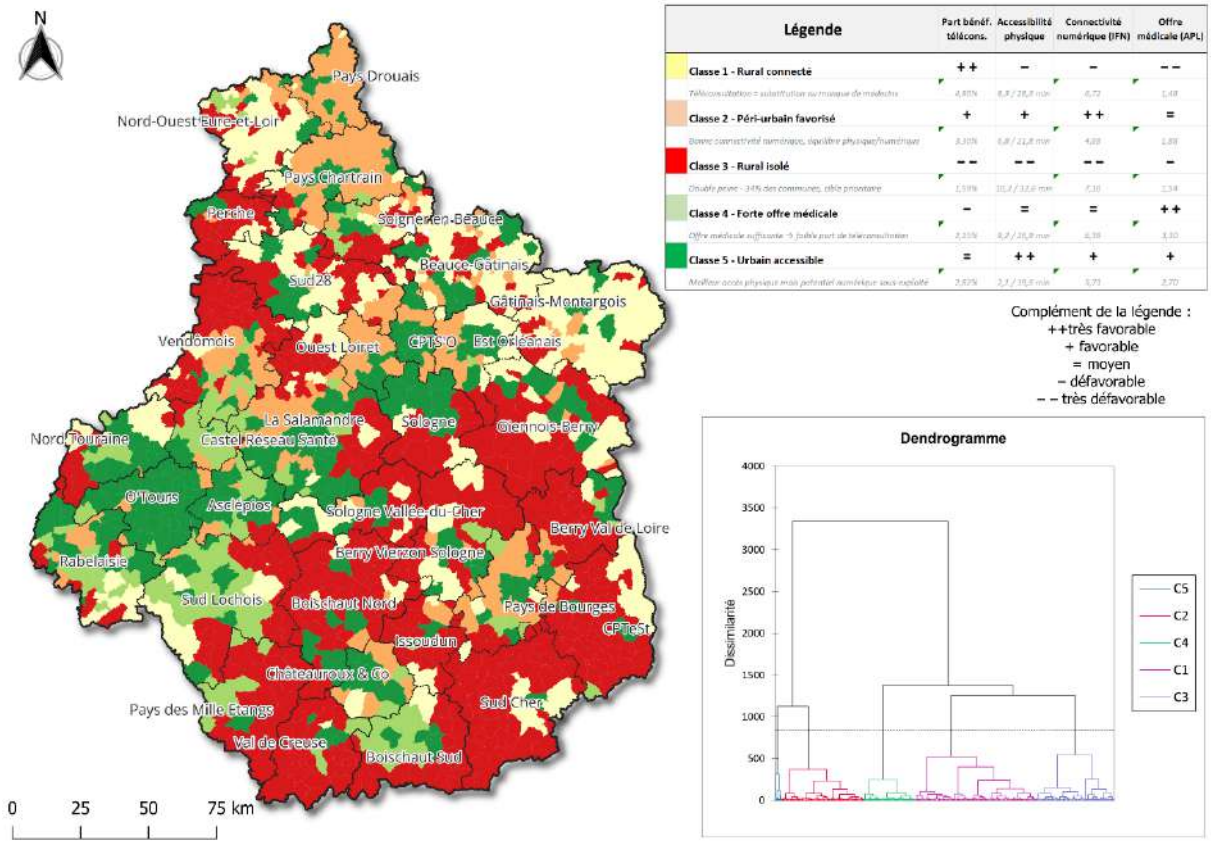
La distribution spatiale du répertoire révèle des déséquilibres considérables. Les points se concentrent le long de l'axe ligérien, de Tours à Orléans, et dans les couronnes des principales agglomérations, tandis que des ensembles entiers apparaissent dépourvus de toute référence : le sud de l'Indre, le sud du Cher, le Berry Val de Loire, la Sologne intérieure et le Nord-Ouest de l'Eure-et-Loir. Il serait erroné d'en conclure à l'absence de professionnels dans ces territoires ; il est en revanche fondé d'en conclure que l'information relative à l'accessibilité y fait défaut, ce qui constitue en soi un axe de travail pour les délégués de l'assurance maladie, dont la fiche action prévoit explicitement la sensibilisation des professionnels au répertoire.

Le répertoire compte 315 professionnels, dont 225 exercent en Centre-Val de Loire et 90 dans les départements limitrophes, ces derniers étant retenus dès lors qu'ils se situent à moins de 15 km de la limite régionale. Cette prise en compte traduit une réalité fonctionnelle des espaces frontaliers, où le recours aux soins ignore les limites administratives : l'analyse départementale montrera que plusieurs assurés du sud du Cher sont rattachés à Boussac, dans la Creuse, et que des assurés de l'est du Loiret le sont à Nemours, en Seine-et-Marne.

Chapitre 6. Une typologie territoriale des usages et des contraintes

Les chapitres précédents ont caractérisé le territoire indicateur par indicateur. Une approche multivariée permet de dépasser cette juxtaposition et d'identifier des profils territoriaux cohérents, c'est-à-dire des combinaisons récurrentes de caractéristiques dont chacune définit un problème d'action publique distinct et appelle donc une réponse différenciée.

Figure 3 : Typologie communale issue de la classification ascendante hiérarchique, Centre-Val de Loire



Sources : SNIIRAM 2024/2025 ; INSEE RP 2022 ; FiLoSoFi 2021

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

Tableau 3 : Caractérisation des cinq classes de la typologie communale

Classe	Part de bénéficiaires de téléconsultation	Accessibilité physique	Offre médicale (APL)	Interprétation
1 : rural connecté	++ (4,80 %)	− (8,3 km / 28,6 min)	− − (1,48)	La téléconsultation fonctionne comme substitution au manque de médecins
2 : péri-urbain favorisé	+ (3,30 %)	+ (6,8 km / 21,8 min)	= (1,88)	Équilibre entre accès physique et recours à distance
3 : rural isolé	− − (1,59 %)	− − (10,3 km / 32,6 min)	− (1,54)	Cumul des contraintes ; 34 % des communes ; cible prioritaire du dispositif
4 : forte offre médicale	− (2,15 %)	= (9,2 km / 26,9 min)	++ (3,30)	Offre médicale suffisante, d'où une faible part de téléconsultation
5 : urbain accessible	= (2,82 %)	++ (2,1 km / 19,6 min)	+ (2,70)	Meilleur accès physique mais potentiel numérique sous-exploité

Source : SNIIRAM 2024/2025 ; INSEE RP 2022 ; FiLoSoFi 2021

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

La classe 3, dite du rural isolé, concentre l'ensemble des difficultés : la part la plus faible de bénéficiaires de téléconsultation, à 1,59 %, l'accessibilité physique la plus dégradée avec 10,3 km et 32,6 minutes en moyenne et une offre médicale déficitaire à 1,54. Elle regroupe 34 % des communes régionales et constitue la cible prioritaire du dispositif. Sa distribution spatiale, visible en rouge sur la carte, recouvre très exactement les espaces identifiés aux paragraphes précédents : Sologne, sud et est du Cher, ensemble de l'Indre à l'exception de l'agglomération castelroussine, Perche et Thymerais, marges gâtinaises et giennoises du Loiret.

La classe 1, dite du rural connecté, présente une configuration paradoxale : elle affiche la part de bénéficiaires de téléconsultation la plus élevée de la région, à 4,80 %, alors même que son offre médicale est la plus déficitaire, à 1,48. Cette configuration relève d'un mécanisme de substitution, puisque c'est parce que le médecin manque que la téléconsultation s'y développe, et démontre que l'appropriation demeure possible dans des territoires ruraux lorsque le besoin est suffisamment pressant, ce qui constitue un argument favorable au déploiement du dispositif. Sa distribution spatiale[16] correspond principalement au Loiret et à la Beauce.

La classe 5, dite de l'urbain accessible, présente la configuration symétrique : le meilleur accès physique et une offre correcte, mais une part de téléconsultation au niveau de la moyenne régionale. Le potentiel de recours à distance y est sous-exploité, ce qui n'appelle pas nécessairement une intervention puisque l'accès physique y constitue une alternative satisfaisante. La classe 4 confirme cette logique : l'accessibilité potentielle localisée y atteint 3,30, la meilleure de la région, et la faible part de téléconsultation y traduit non pas un défaut d'appropriation mais l'absence de besoin.

Ces quatre observations convergent vers une proposition centrale pour l'action publique : le recours à la téléconsultation n'est pas déterminé par la seule qualité de la connectivité, ni par le seul déficit d'offre, mais par leur combinaison. Lorsque le déficit d'offre est fort et la connectivité moyenne, la substitution s'opère spontanément : c'est la classe 1. Lorsque le déficit d'offre est fort et la connectivité très dégradée, la substitution ne s'opère pas : c'est la classe 3. C'est donc exactement dans cette dernière configuration que l'intervention institutionnelle trouve sa justification, puisque le marché, si l'on peut employer ce terme, n'y produit pas spontanément la réponse.

[16] Un mécanisme analogue a été observé pendant la pandémie de Covid-19 : parmi 10 000 répondants au dispositif de suivi à distance Covidom, 40 % déclaraient qu'en l'absence de l'application ils se seraient rendus à l'hôpital (Or et Parry, 2026)

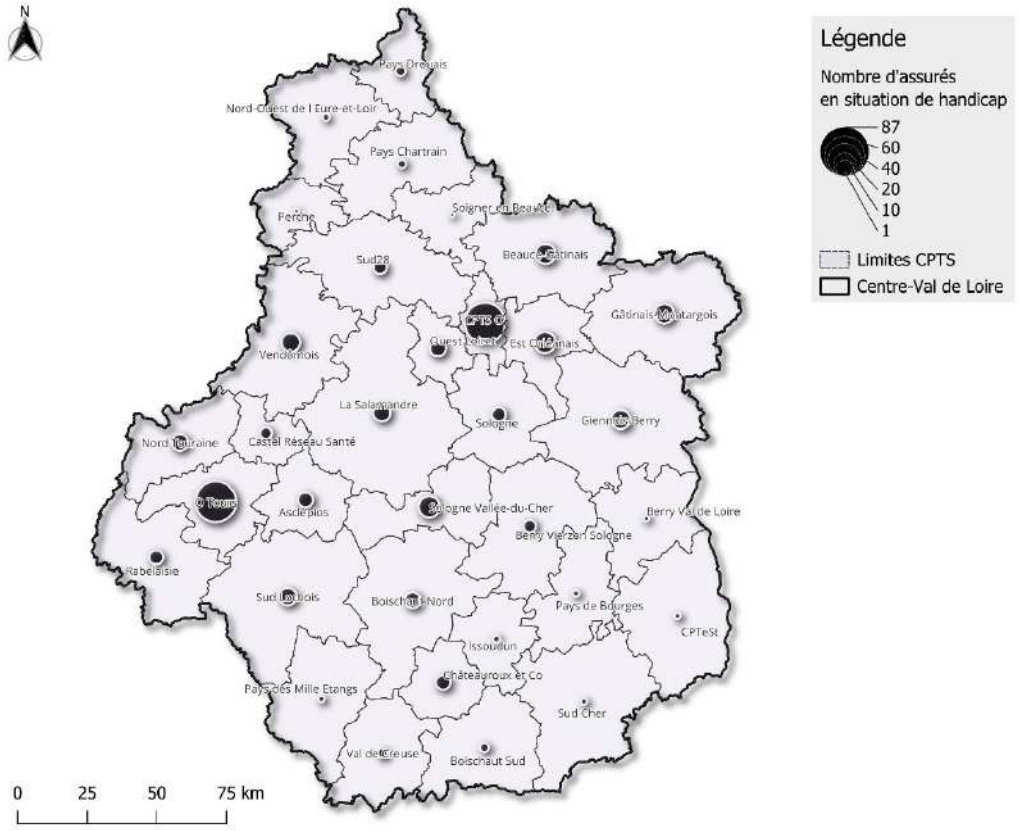
Chapitre 7. Le public cible : localisation, structure et caractérisation

Les deux chapitres précédents ont caractérisé le territoire. Il reste à y situer la population concernée, c'est-à-dire à confronter la géographie des contraintes à celle des personnes qui les subissent. Cette confrontation constitue le passage du diagnostic général au ciblage opérationnel.

7.1. Une population de 535 assurés géolocalisés

Le repérage aboutit à 535 assurés géolocalisés dans les 6 départements de la région, répartis dans 246 communes distinctes. Cet effectif, rapporté aux 2 581 285 habitants couverts par les CPTS, correspond à 2,07 assurés pour 10 000 habitants. Il ne s'agit donc pas de mesurer la fréquence du handicap moteur dans la population. L'objectif est plutôt d'identifier une situation de rupture dans le parcours de soins, caractérisée par le cumul de trois éléments : la présence d'un handicap moteur, l'absence de médecin traitant et l'absence de consommation de soins.

Figure 4 : Nombre d'assurés en situation de handicap sans médecin traitant par communauté professionnelle territoriale de santé



Source : SIAM ERASME 2025

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

Cette carte est essentielle au ciblage de l'action, puisqu'elle situe le public repéré dans l'armature territoriale décrite jusqu'ici. La représentation par cercles proportionnels fait apparaître une concentration très marquée sur un petit nombre de CPTS. La CPTS'O, avec 87 assurés, constitue le plus important, suivi du Pays de Bourges avec 60, de Châteauroux & Co avec 51, du Pays Chartrain avec 43 et du Gâtinais-Montargois avec 41. A l'opposé, 7 CPTS ne comptent qu'un ou 2 assurés. Les 6 premières CPTS rassemblent à elles seules 317 des 535 assurés, soit 59 %.

Cette concentration urbaine peut surprendre dans une étude consacrée à l'accès aux soins en milieu rural et appelle une interprétation prudente. Trois mécanismes concourent à l'expliquer : un effet de taille dominant, la corrélation entre l'effectif repéré et la population du territoire s'établissant à 0,714 ; un biais méthodologique, une part des adresses urbaines correspondant à des boîtes postales géocodées au centroïde communal ; et un facteur substantiel, les situations de rupture de soins n'étant nullement l'apanage du rural, l'isolement social en milieu urbain constituant une réalité que le raisonnement territorial classique tend à sous-estimer.

Le rapport à la population corrige partiellement cet effet de taille. Rapporté à 10 000 habitants, l'effectif atteint 6,93 à Châteauroux & Co, 4,84 au Pays de Bourges, 3,83 dans le Sud Cher, 3,71 au Pays des Mille Etangs et 3,69 en Sologne Vallée-du-Cher, contre 0,85 sur le territoire tourangeau et 0,33 en Sologne. Le classement se recompose donc sensiblement, faisant remonter des territoires ruraux et vieillissants de l'Indre et du Cher, et confirmant que l'intensité du phénomène, distincte de son volume, suit bien la géographie de la vulnérabilité établie aux chapitres précédents.

7.2. Recours à la téléconsultation et présence du public cible : une relation inverse

Le rapprochement entre l'intensité du public cible et le taux de recours à la téléconsultation produit l'un des résultats les plus significatifs de ce diagnostic. Le coefficient de corrélation entre le nombre d'assurés repérés pour 10 000 habitants et le taux de recours à la téléconsultation s'établit à -0,35. La relation est donc négative : les territoires où la concentration du public cible est la plus forte sont ceux où la téléconsultation est la moins pratiquée.

Ce résultat pourrait être lu à tort comme une réfutation de l'hypothèse du dispositif ; il en constitue au contraire la justification. Si la téléconsultation se développait spontanément là où le public vulnérable est concentré, l'intervention institutionnelle serait superflue. C'est parce que la diffusion spontanée de l'outil suit une géographie inverse de celle du besoin qu'un dispositif d'aller-vers, associant repérage actif et accompagnement humain, trouve sa raison

d'être. On retrouve ici, transposée au champ numérique, la loi inverse des soins formulée par Julian Tudor Hart en 1971, selon laquelle la disponibilité de soins de qualité tend à varier inversement au besoin de la population desservie (Tudor Hart, 1971)[17].

La Rabelaisie affiche le taux de recours le plus élevé de la région, à 7,59 %, pour seulement 4 assurés repérés, soit 0,59 pour 10 000 habitants : la téléconsultation y est massivement pratiquée par une population qui n'est pas celle du dispositif. Châteauroux & Co présente la configuration exactement inverse, avec le taux de recours le plus faible de la région à 0,32 % et la concentration de public cible la plus élevée à 6,93 pour 10 000. Le Boischaut Nord, le Pays des Mille Etangs et Berry Vierzon Sologne se rangent dans la même catégorie, associant un recours inférieur à 0,7 % et une concentration supérieure à la moyenne régionale.

Ces 4 territoires, Châteauroux & Co, Boischaut Nord, Pays des Mille Etangs et Berry Vierzon Sologne, constituent, au terme de ce croisement, les territoires de priorité maximale : le public cible y est proportionnellement le plus nombreux et l'outil y est le moins diffusé, de sorte que le bénéfice marginal attendu d'un accompagnement institutionnel y est le plus élevé. On notera que 3 d'entre eux relèvent de l'Indre et du Cher, confirmant la convergence des diagnostics établis par des voies indépendantes.

Un dernier résultat mérite d'être relevé : la corrélation entre la part des 65 ans et plus et le taux de recours à la téléconsultation est nulle, à 0,014. Le vieillissement d'un territoire ne détermine donc ni positivement ni négativement l'appropriation de la téléconsultation. Ce résultat contredit l'idée reçue selon laquelle les personnes âgées seraient réfractaires à la télémédecine, et suggère que les déterminants de l'usage relèvent davantage de l'organisation de l'offre locale que des caractéristiques de la population[18].

[17] « *The availability of good medical care tends to vary inversely with the need for it in the population served* », *The Lancet*, 1971. La proposition, formulée à propos de l'offre médicale britannique, s'applique ici à la diffusion d'un outil et non à l'implantation de professionnels.

[18] Le mémoire de master 1 conduit l'année précédente aboutissait à un constat convergent à l'échelle des CPTS, en montrant que l'appropriation de la téléconsultation était adossée au niveau de vie et à l'organisation locale plutôt qu'à la structure d'âge (Ndoye, 2025).

QUATRIÈME PARTIE

LA MOBILITÉ COMME RÉVÉLATEUR : MESURE DE LA CONTRAINTE ET CONDITIONS DE FAISABILITÉ

Chapitre 8. L'accès routier : une contrainte apparemment modérée

Les indicateurs d'accessibilité mobilisés dans la troisième partie caractérisent des territoires et non des personnes. Ils supposent une population moyenne, dotée d'une mobilité moyenne, alors que le public visé se définit précisément par une mobilité empêchée. C'est très exactement la limite que la littérature récente sur les indicateurs d'accessibilité identifie lorsqu'elle propose d'intégrer les pratiques de déplacement différenciées selon les espaces et les caractéristiques sociales des populations (Lucas-Gabrielli et al., 2025). Ce chapitre inaugure donc un changement d'échelle décisif : la mesure ne porte plus sur des communes mais sur les 535 itinéraires individuels calculés depuis l'adresse géolocalisée de chaque assuré vers le cabinet accessible le plus proche. L'enjeu en est directement opérationnel, puisque c'est cette mesure qui détermine si un démarchage vers un praticien de proximité a des chances d'aboutir.

8.1. La distribution régionale des temps de trajet routiers

Le temps de trajet routier moyen s'établit à 14,6 minutes et le temps médian à 11,2 minutes, pour une distance moyenne parcourue de 11,5 km. Ces valeurs, prises isolément, décrivent une situation d'accessibilité satisfaisante : la moitié des assurés se situent à moins d'un quart d'heure de route d'un cabinet accessible. La distribution révèle cependant une dispersion considérable, le maximum atteignant 62,4 minutes.

Tableau 4 : Distribution des temps de trajet routiers vers le cabinet accessible le plus proche

Classe de temps	Effectif	Part (%)	Cumul (%)
Moins de 5 minutes	74	13,8	13,8
De 5 à 10 minutes	171	32,0	45,8
De 10 à 15 minutes	83	15,5	61,3
De 15 à 25 minutes	116	21,7	83,0
De 25 à 35 minutes	50	9,3	92,3
De 35 à 50 minutes	38	7,1	99,4
50 minutes et plus	3	0,6	100,0
Ensemble	**535**	**100,0**	

Source : Santé.fr 2026, annuaire de l'accessibilité des cabinets

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

La lecture cumulée établit que 61,3 % des assurés se situent à moins de 15 minutes, 83 % à moins de 25 minutes, mais que 90 d'entre eux, soit 16,8 %, dépassent ce dernier seuil, et que

Page retirée de la version publique

Elle présentait la figure 5, une carte qui localise les assurés en situation de handicap de la région, d'après des données de l'Assurance Maladie, ainsi que le texte qui l'entourait.

Elle est retirée pour protéger ces personnes. Hors des passages signalés ainsi, le mémoire est identique à la version soutenue.

Page 44 de la version originale

du Loiret. Ce sont ces situations isolées, statistiquement minoritaires mais qualitativement décisives, qui constituent l'objet de l'action[19].

8.2. La ventilation départementale

Tableau 5 : Temps de trajet routiers vers le cabinet accessible le plus proche, par département

Département	Effectif	Temps moyen (min)	Temps médian (min)	Temps max. (min)	Distance moyenne (km)	> 15 min (n)	> 25 min (n)	> 25 min (%)
Cher (18)	102	14,1	8,8	62,4	11,5	33	19	18,6
Eure-et-Loir (28)	77	13,4	9,8	35,5	11,6	32	10	13,0
Indre (36)	82	18,0	15,6	54,0	15,1	52	13	15,9
Indre-et-Loire (37)	50	10,4	8,3	37,6	6,3	11	3	6,0
Loir-et-Cher (41)	66	12,2	10,0	39,1	8,4	17	5	7,6
Loiret (45)	158	16,1	9,0	50,1	12,5	61	40	25,3
Centre-Val de Loire	**535**	**14,6**	**11,2**	**62,4**	**11,5**	**206**	**90**	**16,8**

Source : Santé.fr 2026, annuaire de l'accessibilité des cabinets

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

Trois configurations se distinguent nettement. L'Indre présente les valeurs centrales les plus élevées, avec 18,0 minutes de moyenne et surtout 15,6 minutes de médiane, ce qui signifie que la difficulté y est diffuse et non concentrée sur quelques cas extrêmes : la moitié des assurés de ce département se situe au-delà d'un quart d'heure de route. Le Loiret présente au contraire une médiane basse à 9,0 minutes mais la proportion de trajets excédant 25 minutes la plus élevée de la région à 25,3 %, configuration caractéristique d'un département polarisé, où une majorité d'assurés bénéficie de la proximité orléanaise tandis qu'une minorité importante réside dans les marges gâtinaises et pithiveraines. Le Cher présente un profil comparable, avec une médiane de 8,8 minutes et un maximum de 62,4 minutes, l'écart le plus important de la région.

L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher constituent à l'inverse les départements les plus favorisés, avec respectivement 6,0 % et 7,6 % de trajets excédant 25 minutes. L'Eure-et-Loir occupe une position intermédiaire, avec une médiane relativement élevée à 9,8 minutes mais un maximum modéré à 35,5 minutes, ce qui traduit une contrainte homogène et jamais extrême.

8.3. Une accessibilité routière trompeuse

Le constat qui se dégage de ce chapitre est celui d'une accessibilité routière globalement satisfaisante : plus de 6 assurés sur 10 se situent à moins d'un quart d'heure de route, et l'immense majorité à moins d'une demi-heure. Ce constat conforte le choix de faire du démarchage de proximité le levier premier de l'action : dans la grande majorité des cas, un praticien existe à distance raisonnable, et la question posée est celle de sa disponibilité bien plus

[19] Ce point rejoint une propriété générale des indicateurs agrégés : la moyenne d'un territoire ne dit rien de la situation des individus qui s'en écartent le plus, or ce sont ces derniers que vise une politique d'aller-vers.

que celle de son éloignement. Il repose cependant sur une hypothèse implicite dont la fausseté constitue l'argument central de ce mémoire : celle selon laquelle le public concerné dispose d'un véhicule et de la capacité de le conduire.

Or cette hypothèse est précisément celle que la définition du public cible invalide. Il s'agit de personnes vivant avec un handicap moteur dont l'intensité a justifié le remboursement de matériel spécifique, et de seniors isolés en milieu rural. Pour une part significative d'entre elles, la conduite automobile est impossible, et le déplacement dépend donc soit d'un tiers aidant, soit du transport collectif, soit d'un transport sanitaire prescrit. L'isochrone routier, qui constitue l'outil standard de mesure de l'accessibilité aux soins, décrit donc pour cette population une accessibilité virtuelle. Le chapitre suivant substitue à cette mesure celle du mode de déplacement effectivement mobilisable : il ne remet pas en cause la pertinence du démarchage, mais il en conditionne l'efficacité à la résolution préalable d'un problème de transport. Cette réserve rejoint les enseignements des enquêtes qualitatives conduites auprès de patients contraints à de longs déplacements pour accéder à une expertise médicale. La distance y est le plus souvent acceptée au regard de la gravité de la maladie, mais elle est absorbée par des stratégies d'adaptation dont le coût n'apparaît dans aucun indicateur d'accessibilité, et elle devient nettement plus contraignante pour les personnes qui ne disposent ni des ressources ni des appuis nécessaires pour la surmonter, au point de produire des inégalités sociales et spatiales de santé (Chasles et al., 2018). Une accessibilité exprimée en minutes de voiture ne renseigne donc pas sur la charge réellement supportée par la personne.

Chapitre 9. L'accès en transport en commun : le renversement du diagnostic

Le calcul d'itinéraires en transport collectif a été conduit pour les mêmes 535 assurés et vers le même ensemble de cabinets accessibles. Il restitue, outre la durée du trajet, la distance de marche nécessaire pour rejoindre et quitter les arrêts, le nombre de correspondances et les modes empruntés. Trois statuts sont distingués : un itinéraire trouvé, l'absence de tout itinéraire atteignable et un itinéraire non praticable en raison d'une durée excédant 90 minutes.

9.1. Un tiers du public sans solution de transport collectif

Tableau 6 : Desserte en transport en commun du public cible, par département

Département	Effectif	Itinéraire trouvé	Aucun itinéraire atteignable	Itinéraire non praticable (> 90 min)	Sans solution (n)	Sans solution (%)
Cher (18)	102	74	28	0	28	27,5
Eure-et-Loir (28)	77	50	27	0	27	35,1
Indre (36)	82	62	18	2	20	24,4
Indre-et-Loire (37)	50	34	13	3	16	32,0
Loir-et-Cher (41)	66	37	26	3	29	43,9
Loiret (45)	158	98	40	20	60	38,0
Centre-Val de Loire	**535**	**355**	**152**	**28**	**180**	**33,6**

Source : SIAM ERASME 2025

Réalisation : Gora NDOYE ; 2026

Le résultat central de ce tableau est le suivant : 180 assurés sur 535, soit 33,6 %, ne disposent d'aucune solution de transport collectif praticable pour rejoindre un cabinet accessible. Un tiers du public cible se trouve donc, en l'absence de véhicule personnel ou d'aidant disponible, dans l'impossibilité matérielle de rejoindre un médecin, quelle que soit par ailleurs la qualité de l'accessibilité routière mesurée précédemment. Il importe de mesurer la portée de ce constat pour la conduite de l'action : il ne signifie pas qu'aucun praticien n'est disponible à proximité, mais que le démarchage, s'il aboutit, restera lettre morte tant qu'une solution de déplacement n'aura pas été trouvée.

La distinction entre les deux modalités de l'absence de solution est riche d'enseignements. Pour 152 assurés, aucun itinéraire n'est atteignable : il n'existe pas de service reliant leur lieu de résidence à un cabinet, ou les arrêts existants sont hors de portée de marche. Pour 28 autres, un itinéraire existe mais sa durée excède 90 minutes ; ces situations, dont 20 se concentrent dans le Loiret, relèvent non d'un défaut d'infrastructure mais d'une inadaptation de l'infrastructure

existante, le réseau étant conçu pour des flux pendulaires vers le pôle et non pour des déplacements transversaux vers les équipements de proximité[20].

La géographie de ce déficit contredit l'intuition. Le Loir-et-Cher, département de taille moyenne et de contrainte routière modérée, présente le taux le plus élevé de la région avec 43,9 % d'assurés sans solution. Le Loiret, département le plus peuplé et le mieux équipé en réseaux urbains, arrive en deuxième position avec 38 %, et l'Eure-et-Loir, sous influence francilienne, en troisième avec 35,1 %. L'Indre, département le plus contraint pour l'accès routier, présente en revanche le taux le plus faible avec 24,4 %. Ce paradoxe apparent s'explique par la structure de peuplement : l'Indre concentre son public cible dans l'agglomération de Châteauroux, correctement desservie, tandis que le Loir-et-Cher et le Loiret le dispersent dans des espaces périurbains et solognots où le réseau collectif est inexistant.

Ce constat invite à réviser un présupposé courant de l'analyse des inégalités d'accès aux soins : le déficit de transport collectif n'est pas une caractéristique du rural profond, mais des espaces intermédiaires, périurbains et rurbains, trop peu denses pour justifier une desserte régulière et trop peu dotés pour disposer d'équipements de proximité. C'est précisément dans ces espaces que se joue l'essentiel de la contrainte mesurée.

9.2. Une durée de déplacement multipliée par 2,7

Pour les 355 assurés disposant d'un itinéraire, la comparaison directe avec le trajet routier permet de quantifier le surcoût temporel du transport collectif.

Tableau 7 : Ecart entre les temps de trajet routier et en transport en commun (trajets comparables)

Département	Trajets comparables	Voiture (min)	Transport en commun (min)	Ecart moyen (min)	Ratio médian TC / voiture	Marche à pied moyenne (m)
Cher (18)	74	9,6	28,2	18,6	3,27	1 065
Eure-et-Loir (28)	50	10,4	26,4	16,0	2,65	939
Indre (36)	62	15,8	37,6	21,8	2,23	1 418
Indre-et-Loire (37)	34	8,2	27,1	18,9	2,88	1 232
Loir-et-Cher (41)	37	8,9	36,9	28,0	2,80	1 163
Loiret (45)	98	7,8	23,9	16,1	2,60	783
Centre-Val de Loire	**355**	**10,1**	**29,2**	**19,1**	**2,66**	**1 057**

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

Le temps de trajet moyen en transport en commun atteint 29,2 minutes contre 10,1 minutes en voiture pour les mêmes trajets, soit un écart de 19,1 minutes et un ratio médian de 2,66. Dans 78,6 % des cas, le trajet en transport collectif dure plus du double du trajet routier. Le troisième

[20] Cette distinction entre absence d'infrastructure et inadaptation de l'infrastructure existante est décisive pour l'action publique : la première appelle une création de service, la seconde une adaptation d'horaires ou un service de transport à la demande.

quartile du ratio s'établit à 3,8, ce qui signifie qu'un quart des assurés desservis subissent un allongement de plus de 280 %.

La colonne relative à la marche à pied introduit une dimension supplémentaire, décisive pour un public à mobilité réduite. La distance de marche moyenne nécessaire pour rejoindre et quitter les arrêts s'établit à 1 057 mètres, avec un maximum de 4 025 mètres. Dans 42,8 % des cas, elle excède 1 km ; dans 11,8 % des cas, elle excède 2 km. Cette donnée modifie radicalement l'interprétation des durées : un itinéraire de 30 minutes comportant 1,5 km de marche n'est pas un itinéraire de 30 minutes pour une personne dont la mobilité pédestre est limitée ; il est un itinéraire impraticable. Il en résulte que le taux de 33,6 % d'assurés sans solution constitue une estimation basse, et que la proportion réelle de personnes dans l'impossibilité d'utiliser le transport collectif est vraisemblablement très supérieure[21].

En ajoutant aux 180 assurés dépourvus de solution les 78 itinéraires exigeant plus de 1 500 mètres de marche, le nombre d'assurés pour lesquels le transport en commun ne constitue pas une réponse praticable s'élève à 258 sur 535, soit 48,2 %. Près d'un assuré sur deux se trouve ainsi, en l'absence de véhicule personnel ou d'aidant disponible, dans l'impossibilité pratique de rejoindre un cabinet médical accessible.

L'Indre présente à cet égard la situation la plus critique, avec une marche moyenne de 1 418 mètres et une durée moyenne de 37,6 minutes, malgré le ratio le plus faible de la région. Ce résultat s'explique par la longueur du trajet routier de référence, déjà élevée dans ce département : l'allongement relatif y est modéré parce que le point de départ était déjà dégradé. Le Loir-et-Cher présente l'écart absolu le plus élevé, avec 28 minutes de surcoût moyen, ce qui, combiné à son taux record de 43,9 % d'assurés sans solution, en fait le département où la dépendance au véhicule personnel est la plus totale.

9.3. Structure des itinéraires : un réseau conçu pour d'autres usages

L'examen de la structure des itinéraires éclaire les raisons de cette inadaptation. Sur les 355 trajets aboutis, 308 s'effectuent sans correspondance, 42 avec une et 5 avec deux. Cette quasi-absence de correspondance ne traduit pas la performance du réseau mais sa configuration en étoile : les itinéraires possibles sont ceux qui empruntent une ligne unique convergeant vers un pôle, et les déplacements nécessitant une combinaison de lignes sont, dans leur immense majorité, impossibles et comptabilisés comme absence d'itinéraire. Les modes empruntés confirment cette lecture, les lignes urbaines des agglomérations d'Orléans, de Tours, de

[21] La marche à pied constitue le maillon le plus souvent ignoré des mesures d'accessibilité aux soins, alors qu'elle conditionne l'usage effectif du transport collectif pour les personnes à mobilité réduite.

Bourges et de Chartres constituant l'essentiel de l'offre mobilisée : le transport collectif régional, structuré pour assurer les migrations domicile-travail aux heures de pointe, n'offre pas la desserte fine et la souplesse horaire que requiert un déplacement de soins.

9.4. Une segmentation opérationnelle du public cible

La confrontation des deux modes de déplacement produit le résultat central de ce mémoire : mesurée par l'isochrone routier, la contrainte d'accès apparaît modérée, puisque 83 % des assurés se situent à moins de 25 minutes d'un cabinet accessible, mais elle devient prohibitive dès lors qu'on retient le mode de déplacement effectivement mobilisable. Ces mesures ne prennent toutefois leur sens opérationnel qu'une fois rapportées à la question qui commande l'action : pour quels assurés le démarchage vers un médecin de proximité constitue-t-il une voie praticable, et pour quels autres faut-il envisager le levier subsidiaire ? Le croisement des deux modes permet de répondre individu par individu et de partager les 535 assurés repérés en trois niveaux d'intervention.

Le premier niveau réunit les assurés pour lesquels un cabinet accessible se situe à moins de 25 minutes de route et qui disposent en outre d'un itinéraire en transport collectif praticable exigeant moins d'1 km de marche. Pour eux, la solution de proximité est atteignable quelle que soit leur situation de mobilité, et le démarchage peut être engagé sans condition préalable. Le deuxième niveau réunit ceux pour lesquels le cabinet demeure à distance raisonnable par la route mais qui ne disposent d'aucune solution collective praticable : le médecin existe à portée, mais l'accès suppose un aidant, un transport adapté ou un transport sanitaire prescrit. Le démarchage y reste pertinent, à condition d'être assorti d'une solution de déplacement. Le troisième niveau réunit enfin ceux dont le cabinet accessible le plus proche excède 25 minutes de route : c'est le sous-ensemble pour lequel aucune solution de proximité n'existe et pour lequel la téléconsultation assistée constitue le levier subsidiaire.

Tableau 8 : Segmentation du public cible selon l'accessibilité d'une solution de proximité

Niveau d'intervention	Effectif	Part (%)	Temps de trajet routier médian (min)	Distance routière médiane (km)	Assurés disposant d'un infirmier référencé à moins de 8 km
Niveau 1 : proximité effective	202	37,8	6,3	2,6	109 (54 %)
Niveau 2 : proximité sous condition de mobilité	243	45,4	14,4	10,5	102 (42 %)
Niveau 3 : absence de solution de proximité	90	16,8	33,2	30,2	32 (36 %)
Ensemble	**535**	**100,0**	**11,2**	**7,4**	**243 (45 %)**

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

La distribution obtenue infirme deux lectures opposées et également répandues. Elle infirme d'abord l'idée que le public repéré serait massivement enclavé : pour 445 assurés sur 535, soit

83 %, un cabinet accessible se situe à moins de 25 minutes de route, et le démarchage de proximité constitue donc la réponse pertinente. Elle infirme ensuite l'idée symétrique selon laquelle la proximité suffirait : seuls 202 assurés, soit 37,8 %, cumulent cette proximité et une solution de déplacement praticable sans automobile, tandis que 243, soit 45,4 %, se trouvent dans une situation intermédiaire où le médecin est proche mais l'accès incertain. Cette situation intermédiaire, qui concerne près d'un assuré sur deux, constitue le principal enjeu opérationnel de l'action : elle n'appelle ni le renoncement au démarchage ni le basculement immédiat vers la téléconsultation, mais l'adjonction d'une solution de transport au travail d'orientation.

Le détail du niveau 2 précise la nature de l'obstacle : sur les 243 assurés concernés, 105 ne disposent d'aucun itinéraire en transport collectif praticable et 138 en disposent d'un mais au prix de plus d'1 km de marche. La seconde catégorie relève d'une correction accessible, puisqu'un transport à la demande ou un accompagnement ponctuel suffit à lever l'obstacle ; la première appelle une solution de transport à part entière.

Tableau 9 : Répartition départementale des trois niveaux d'intervention

Département	Niveau 1 (n)	Niveau 2 (n)	Niveau 3 (n)	Niveau 1 (%)	Niveau 2 (%)	Niveau 3 (%)
Cher (18)	45	38	19	44,1	37,3	18,6
Eure-et-Loir (28)	31	36	10	40,3	46,8	13,0
Indre (36)	10	59	13	12,2	72,0	15,9
Indre-et-Loire (37)	16	31	3	32,0	62,0	6,0
Loir-et-Cher (41)	20	41	5	30,3	62,1	7,6
Loiret (45)	80	38	40	50,6	24,1	25,3
Centre-Val de Loire	**202**	**243**	**90**	**37,8**	**45,4**	**16,8**

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

La ventilation départementale fait apparaître trois profils distincts, qui commandent trois stratégies différentes. L'Indre présente la configuration la plus homogène et la plus singulière, avec 72 % de son public au niveau 2 : le médecin y est presque toujours accessible par la route, mais presque jamais autrement, de sorte que la question posée n'y est pas celle de l'existence d'une offre mais celle du transport. Le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire présentent un profil voisin, avec respectivement 62,1 % et 62,0 % au niveau 2. Le Loiret occupe une position opposée, avec la part de niveau 1 la plus élevée de la région, à 50,6 %, mais aussi la part de niveau 3 la plus élevée, à 25,3 % : département polarisé, il combine une majorité d'assurés pour lesquels le démarchage est immédiatement praticable et un quart pour lesquels aucune solution de proximité n'existe. Le Cher enfin présente une distribution relativement équilibrée entre les trois niveaux.

La dernière colonne du premier tableau introduit toutefois une difficulté que le chapitre suivant développe : la disponibilité de l'infirmier référencé, condition de faisabilité du levier

subsidiaire, décroît précisément à mesure que l'on progresse vers les niveaux où ce levier devient nécessaire. Elle atteint 54 % au niveau 1, où elle est superflue, et tombe à 36 % au niveau 3, où elle est indispensable.

Chapitre 10. Les conditions de faisabilité : accompagnant de proximité et accessibilité des lieux de soins

Le chapitre précédent a établi qu'un assuré sur 6 ne dispose d'aucune solution de proximité et relève donc du levier subsidiaire. Encore faut-il que ce levier soit réalisable. Or la téléconsultation assistée repose entièrement sur la présence d'un tiers professionnel auprès du patient, sans lequel elle se réduit à une téléconsultation ordinaire, modalité que l'équipement et les compétences numériques du public rendent souvent inopérante. La disponibilité de ce tiers constitue donc la condition de faisabilité première du second temps de l'action, et son examen s'impose avant toute considération relative au déploiement.

10.1. L'infirmier libéral, pivot naturel du dispositif

Trois raisons désignent l'infirmier libéral comme le professionnel accompagnant privilégié. La première est réglementaire : l'avenant 9 l'autorise expressément à assister un patient lors d'une téléconsultation, sans prescription médicale préalable, et valorise cet acte selon une gradation qui privilégie l'intervention à domicile. La deuxième est organisationnelle : il se déplace déjà quotidiennement au domicile des patients dépendants, de sorte que l'accompagnement peut s'insérer dans une tournée existante. La troisième est relationnelle : il est fréquemment le seul professionnel en contact régulier avec les personnes dépendantes, et cette antériorité constitue un atout décisif pour l'acceptation du dispositif par des personnes en rupture avec le système de soins[22]. Cette centralité fait du maillage infirmier un point de vulnérabilité : là où l'infirmier manque, la téléconsultation assistée ne peut être organisée, quelle que soit la qualité de la connexion. La France compte près de 637 000 infirmiers en exercice et une densité de 8,8 pour 1 000 habitants en 2022, supérieure à la moyenne de l'Union européenne ; cette densité pourrait croître de 37 % d'ici à 2050 sans pour autant suffire à absorber la hausse de demande liée au vieillissement (Bellamy, 2024; Or & Parry, 2026).

10.2. Une couverture régionale partielle et très inégale

Le calcul d'itinéraires vers l'infirmier le plus proche, avec un rayon de recherche limité à 8 km, aboutit à 243 trajets sur les 535 assurés, soit un taux de couverture de 45,4 %.

Tableau 10 : Couverture du public cible par un infirmier référencé accessible situé à moins de 8 km

Département	Assurés cibles	Assurés couverts	Taux de couverture (%)	Temps moyen vers l'infirmier (min)	Distance moyenne (km)	Temps moyen vers le médecin (min)
Cher (18)	102	22	21,6	10,1	5,0	12,2
Eure-et-Loir (28)	77	26	33,8	6,5	3,7	21,4

[22] Le rôle des réseaux relationnels dans le recours effectif aux soins constitue un résultat établi de la sociologie de l'accès aux soins (Roduit, 2020).

Département	Assurés cibles	Assurés couverts	Taux de couverture (%)	Temps moyen vers l'infirmier (min)	Distance moyenne (km)	Temps moyen vers le médecin (min)
Indre (36)	82	52	63,4	4,4	1,9	14,7
Indre-et-Loire (37)	50	33	66,0	6,9	2,9	8,6
Loir-et-Cher (41)	66	5	7,6	5,8	3,5	11,1
Loiret (45)	158	105	66,5	7,8	4,0	14,3
Centre-Val de Loire	**535**	**243**	**45,4**	**7,0**	**3,4**	**14,1**

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

Une précaution d'interprétation majeure s'impose. Le répertoire mobilisé ne recense que les professionnels ayant déclaré les caractéristiques d'accessibilité de leur local, soit 54 infirmiers en Centre-Val de Loire. Le taux de couverture de 45,4 % ne mesure donc pas la disponibilité d'un infirmier au sens de la démographie professionnelle, celle-ci étant bien supérieure, mais la disponibilité d'un infirmier dont l'accessibilité est documentée. Il constitue à ce titre un indicateur de la qualité de l'information disponible autant qu'un indicateur de l'offre, et sa valeur doit être lue comme une borne inférieure de la faisabilité réelle.

Le résultat le plus important de ce chapitre tient toutefois moins au niveau de ce taux qu'à sa distribution. Rapportée aux trois niveaux d'intervention établis précédemment, la couverture infirmière décroît en effet exactement à l'inverse du besoin : elle atteint 54 % parmi les assurés de niveau 1, pour lesquels le levier subsidiaire est superflu puisque le démarchage suffit, 42 % au niveau 2, et seulement 36 % au niveau 3, c'est-à-dire parmi les 90 assurés pour lesquels la téléconsultation assistée constitue l'unique réponse. Le constat prend une acuité particulière dans deux départements : sur les 13 assurés de niveau 3 de l'Indre et les 5 du Loir-et-Cher, aucun ne dispose d'un infirmier référencé à moins de 8 km. Autrement dit, là où le démarchage de proximité est hors de portée, le levier de substitution n'est pas davantage disponible en l'état. Sous cette réserve, les écarts départementaux sont considérables et porteurs d'enseignements. Le Loiret, l'Indre-et-Loire et l'Indre présentent des taux de couverture compris entre 63 et 67 %, tandis que le Loir-et-Cher n'atteint que 7,6 %, avec 5 assurés couverts sur 66. Ce dernier résultat s'explique directement par la composition du répertoire départemental, qui ne compte que 2 infirmiers référencés pour le Loir-et-Cher contre 14 en Indre-et-Loire et 13 dans le Loiret. Le Cher présente également un taux faible à 21,6 %.

Le cas de l'Indre mérite d'être souligné pour son caractère contre-intuitif. Département le plus contraint pour l'accès au médecin, il présente le meilleur temps d'accès à l'infirmier de la région, à 4,4 minutes et 1,9 km en moyenne, par l'effet de la concentration du public cible dans l'agglomération castelroussine. Il en résulte que la contrainte n'y est pas la disponibilité de l'accompagnant mais l'accès au médecin téléconsultant, ce qui désigne précisément la configuration où la téléconsultation assistée apporte la valeur ajoutée maximale.

Pour les 243 assurés couverts, le temps moyen d'accès à l'infirmier s'établit à 7,0 minutes, contre 14,1 minutes pour l'accès au médecin. Le gain moyen atteint donc 7,2 minutes, soit une réduction de moitié. Ce chiffre, pris isolément, pourrait sembler modeste. Sa portée réelle apparaît lorsqu'on considère que le déplacement pertinent n'est pas celui du patient vers l'infirmier mais celui de l'infirmier vers le patient : dans la configuration cible, correspondant à la cotation TLD, le patient ne se déplace pas du tout.

La distribution des temps d'accès à l'infirmier confirme la faisabilité de cette configuration. Aucun des 243 trajets n'excède 20 minutes, le maximum s'établissant à 16,5 minutes, et seulement 7 excèdent 15 minutes. 188 trajets, soit 77 %, s'effectuent en moins de 10 minutes. Ces valeurs sont compatibles avec l'insertion d'un accompagnement dans une tournée de soins à domicile, y compris en milieu rural, ce qui valide le modèle organisationnel retenu par l'action. Une analyse complémentaire, retenant pour chaque assuré le professionnel le plus rapide toutes professions confondues et sans seuil de distance, confirme cet apport : le temps de trajet médian en voiture tombe alors à 7,4 minutes, contre 11,2 minutes vers le seul médecin généraliste, et le nombre d'assurés disposant d'un itinéraire praticable en transport collectif passe de 355 à 369. Autrement dit, la prise en compte de l'infirmier ne modifie pas seulement la faisabilité du dispositif : elle améliore mécaniquement l'accessibilité mesurée du public cible.

10.3. Deux configurations de déploiement

Le croisement de la couverture infirmière et des difficultés d'accès au médecin permet de distinguer deux situations, qui nécessitent des stratégies différentes.

- **Une situation favorable** concerne l'Indre, le Loiret et l'Indre-et-Loire. La couverture infirmière y est relativement bonne, avec des taux compris entre 63 et 67 %. Le dispositif peut donc être déployé en s'appuyant sur les professionnels déjà référencés. Dans l'Indre, où les difficultés d'accès au médecin sont les plus importantes et où l'accès aux infirmiers est le plus faible, le dispositif présente un intérêt particulièrement important.
- **Une situation plus contrainte** concerne le Loir-et-Cher et le Cher. La couverture infirmière y est beaucoup plus faible, avec respectivement 7,6 % et 21,6 % des professionnels référencés. Le déploiement du dispositif ne peut donc pas être réalisé immédiatement auprès de l'ensemble du public identifié. La principale difficulté ne semble toutefois pas être le manque de professionnels, puisque leur nombre réel est supérieur à celui enregistré dans le répertoire. L'enjeu est plutôt d'identifier et de référencer les professionnels déjà présents sur le territoire, notamment par l'intermédiaire des DAM, comme prévu dans la fiche action.

Cette analyse conduit à une priorité opérationnelle claire : le référencement des infirmiers libéraux dans le répertoire des locaux accessibles doit être renforcé en priorité dans les communes où résident les personnes classées en niveau 3. Sans ce référencement, la solution de téléconsultation assistée risque de rester difficile à mettre en place précisément dans les territoires où les difficultés d'accès aux soins sont les plus importantes. Le référencement doit donc être considéré comme un véritable indicateur de suivi du dispositif et non comme une simple étape préalable. Son coût reste limité au regard de son importance, puisqu'il conditionne directement la possibilité d'organiser les téléconsultations assistées.

Un dernier constat mérite d'être versé au dossier de la faisabilité. Le répertoire des locaux accessibles renseigne, pour chaque professionnel, les conditions d'accueil de son cabinet : le stationnement réservé est signalé dans 87,6 % des cas et le plain-pied dans 73,8 %, mais un cabinet référencé sur deux ne dispose pas d'un poste d'accueil accessible en fauteuil, et moins d'un professionnel sur 4 déclare une formation à la prise en charge du handicap. Un point est en revanche favorable au dispositif : 60,4 % d'entre eux proposent des consultations à domicile, ce qui atteste d'une culture de l'intervention au domicile propice à la téléconsultation assistée. Le tableau détaillé figure en annexe. Surtout, le répertoire ne compte que 225 professionnels pour l'ensemble de la région, dont 14 dans l'Indre et 2 infirmiers en Loir-et-Cher : un assuré cherchant un professionnel accessible dans ces deux départements ne dispose, en l'état, d'aucune information exploitable. Le déficit d'information produit ici un effet équivalent à un déficit d'offre, ce qui fait de la sensibilisation des professionnels au répertoire une condition de faisabilité et non un volet accessoire.

CINQUIÈME PARTIE

ANALYSE DÉPARTEMENTALE : SIX CONFIGURATIONS TERRITORIALES D'UNE MÊME CONTRAINTE

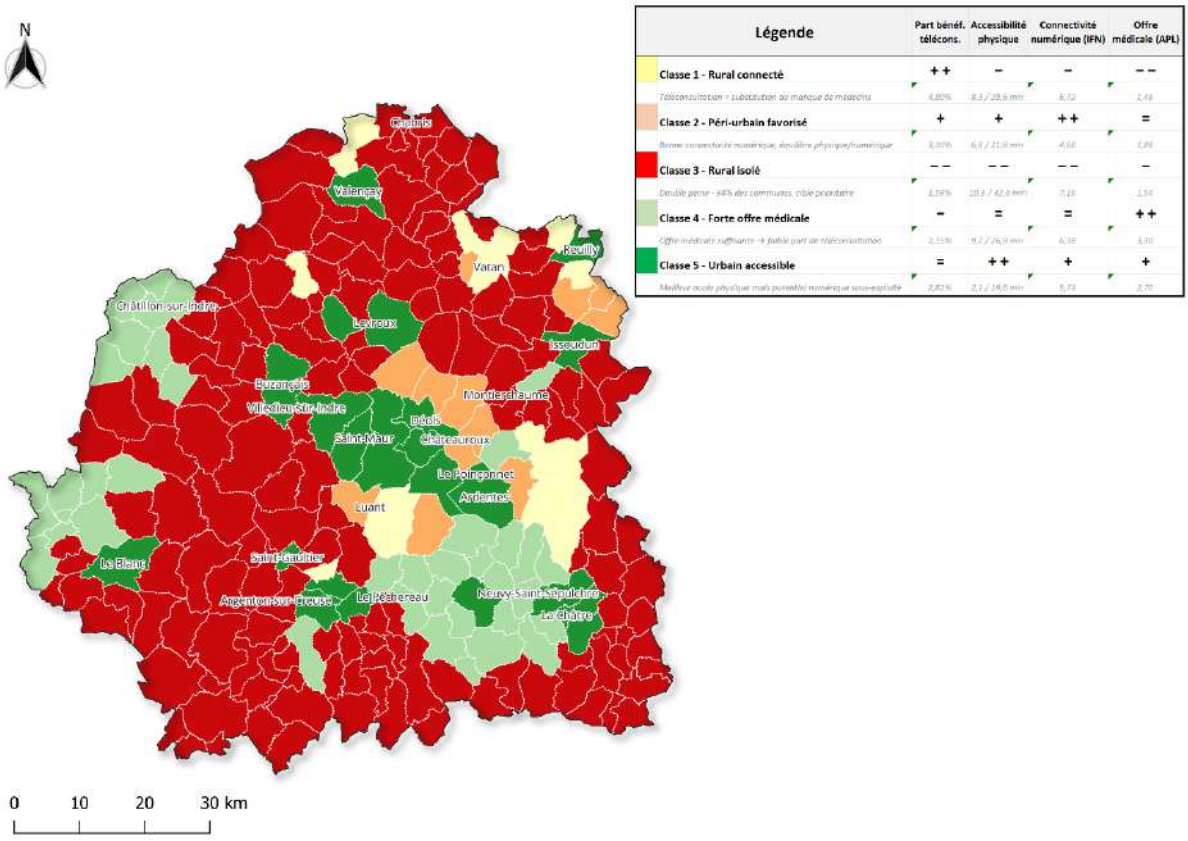
Chapitre 11. Configurations départementales : trois cas révélateurs

Décliner le diagnostic sur les 6 départements conduirait à répéter 6 fois la même démonstration. Ce chapitre retient donc trois cas qui portent chacun un enseignement distinct : l'Indre, où le public relève massivement du niveau 2 et où le problème posé est celui du transport bien plus que celui de l'offre ; le Loiret, qui concentre à lui seul près de la moitié des assurés de niveau 3 et réunit les meilleures conditions d'expérimentation du levier subsidiaire ; l'Eure-et-Loir enfin, dont la configuration inverse celle des deux précédents et fait office de contre-exemple. Les trois autres départements sont traités ensemble, dans une synthèse comparative qui en dégage les traits saillants. Chaque cas suit le même protocole : typologie communale, distance au cabinet accessible le plus proche et temps de trajet routier des assurés repérés, cette dernière représentation constituant le support direct du ciblage. Les principaux trajets routiers contraints closent chaque section ; le détail des itinéraires en transport en commun est reporté en annexe.

11.1. L'Indre : le transport plutôt que l'offre

L'Indre constitue le département où le diagnostic régional atteint son expression la plus aiguë. Il ne s'agit pas, comme dans le Cher, d'une césure interne, ni comme en Eure-et-Loir d'un contraste entre marges et centre, mais d'une rareté généralisée dont l'agglomération de Châteauroux constitue la seule exception significative.

Figure 6 : Typologie communale issue de la classification ascendante hiérarchique dans l'Indre

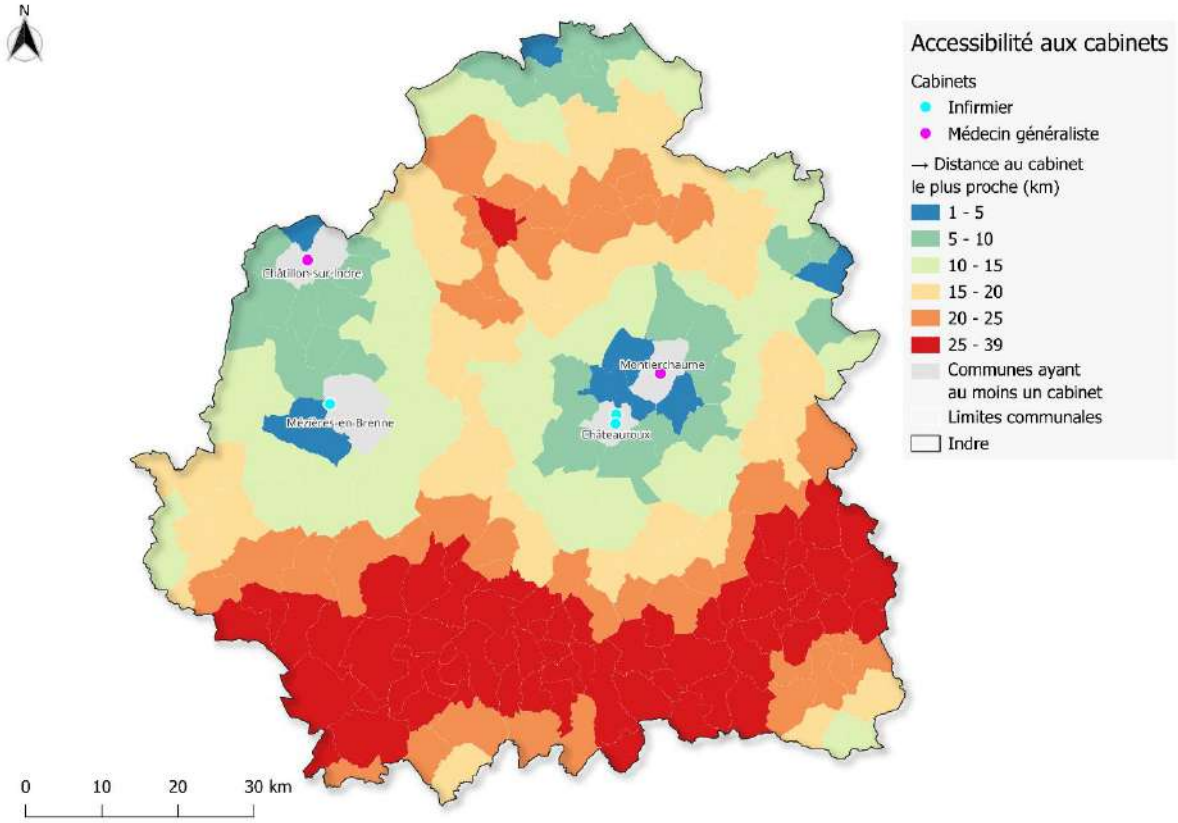


Sources : SNIIRAM 2024/2025 ; INSEE RP 2022 ; FiLoSoFi 2021

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

Cette carte est la plus monochrome de toutes celles produites pour ce mémoire. La classe 3 recouvre 151 des 241 communes et l'essentiel du territoire, en particulier la Brenne à l'ouest, le Boischaut au sud autour de La Châtre et l'ensemble des franges départementales. Seul le noyau castelroussin présente les classes 4 et 5, complété par quelques relais isolés tels qu'Issoudun, Le Blanc ou Argenton-sur-Creuse. La classe 1, rural connecté, y est presque absente : la substitution spontanée par la téléconsultation, observée ailleurs dans les territoires ruraux mieux connectés, n'y opère pas.

Figure 7 : Distance au cabinet accessible le plus proche dans l'Indre



Source : Santé.fr 2026, annuaire de l'accessibilité des cabinets

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

L'accessibilité est la plus dégradée de la région : toute la moitié méridionale apparaît en rouge, avec des distances de 25 à 39 km, et cet ensemble se prolonge vers l'est jusqu'aux limites du Cher ; le nord présente des valeurs de 15 à 25 km, à l'exception de deux poches autour de Châtillon-sur-Indre et de Mézières-en-Brenne et du noyau castelroussin. Avec 14 professionnels référencés seulement, dont 3 médecins généralistes et 4 infirmiers, l'Indre présente le maillage documenté le plus lâche de la région.

Page retirée de la version publique

Elle présentait la figure 8 et le tableau 11 : la carte des assurés de l'Indre et la liste de leurs trajets les plus longs, d'après des données de l'Assurance Maladie, ainsi que le texte qui l'entourait.

Elle est retirée pour protéger ces personnes. Hors des passages signalés ainsi, le mémoire est identique à la version soutenue.

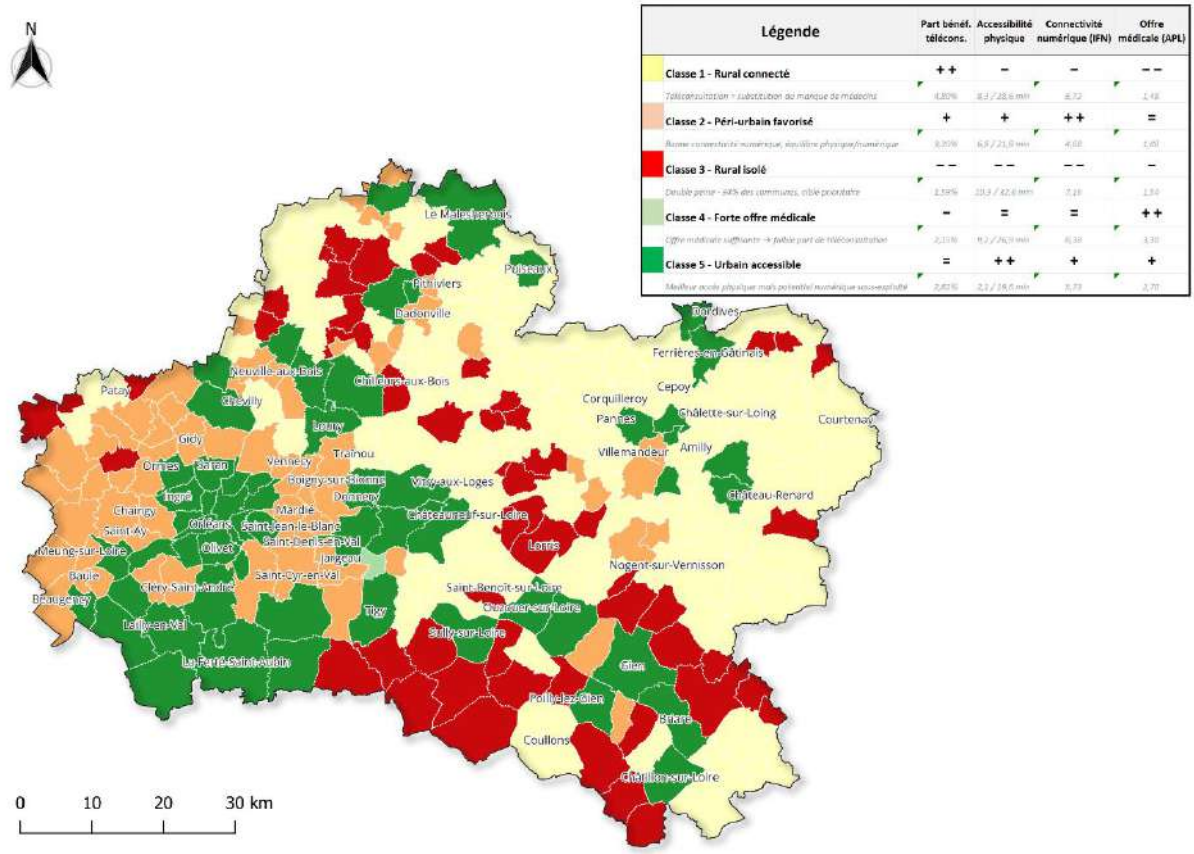
Page 60 de la version originale

L'Indre présente la configuration la plus favorable au déploiement, pour une raison qui tient à sa dualité : la contrainte d'accès au médecin y est la plus élevée de la région, avec une médiane de 15,6 minutes qui signale une difficulté diffuse, tandis que le public repéré bénéficie du meilleur accès à l'infirmier. Une réserve s'impose toutefois : le département présente des conditions de connexion parmi les plus incertaines de la région, de sorte que la sécurisation de la liaison par une solution mobile embarquée par l'infirmier y constitue un préalable technique. Les 47 itinéraires en transport en commun excédant 25 minutes sur les 62 aboutis confirment que l'alternative du déplacement n'existe pas.

11.2. Le Loiret : la concentration du niveau 3

Département le plus peuplé de la région et le plus directement soumis à l'influence parisienne, le Loiret concentre l'effectif de public cible le plus élevé, avec 158 assurés soit 29,5 % du total régional, et présente la diffusion de la téléconsultation la plus avancée. Sa position de caisse pilote pressentie lui confère un rôle particulier dans le déploiement de l'action.

Figure 9 : Typologie communale issue de la classification ascendante hiérarchique dans le Loiret



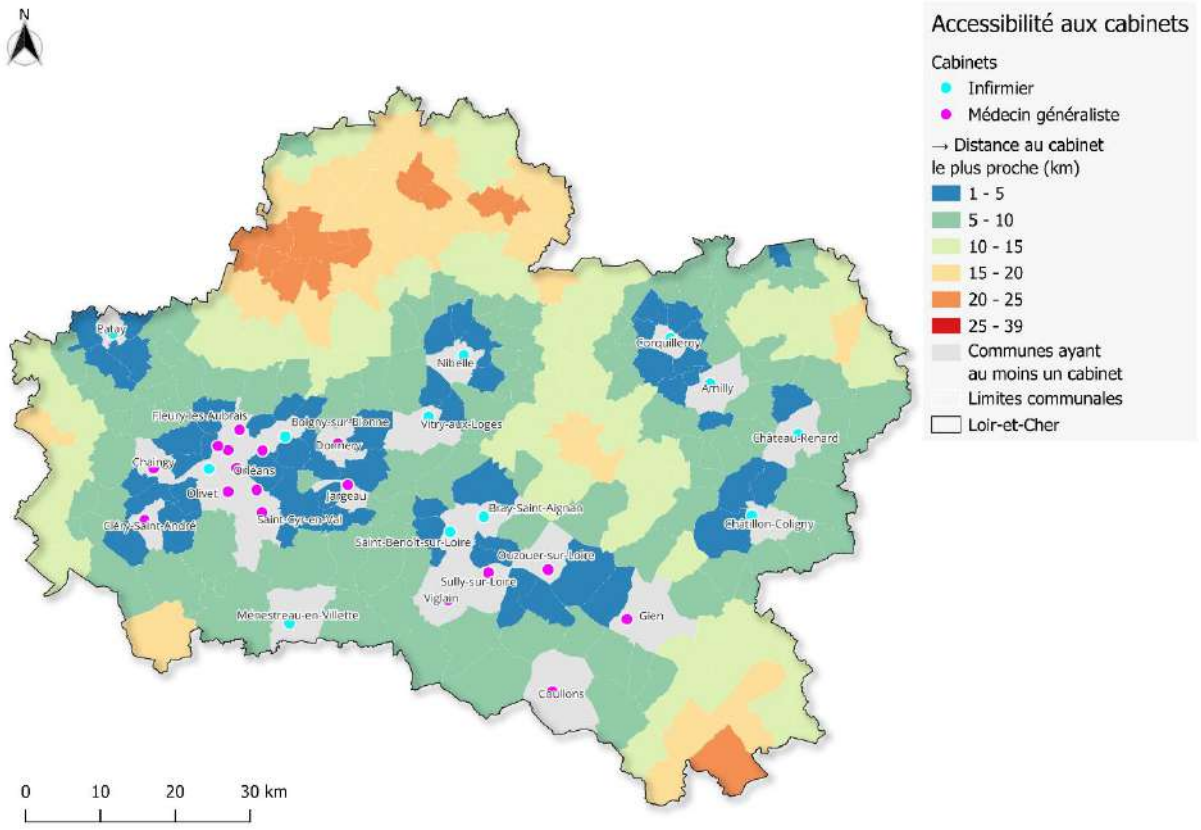
Sources : SNIIRAM 2024/2025 ; INSEE RP 2022 ; FiLoSoFi 2021

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

Le Loiret est le seul département où la classe 1, rural connecté, domine, avec 141 communes distribuées principalement dans le Gâtinais oriental et en Beauce ; la couronne orléanaise

présente les classes 2 et 5, et des ensembles de classe 3 apparaissent au nord-ouest de Pithiviers, autour de Lorris et dans le Giennois méridional. Cette prédominance de la classe 1 éclaire le taux de recours à la téléconsultation le plus élevé de la région : c'est dans les espaces ruraux mais correctement connectés que la substitution numérique s'opère spontanément, ce qui constitue un atout pour le déploiement, la culture de l'usage y étant déjà installée.

Figure 10 : Distance au cabinet accessible le plus proche dans le Loiret

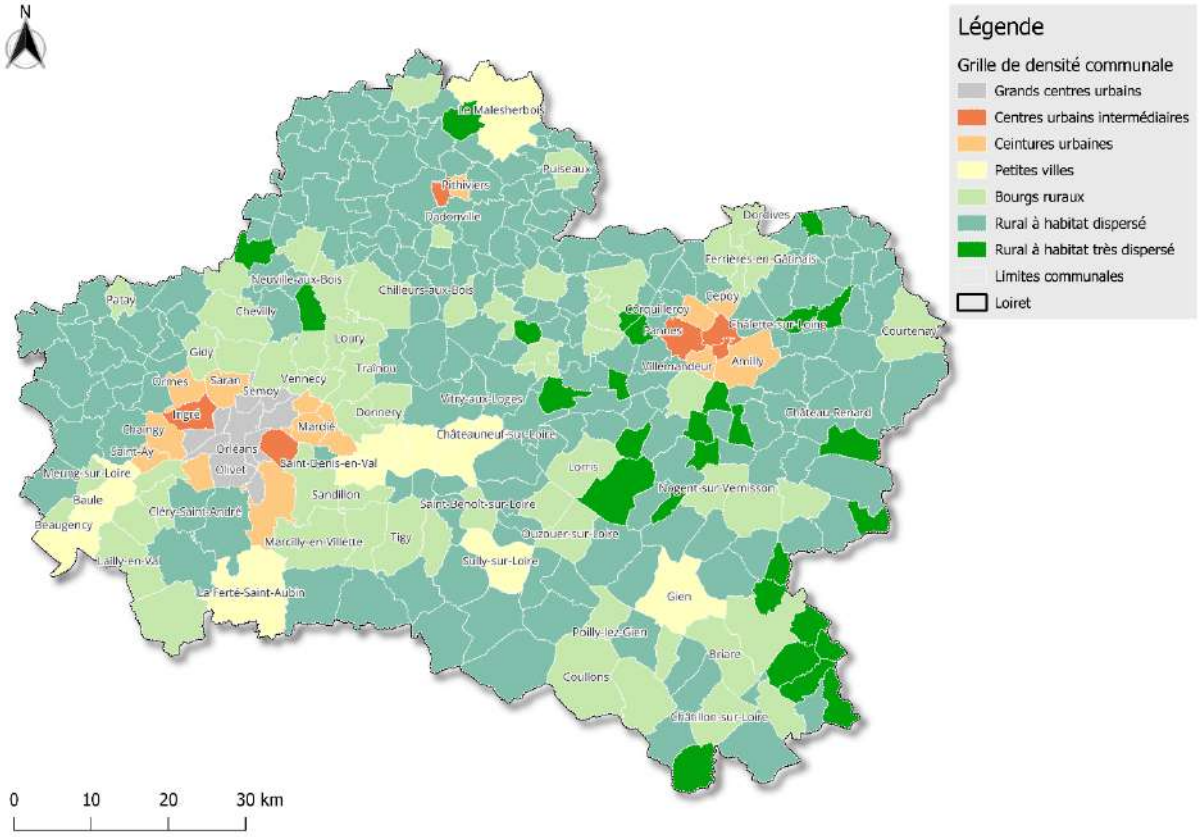


Source : Santé.fr 2026, annuaire de l'accessibilité des cabinets

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

Le maillage est relativement dense, avec 61 professionnels référencés dont 18 médecins généralistes et 13 infirmiers, les valeurs les plus basses se distribuant le long de la Loire, d'Orléans à Gien. Une seule zone dégradée se détache nettement, le nord-ouest entre Patay et Pithiviers, où les distances atteignent 20 à 25 km ; le sud-est, autour de Coullons et de Châtillon-sur-Loire, présente également des valeurs élevées.

Figure 11 : Grille communale de densité dans le Loiret



Source : INSEE, grille communale de densité 2025

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

La grille de densité communale éclaire l'armature du département. Les grands centres urbains se limitent à Orléans et à sa couronne immédiate, entourés des ceintures urbaines d'Ingré à Saint-Denis-en-Val ; Pithiviers, Amilly et Châlette-sur-Loing constituent les centres urbains intermédiaires. Le reste du département relève du rural à habitat dispersé, ponctué de taches de rural à habitat très dispersé qui se concentrent significativement dans le sud-est, entre Lorris, Gien et Châtillon-sur-Loire, ainsi qu'au nord-est vers Château-Renard.

Page retirée de la version publique

Elle présentait la figure 12 et le tableau 12 : la carte des assurés du Loiret et la liste de leurs trajets les plus longs, d'après des données de l'Assurance Maladie, ainsi que le texte qui l'entourait.

Elle est retirée pour protéger ces personnes. Hors des passages signalés ainsi, le mémoire est identique à la version soutenue.

Page 64 de la version originale

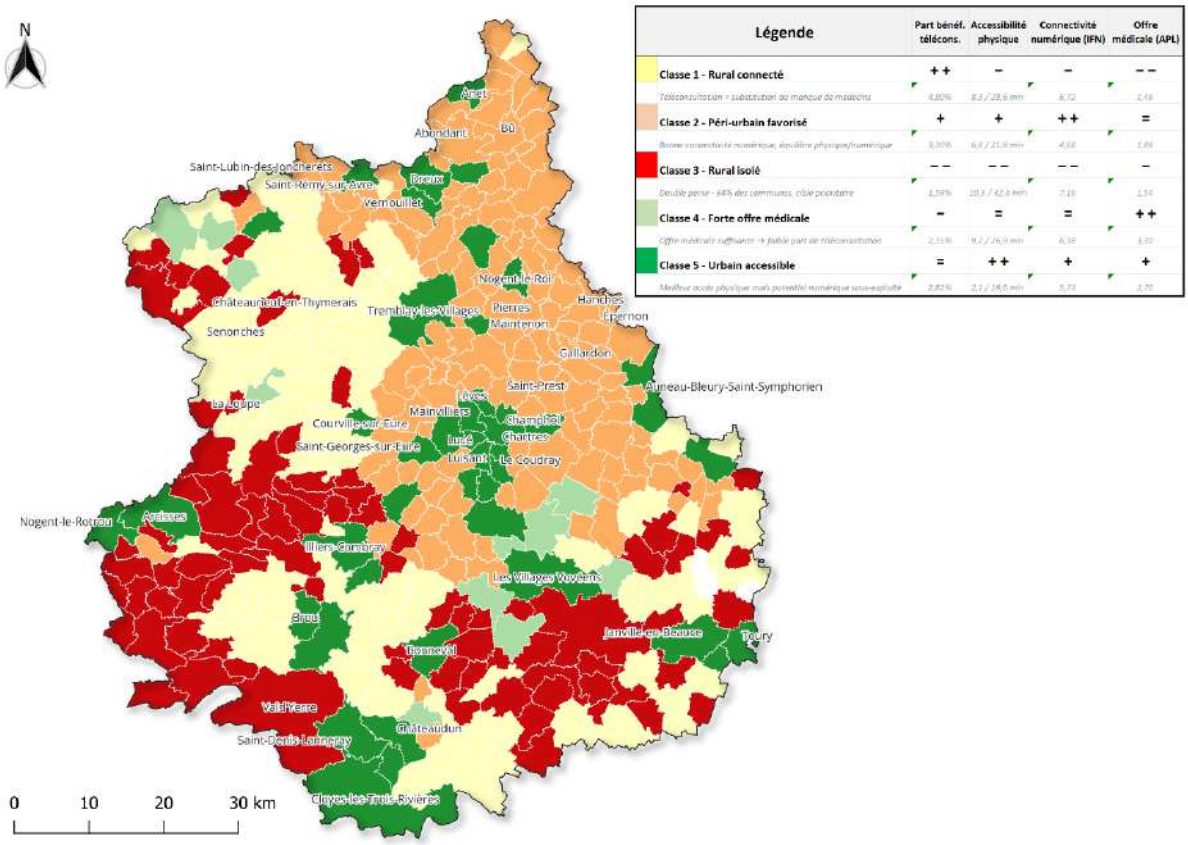
Le Loiret présente une configuration statistiquement singulière : il affiche simultanément la médiane routière la plus favorable après l'Indre-et-Loire, à 9 minutes, et la proportion de trajets excédant 25 minutes la plus élevée de la région, à 25,3 %. Cette apparente contradiction traduit une polarisation extrême, deux tiers du public cible bénéficiant de la proximité orléanaise ou montargoise tandis qu'un tiers réside dans des marges où les temps s'allongent considérablement. Les 40 trajets excédant 25 minutes se concentrent presque exclusivement dans le Gâtinais oriental, où les assurés sont rattachés à des cabinets situés à Charny Orée de Puisaye dans l'Yonne, à Nemours en Seine-et-Marne ou à Ouzouer-sur-Loire.

Cette dépendance à des cabinets extérieurs au département constitue un enseignement de premier ordre pour la caisse concernée : le déficit d'offre référencée dans le Montargois est tel que le calcul d'itinéraire renvoie systématiquement vers des destinations situées à plus de 30 km, alors même que l'agglomération montargoise compte plus de 60 000 habitants ; le référencement de l'offre montargoise apparaît ainsi comme la priorité opérationnelle immédiate. Le département concentre enfin 20 des 28 itinéraires jugés non praticables au niveau régional, résultat qui traduit non une absence d'infrastructure mais son inadaptation, comme l'illustrent les liaisons Chilleurs-aux-Bois à Saint-Jean-de-Braye en 86,6 minutes avec deux correspondances et Dadonville à Fleury-les-Aubrais en 83,2 minutes assorties de 2 628 mètres de marche.

11.3. L'Eure-et-Loir : le contre-exemple

L'Eure-et-Loir se singularise par sa position septentrionale et par l'influence francilienne qui irrigue sa partie orientale. Cette position se traduit par les indicateurs d'accessibilité les plus favorables de la région, sans que les difficultés en soient absentes : elles se déplacent vers l'ouest et prennent une forme différente.

Figure 13 : Typologie communale issue de la classification ascendante hiérarchique en Eure-et-Loir

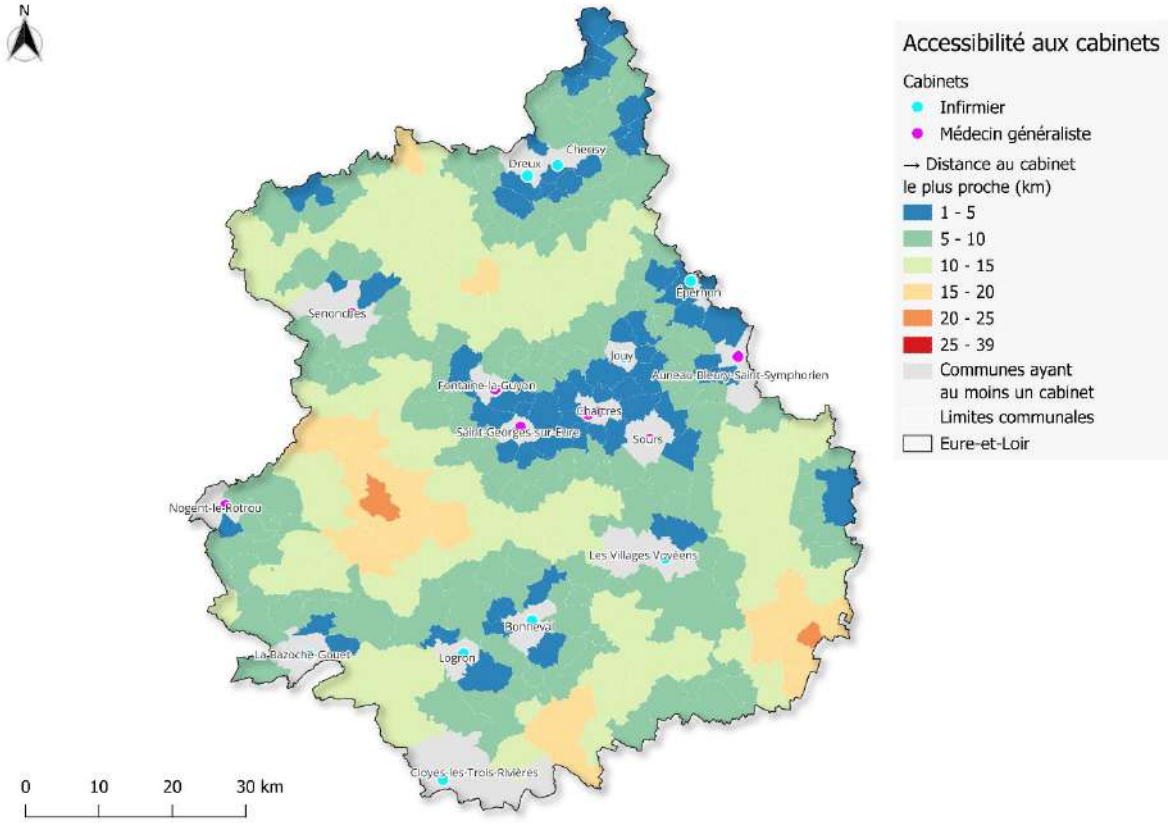


Sources : SNIIRAM 2024/2025 ; INSEE RP 2022 ; FiLoSoFi 2021

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

La structure est tripartite. Le nord-est, du Drouais au Pays Chartrain, est dominé par la classe 2, péri-urbain favorisé, tandis que l'agglomération chartraine relève de la classe 5. Le sud-ouest en revanche, du Perche à la Beauce méridionale en passant par le Thymerais, présente une prédominance de la classe 3.

Figure 14 : Distance au cabinet accessible le plus proche en Eure-et-Loir



Source : Santé.fr 2026, annuaire de l'accessibilité des cabinets

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

Cette carte est la plus favorable de la région : aucune commune n'atteint la classe supérieure à 25 km, et seules quelques taches orangées apparaissent à l'ouest de Chartres et à l'est vers Toury. La densité de cabinets référencés, 35 professionnels dont 9 médecins généralistes et 11 infirmiers, explique cette performance.

Page retirée de la version publique

Elle présentait la figure 15 et le tableau 13 : la carte des assurés d'Eure-et-Loir et la liste de leurs trajets les plus longs, d'après des données de l'Assurance Maladie, ainsi que le texte qui l'entourait.

Elle est retirée pour protéger ces personnes. Hors des passages signalés ainsi, le mémoire est identique à la version soutenue.

Page 68 de la version originale

% de ses communes se situent au-delà de 15 km, il compte 35,1 % d'assurés dépourvus de solution de transport collectif, troisième taux régional, par l'effet de la dispersion du public dans des communes périurbaines proches mais non desservies. Le rattachement de plusieurs assurés du Drouais à un cabinet situé à Gambais, dans les Yvelines, plaide en outre pour une articulation interrégionale du dispositif sur ce secteur.

11.4. Trois configurations intermédiaires : le Cher, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher

Les trois départements restants ne présentent pas de configuration aussi tranchée que les précédents, mais leur comparaison éclaire les nuances de la segmentation établie plus haut. Ils totalisent 218 des 535 assurés repérés, soit 41 % du public régional, et se distribuent selon des profils que les indicateurs moyens masqueraient.

Le Cher se caractérise par la distribution la plus équilibrée entre les trois niveaux d'intervention : 45 assurés relèvent du niveau 1, 38 du niveau 2 et 19 du niveau 3, soit respectivement 44,1 %, 37,3 % et 18,6 %. Cette apparente modération recouvre une césure interne nord-sud que la carte des temps de trajet rend immédiatement lisible. L'agglomération de Bourges, prolongée par Vierzon, concentre les accès rapides et l'essentiel des assurés de niveau 1, tandis que le Boischaut méridional et le Val d'Aubois rassemblent les situations les plus contraintes, avec des trajets atteignant 62 minutes et des rattachements à des cabinets situés hors région, à Boussac dans la Creuse ou à Saint-Eloi dans la Nièvre. Le ratio médian entre transport collectif et voiture y atteint 3,27, valeur la plus élevée de la région. Surtout, la couverture infirmière des assurés de niveau 3 n'y est que de 11 %, soit 2 assurés sur 19 : le département cumule donc un effectif de niveau 3 substantiel et une capacité quasi nulle à lui proposer le levier subsidiaire.

Page retirée de la version publique

Elle présentait la figure 16, une carte qui localise les assurés du Cher, d'après des données de l'Assurance Maladie, ainsi que le texte qui l'entourait.

Elle est retirée pour protéger ces personnes. Hors des passages signalés ainsi, le mémoire est identique à la version soutenue.

Page 70 de la version originale

Page retirée de la version publique

Elle présentait la figure 17, une carte qui localise les assurés d'Indre-et-Loire, d'après des données de l'Assurance Maladie, ainsi que le texte qui l'entourait.

Elle est retirée pour protéger ces personnes. Hors des passages signalés ainsi, le mémoire est identique à la version soutenue.

Page 71 de la version originale

Page retirée de la version publique

Elle présentait la figure 18, une carte qui localise les assurés de Loir-et-Cher, d'après des données de l'Assurance Maladie, ainsi que le texte qui l'entourait.

Elle est retirée pour protéger ces personnes. Hors des passages signalés ainsi, le mémoire est identique à la version soutenue.

Page 72 de la version originale

SIXIÈME PARTIE

DE RÉUSSITE DU DISPOSITIF

PORTÉE, LIMITES ET CONDITIONS
DISCUSSION :

Chapitre 12. Ce que le diagnostic établit et ce qu'il ne peut établir

Le travail conduit dans les parties précédentes établit 4 propositions dont la robustesse repose sur des sources indépendantes et sur des méthodes de nature différente : l'obstacle principal n'est pas, pour la majorité du public repéré, l'absence de médecin à proximité mais l'impossibilité de l'atteindre ; l'accessibilité mesurée par les indicateurs standards surestime considérablement l'accessibilité réelle de ce public ; la diffusion spontanée de la téléconsultation suit une géographie inverse de celle du besoin ; et la faisabilité du levier subsidiaire décroît à mesure que le besoin croît. Ces acquis, développés dans les parties précédentes et repris en conclusion, appellent surtout d'être confrontés aux limites de la démarche.

12.1. Les limites du diagnostic

Six limites doivent être prises en compte pour interpréter les résultats et leurs conclusions.

- **La limite du référentiel d'offre.** Les temps de trajet ont été calculés vers les cabinets présents dans le répertoire des locaux accessibles, et non vers l'ensemble des cabinets existants. Les résultats peuvent donc donner une image plus importante des difficultés d'accès que si l'ensemble de l'offre était pris en compte. Cependant, ils mesurent correctement l'accès à l'offre dont l'accessibilité est connue et vérifiée.
- **La principale limite : l'étude mesure l'accessibilité, mais pas la disponibilité.** L'analyse montre qu'un cabinet accessible se trouve à une certaine distance, mais elle ne permet pas de savoir si le professionnel peut réellement accueillir de nouveaux patients. Cette question est particulièrement importante dans une région où l'offre médicale est limitée. Ainsi, certaines personnes considérées comme ayant un accès relativement facile aux soins peuvent malgré tout rencontrer des difficultés pour obtenir un rendez-vous. Seul le retour des conseillers chargés du démarchage permettra de mesurer cette situation et de déterminer la part réelle des personnes nécessitant une solution alternative.
- **La limite liée à la mesure du handicap.** Le repérage à partir des remboursements de matériel permet d'identifier une population de manière objective, mais ne renseigne pas sur le niveau réel de limitation de chaque personne. Il ne permet pas non plus de savoir si elle bénéficie de l'aide d'un proche, dispose d'un véhicule adapté ou peut utiliser un

transport sanitaire prescrit. Deux personnes ayant un même profil administratif peuvent donc avoir des possibilités de déplacement très différentes.

- **La limite liée à l'échelle géographique.** Certaines adresses ont été géocodées à partir du centroïde de la commune, notamment lorsqu'elles correspondaient à une boîte postale ou à une adresse professionnelle. Cette méthode peut entraîner une certaine imprécision dans les temps de trajet calculés, notamment dans les communes urbaines.

12.2. Ce que le diagnostic ne peut pas dire

Une dernière catégorie de limites tient à la nature même de l'exercice. Le diagnostic établit une opportunité et non une efficacité. Il montre où le dispositif est susceptible d'apporter le bénéfice le plus élevé, mais il ne démontre pas que ce bénéfice se réalisera. 3 incertitudes majeures subsistent, qui ne pourront être levées que par l'observation du déploiement.

La première concerne le taux d'aboutissement du démarchage. La segmentation établie repose sur l'existence d'un cabinet accessible, non sur la disponibilité d'un praticien acceptant de nouveaux patients ; si ce taux se révélait faible, une part significative des assurés de niveaux 1 et 2 basculerait de fait vers le levier subsidiaire, dont les conditions de faisabilité sont, on l'a vu, très inégalement réunies. La deuxième concerne l'acceptabilité par les personnes : le public visé est en rupture avec le système de soins depuis une durée inconnue, et cette rupture peut résulter d'un désintérêt, d'une défiance ou d'un renoncement intériorisé qu'une proposition institutionnelle ne suffira pas à lever, ce qui plaide pour un dimensionnement modeste des objectifs initiaux. La troisième concerne la mobilisation des professionnels : la rémunération de l'accompagnement, comprise entre 10 et 15 euros, doit être rapportée au temps effectivement consacré, et dans un contexte de forte tension sur la démographie infirmière son attractivité économique n'est pas acquise. La quatrième concerne la disponibilité du médecin téléconsultant, dans une région présentant la densité médicale la plus faible de France métropolitaine : la question de l'origine de cette ressource médicale, qu'il s'agisse des médecins des CPTS, des centres de santé ou des plateformes, n'est pas tranchée et constitue un déterminant majeur du succès.

Chapitre 13. Priorisation, conditions de réussite et évaluation

13.1. Une grille de priorisation opérationnelle

La segmentation du public en trois niveaux d'intervention fournit la clé de la priorisation, car elle indique, département par département, quelle proportion du public relève du démarchage seul, du démarchage assorti d'une solution de transport, ou du levier subsidiaire. Croisée avec la couverture infirmière du seul niveau 3, elle permet de construire une grille opérationnelle.

Tableau 14 : Grille de priorisation départementale du déploiement selon les niveaux d'intervention

Département	Niveau 1 (n)	Niveau 2 (n)	Niveau 3 (n)	Couverture infirmière du niveau 3	Orientation proposée
Indre (36)	10	59	13	0 %	Démarchage assorti d'une solution de transport, priorité absolue ; référencer l'offre infirmière avant tout recours au levier subsidiaire
Loiret (45)	80	38	40	55 %	Démarchage immédiat pour la moitié du public ; téléconsultation assistée à organiser dans le Gâtinais et le Giennois
Cher (18)	45	38	19	11 %	Démarchage sur le centre du département ; référencement infirmier préalable dans le Boischaut et le pays de Sauldre
Loir-et-Cher (41)	20	41	5	0 %	Enjeu de transport dominant en Sologne ; effectif de niveau 3 restreint mais dépourvu d'accompagnant référencé
Indre-et-Loire (37)	16	31	3	33 %	Démarchage assorti d'une solution de transport ; niveau 3 marginal, concentré sur les marges
Eure-et-Loir (28)	31	36	10	70 %	Démarchage praticable ; conditions du levier subsidiaire les mieux réunies de la région

Réalisation : Gora NDOYE, 2026

Trois enseignements se dégagent de cette grille. Le premier est que l'Indre constitue un cas limite : 72 % de son public relève du niveau 2, c'est-à-dire d'un médecin accessible par la route mais inatteignable autrement, et aucun de ses 13 assurés de niveau 3 ne dispose d'un infirmier référencé. Le département appelle donc en priorité une réponse de transport, et non un déploiement de la téléconsultation, qui n'y est pas outillée. Le deuxième est que le Loiret concentre à lui seul 40 des 90 assurés de niveau 3 de la région, soit 44 %, avec une couverture infirmière de 55 % : c'est le territoire où le levier subsidiaire peut être expérimenté dans les meilleures conditions. Le troisième est que l'Eure-et-Loir, souvent relégué au second plan par les indicateurs de contrainte, présente la couverture infirmière du niveau 3 la plus élevée de la région, à 70 %, ce qui en fait un terrain d'expérimentation secondaire pertinent. A l'échelle infra-départementale, 4 territoires de coordination présentent une priorité maximale au regard de la concentration du public repéré et de la faiblesse du recours à la téléconsultation : Châteauroux & Co, avec 6,93 assurés pour 10 000 habitants et un taux de recours de 0,32 % ; le Boischaut Nord, avec 2,77 et 0,54 % ; le Pays des Mille Etangs, avec 3,71 et 0,43 % ; et Berry Vierzon Sologne, avec 2,18 et 0,68 %.

Proposition de séquence de déploiement

Temps 1 : le démarchage, partout et d'emblée. Il concerne 445 assurés sur 535, soit 83 %, pour lesquels un cabinet accessible se situe à moins de 25 minutes. C'est le cœur de l'action et il ne suppose aucun préalable technique : il mobilise les conseillers accompagnement santé et les délégués de l'assurance maladie auprès des praticiens du secteur.

Temps 2 : la solution de transport, pour le niveau 2. Elle conditionne l'efficacité du démarchage pour 243 assurés, soit 45 % du public, dont 105 sans aucune desserte collective praticable et 138 pour lesquels la marche à pied constitue l'obstacle. Transport à la demande, transport sanitaire[23] prescrit et mobilisation de l'entourage relèvent ici d'un partenariat à construire avec les collectivités et les transporteurs.

Temps 3 : la téléconsultation assistée, pour le niveau 3. Elle concerne 90 assurés, dont 40 dans le seul Loiret. L'expérimentation gagnerait à s'y ouvrir, la couverture infirmière y atteignant 55 %, puis à s'étendre à l'Eure-et-Loir, où elle atteint 70 %. Dans l'Indre et le Loir-et-Cher, aucun assuré de niveau 3 ne dispose d'un infirmier référencé : le référencement de l'offre y constitue le préalable absolu.

13.2. Conditions de réussite, risques et points de vigilance

13.2.1. Quatre conditions de réussite

La première condition est la sécurisation technique de la liaison. Les territoires prioritaires sont aussi ceux où l'équipement et la connexion des ménages sont les plus incertains : faire reposer la téléconsultation sur la connexion du domicile revient donc à faire dépendre le dispositif de la variable la plus défavorable. La solution consiste à équiper le professionnel accompagnant d'une connexion mobile autonome et du matériel de vidéotransmission, ce que permettent d'ailleurs les aides conventionnelles à l'équipement, fixées à 350 euros pour la vidéotransmission et à 175 euros pour les appareils médicaux connectés.

La deuxième condition est le référencement de l'offre. Le déficit d'information constaté dans l'Indre, avec 14 professionnels référencés, et en Loir-et-Cher, avec 2 infirmiers, produit un effet équivalent à un déficit d'offre. La campagne de sensibilisation des professionnels au répertoire des locaux accessibles, mentionnée dans la fiche action au titre des missions des délégués de l'assurance maladie, doit être traitée comme un préalable et non comme un volet d'accompagnement.

La troisième condition est l'identification de la ressource médicale téléconsultante. L'action définit précisément le repérage et l'accompagnement mais laisse ouverte la question de l'origine du médecin ; trois options se dessinent, dont les implications diffèrent : la mobilisation des médecins des CPTS, qui garantit l'ancrage territorial mais se heurte à la saturation de leur activité ; le recours aux centres de santé, qui offre une disponibilité salariée mais suppose leur implantation ; le recours à des plateformes, qui assure la disponibilité mais rompt la continuité

[23] De types TPMR, VSL ou taxi conventionné : https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/frais-transport

territoriale. La quatrième condition est l'articulation avec le parcours de soins. Elle découle directement de l'architecture de l'action : l'objectif n'est pas de substituer durablement l'acte à distance à la relation médicale, mais de restaurer cette relation. La téléconsultation assistée n'a de sens que si elle constitue une étape vers la déclaration d'un médecin traitant, et la réussite du dispositif se mesurera donc moins au nombre de téléconsultations réalisées qu'au nombre de patients ayant, à l'issue du parcours, déclaré un médecin traitant ou repris un suivi régulier.

13.2.2. Quatre risques identifiés

- **Le risque d'écrémage.** Une action reposant sur l'adhésion volontaire des caisses et sur la disponibilité des professionnels tend spontanément à se déployer là où elle est la plus facile, c'est-à-dire dans les territoires les mieux dotés. Ce mécanisme reproduirait, à l'échelle du dispositif, « *The inverse care law* » que le diagnostic a mise en évidence. Un pilotage régional attentif à la distribution territoriale des inclusions constitue le seul garde-fou ; le portail cartographique présenté dans la partie méthodologique est précisément conçu pour rendre cette distribution visible en continu, en permettant de comparer la carte des inclusions à celle du public repéré.
- **Le risque de substitution dégradée.** La téléconsultation assistée peut être perçue, par les personnes concernées comme par les professionnels, comme une médecine de second rang réservée à ceux qui ne peuvent accéder à la médecine ordinaire. Cette perception, si elle s'installait, compromettrait l'acceptabilité du dispositif et contredirait son objectif d'égalité. La qualité de l'examen permise par la présence du tiers constitue le principal argument à opposer à cette perception, et mérite d'être documentée.
- **Le risque d'épuisement du tiers.** L'infirmier libéral constitue le pivot du dispositif, mais il exerce dans un contexte de tension démographique et de charge administrative croissante. L'accumulation des missions confiées à cette profession, entre soins, prévention, coordination et accompagnement à la téléconsultation, appelle une vigilance quant à la soutenabilité de l'engagement demandé.
- **Le risque de l'indicateur.** L'indicateur retenu, rapportant le nombre d'assurés accompagnés au total du public vulnérable, présente l'avantage de la simplicité mais mesure une couverture et non un résultat. Un assuré ayant bénéficié d'une téléconsultation unique sans suite serait comptabilisé au même titre qu'un assuré ayant retrouvé un suivi régulier. Le pilotage par cet indicateur risque donc de valoriser le volume au détriment de la continuité.

13.3. Propositions pour l'évaluation du dispositif

L'action prévoit un indicateur principal de couverture et le suivi des indicateurs du baromètre Handifaction, complétés par un questionnaire de satisfaction. Ce dispositif d'évaluation, nécessaire, gagnerait à être enrichi selon trois axes.

Le premier axe concerne la mesure du résultat plutôt que de l'activité, et il doit distinguer les deux leviers : la part d'assurés ayant déclaré un médecin traitant à l'issue du démarchage constitue l'indicateur principal, celle des assurés orientés vers la téléconsultation assistée faute de solution locale mesurant en creux l'échec du premier temps : la part des assurés accompagnés ayant déclaré un médecin traitant dans les 12 mois suivant l'inclusion, qui mesure la restauration du parcours ; la part ayant bénéficié d'au moins un acte de prévention ou de dépistage, qui mesure l'entrée effective dans le système de soins ; et le délai médian entre le repérage et le premier acte, qui mesure la réactivité de la chaîne. Le deuxième axe concerne la dimension territoriale : le suivi du taux de couverture par département et par CPTS, comparé à la distribution du besoin établie dans ce mémoire, permettrait de détecter précocement un effet d'écrémage, et un indicateur d'équité rapportant la part d'inclusions réalisées dans les communes les plus éloignées à la part de public cible y résidant constituerait un instrument de pilotage utile, que le portail permet de renseigner sans traitement supplémentaire[24].

Le troisième axe concerne le volet qualitatif. La seule mesure de la satisfaction des patients ne permettra pas de comprendre les mécanismes de l'adhésion ou du refus. Des entretiens semi-directifs conduits auprès des trois catégories d'acteurs que sont les conseillers accompagnement santé chargés du repérage, les infirmiers accompagnants et les patients inclus permettraient d'identifier les points de rupture de la chaîne. Une attention particulière mériterait d'être portée aux refus, dont l'analyse est généralement plus instructive que celle des adhésions.

Enfin, la comparaison entre le public repéré et le public effectivement inclus constituerait un indicateur de premier ordre. L'écart entre les 535 assurés identifiés et le nombre d'inclusions effectives, ventilé selon les motifs de non-inclusion, qu'il s'agisse du refus du patient, de l'indisponibilité de l'accompagnant, de l'absence de connexion ou du refus du professionnel médical, fournirait la mesure la plus précise des obstacles réels au déploiement, et permettrait d'orienter les actions correctrices.

[24] Cette distinction entre indicateurs d'activité et indicateurs de résultat est constante dans l'évaluation des dispositifs de télémédecine : le programme Étapes de télésurveillance a par exemple été évalué non sur le volume d'actes mais sur la réduction du taux d'hospitalisation des patients insuffisants cardiaques (Or et Parry, 2026, d'après Costa et al., 2025)

Conclusion générale

Ce mémoire s'était donné pour objet d'examiner dans quelle mesure un démarchage individuel conduit par l'assurance maladie permet aux personnes en situation de handicap moteur dépourvues de médecin traitant d'accéder à un médecin disponible à proximité de leur domicile en Centre-Val de Loire, et dans quels territoires cette solution de proximité se révèle hors d'atteinte, justifiant le recours à la téléconsultation assistée comme levier subsidiaire.

La réponse apportée à la première partie de cette question est largement affirmative, et elle conforte le choix fait par l'action de placer le démarchage en première ligne. Pour 445 assurés sur 535, soit 83 % du public repéré, un cabinet accessible se situe à moins de 25 minutes de route : dans la grande majorité des cas, ce n'est donc pas l'absence de médecin à proximité qui explique la rupture de soins. Cette réponse doit cependant être immédiatement nuancée par un déplacement du raisonnement qui constitue l'apport principal de ce travail. Lorsque l'on substitue au mode automobile, implicitement supposé par les indicateurs standards, le mode de déplacement réellement mobilisable par une population dont la mobilité est empêchée, le diagnostic se renverse : un tiers du public cible ne dispose d'aucune solution de transport collectif praticable, et les deux tiers restants subissent un allongement médian de 166 % assorti d'1 km de marche. Il en résulte une segmentation en trois niveaux qui commande l'action. Pour 202 assurés, soit 37,8 %, la solution de proximité est effectivement atteignable et le démarchage suffit. Pour 243 autres, soit 45,4 %, le médecin est proche mais inatteignable sans automobile : le démarchage y demeure pertinent à condition d'être assorti d'une solution de transport, ce qui constitue le principal enjeu opérationnel de l'action et concerne près d'un assuré sur deux. Pour 90 enfin, soit 16,8 %, aucune solution de proximité n'existe, et c'est à eux seuls que s'adresse le levier subsidiaire.

La réponse à la seconde partie de la question est plus préoccupante, car le diagnostic établit que la géographie du besoin et celle de la faisabilité ne coïncident pas, et qu'elles varient même en sens inverse. La couverture par un infirmier référencé, condition de la téléconsultation assistée, s'établit à 54 % parmi les assurés pour lesquels le démarchage suffit, mais à 36 % seulement parmi ceux pour lesquels ce levier constitue l'unique réponse ; dans l'Indre et le Loir-et-Cher, aucun des assurés concernés n'en dispose. Là où le premier levier échoue, le second n'est donc pas davantage outillé, et le référencement de l'offre infirmière dans les communes de résidence de ces 90 assurés constitue la première recommandation opérationnelle de ce travail. Le besoin, mesuré par le cumul de l'éloignement et de la concentration du public cible, désigne prioritairement l'Indre, le sud du Cher et la Sologne. La faisabilité, mesurée par la disponibilité documentée d'un professionnel accompagnant, désigne le Loiret, l'Indre-et-Loire et l'Indre.

Seule l'Indre figure dans les deux listes, ce qui en fait le territoire d'expérimentation le plus indiqué. Ailleurs, la séquence de déploiement doit intégrer une phase préalable de référencement de l'offre, dont ce mémoire soutient qu'elle constitue non pas un accompagnement mais un préalable.

Trois enseignements de portée plus générale se dégagent de ce travail.

Le premier est méthodologique. Les indicateurs d'accessibilité aux soins couramment mobilisés dans l'action publique, qu'il s'agisse de la densité médicale ou de l'accessibilité potentielle localisée, sont construits sur l'hypothèse d'une population moyenne dotée d'une mobilité moyenne. Cette hypothèse produit un diagnostic systématiquement optimiste pour les publics dont la mobilité est contrainte, et l'optimisme croît à mesure que le territoire se déserte : les zonages conventionnels et les dispositifs qui s'y adossent sous-estiment donc structurellement les besoins des personnes âgées, des personnes handicapées et des ménages non motorisés. Le développement d'indicateurs différenciés selon les modes de déplacement, dont les travaux récents de l'IRDES esquissent la possibilité (Lucas-Gabrielli et al., 2025), constituerait une avancée significative pour la conduite des politiques territoriales de santé.

Le deuxième est théorique. La corrélation négative observée entre la concentration du public cible et le taux de recours à la téléconsultation actualise, dans le champ numérique, la loi inverse des soins formulée par Julian Tudor Hart en 1971 : la disponibilité de soins de qualité tend à varier inversement au besoin de la population desservie. Le numérique en santé, souvent présenté comme un instrument de réduction des inégalités territoriales, se diffuse en réalité selon une géographie qui reproduit et parfois amplifie ces inégalités[25], parce qu'il requiert des ressources, connectivité, équipement, compétence et entourage, dont la distribution est elle-même inégale. Ce constat ne condamne pas le recours au numérique ; il établit qu'il ne produit d'effet égalisateur que lorsqu'il est accompagné.

Le troisième est opérationnel. La démarche d'aller-vers se distingue des politiques d'accès par le droit en ce qu'elle prend l'initiative de la relation. Cette prise d'initiative a un coût, en temps et en ingénierie, mais elle est la seule réponse possible à des situations de non-recours installées, où par définition la demande ne s'exprime pas. Le dispositif étudié en constitue une application aboutie, en ce qu'il articule un repérage par la donnée, un accompagnement humain et un levier technique disponible en droit commun ; sa réussite dépendra de sa capacité à maintenir l'équilibre entre ces trois composantes, une donnée sans accompagnement produisant une liste sans effet, un accompagnement sans levier technique se heurtant à la contrainte de mobilité, et

[25] Le constat vaut au-delà du seul champ territorial : au niveau national, l'espace numérique de santé comptait 65 millions de comptes créés en janvier 2024 mais seulement 15 à 20 % de comptes effectivement activés (Or et Parry, 2026).

un levier technique sans accompagnement reproduisant l'exclusion numérique qu'il prétend corriger.

Ce travail comporte enfin une limite qu'il convient d'assumer : il documente une opportunité et non un résultat. Le dispositif n'étant pas déployé au moment de la rédaction, l'analyse ne peut établir que le bénéfice attendu se réalisera. Elle fournit en revanche le cadre de son évaluation, en identifiant les territoires où le bénéfice marginal est le plus élevé, les conditions dont dépend sa réalisation et les indicateurs qui permettraient d'en mesurer l'effet. Le portail cartographique développé en complément de ce mémoire prolonge cette ambition sur le terrain : en rendant les résultats directement manipulables par les caisses et par le service des missions d'accompagnement santé, il entend éviter que le diagnostic ne demeure un document et permettre son appropriation par ceux qui conduiront l'action. La confrontation ultérieure entre la distribution du public repéré établie dans ce mémoire et celle des inclusions effectives constituera, à cet égard, le test le plus rigoureux de la capacité d'une politique d'aller-vers à atteindre ceux qu'elle vise.

Bibliographie

Barlet, M., Coldefy, M., Collin, C., & Lucas-Gabrielli, V. (2012). L'accessibilité potentielle localisée (APL) : Une nouvelle mesure de l'accessibilité aux soins appliquée aux médecins généralistes libéraux en France. *IRDES*, (DT N°51), 56.

Bellamy, V. (2024). *Le handicap en chiffres—Édition 2024*. Irdes. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse-documents-de-reference/panoramas-de-la-drees/241128_Panorama_Handicap2024

Bussière, C. (2023). Définir, évaluer et comprendre la santé, l'accès aux soins et le bien-être de populations vulnérables : Une approche microéconomique. *Erudite HDR / Erudite Accreditation to supervise Ph.D.* https://ideas.repec.org//b/eru/erudhd/hd23-03.html

Chapireau, F. (2001). La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. *Gérontologie et société*, *2499*(4), 37-56. https://doi.org/10.3917/gs.099.0037

Chasles, V., Fayet, Y., & Juvanon, A. (2018). Distance et recours à l'expertise en cancérologie. Expérience des contraintes géographiques chez des patients du Centre Léon Bérard (Lyon). *Espace populations sociétés*, (2018/1-2). https://doi.org/10.4000/eps.7767

CNAM. (2023). *Convention d'objectifs et de gestion*. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/publications-reference/assurance-maladie/convention-objectifs-gestion

Coldefy, M., Com-Ruelle, L., Lucas-Gabrielli, V., & Marcoux, L. (2011). *Les distances d'accès aux soins en France métropolitaine au 1er janvier 2007*. IRDES.

Défenseur des Droits. (2025). *Rapport - Prévenir les discriminations dans les parcours de soins : Un enjeu d'égalité*. Défenseur des Droits. https://www.defenseurdesdroits.fr/rapport-prevenir-les-discriminations-dans-les-parcours-de-soins-un-enjeu-degalite-853

Fassin, D., Grandjean, H., Kaminski, M., Lang, T., & Leclerc, A. (2000). Introduction. Connaître et comprendre les inégalités sociales de santé. In *Les inégalités sociales de santé* (p. 13-24). La Découverte. Cairn.info. https://shs.cairn.info/les-inegalites-sociales-de-sante--9782707132475-page-13?lang=fr

Gaglio, G., & Mathieu-Fritz, A. (2018). Les pratiques médicales et soignantes à distance:La télémédecine en actes. *Réseaux*, *207*(1), 9-24. https://doi.org/10.3917/res.207.0009

Goupil de Bouillé, J., Mubuanga, A., Tantet, C., de Monteynard, S., Dahmane, L., Brichler, S., Méchaï, F., Cordel, H., Vignier, N., & Bouchaud, O. (2025). The lack of digital equipment as the primary barrier to teleconsultation in a socially deprived French department during the COVID-19 epidemic period. *DIGITAL HEALTH*, *11*. https://doi.org/10.1177/20552076241284769

HAS. (2009). *Accès aux soins des personnes en situation de handicap—Rapport de la commission d'audition publique*. Haute Autorité de Santé. https://www.has-sante.fr/jcms/c_736311/fr/acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap-rapport-de-la-commission-d-audition-publique

Jacob, P., & Jousserandot, A. (2013, juin 6). *Un droit citoyen pour la personne handicapee, un parcours de soins et de | Vie publique*. https://www.vie-publique.fr/rapport/33212-un-droit-citoyen-pour-la-personne-handicapee-un-parcours-de-soins-et-de

Lapinte, A., & Blandine, L. (2021). *Renoncement aux soins : La faible densité médicale est un facteur aggravant pour les personnes pauvres*. DREES. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/renoncement-aux-soins-la-faible-densite-medicale-est-un-facteur

Légifrance. (2022). *Avis relatif à l'avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie signée le 22 juin 2007*. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046572815

Lengagne, P., Penneau, A., Pichetti, S., & Sermet, C. (2015). *L'accès aux soins courants et préventifs des personnes en situation de handicap en France : Résultats de l'enquête Handicap-santé*. Irdes.

Lombrail, P., Lang, T., & Pascal, J. (2004). *Accès au système de soins et inégalités sociales de santé : Que sait-on de l'accès secondaire ?* https://doi.org/10.3406/oss.2004.995

Lucas-Gabrielli, V., Bonal, M., Mangeney, C., Com-Ruelle, L., & Gousset, C. (2025). Inégalités spatiales d'accessibilité aux médecins spécialistes. *Rapport Irdes*, (597).

Lucas-Gabrielli, V., & Mangeney, C. (2019). Comment améliorer les mesures d'accessibilité aux soins pour mieux cibler les zones sous-denses ? *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, Colloque « Santé et société » organisé par l'Institut fédératif d'études et de recherche interdisciplinaires santé société (IFERISS)*, *67*, S25-S32. https://doi.org/10.1016/j.respe.2018.12.061

Lucas-Gabrielli, V., & Mangeney, C. (2021). Mesure des niveaux d'accessibilité aux soins en Ile-de-France. *IRDES*.

Luo, W., & Wang, F. (2003). Measures of Spatial Accessibility to Health Care in a GIS Environment : Synthesis and a Case Study in the Chicago Region. *Environment and Planning B: Planning and Design*, *30*(6), 865-884. https://doi.org/10.1068/b29120

OMS. (1976). *International classification of impairments, disabilities, and handicaps : A manual of classification relating to the consequences of disease*. https://iris.who.int/items/52433d37-0300-43d0-b7de-359f1486339f

ONU. (2006). *Convention relative aux droits des personnes handicapées*. OHCHR. https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities

Or, Z., & Parry, A. (2026). Feuille de route stratégique pour un système de santé soutenable et résilient : Agir en amont face aux maladies chroniques. *IRDES*, (603), 140.

Penneau, A., Pichetti, S., & Sermet, C. (avec Institut de recherche et documentation en économie de la santé). (2015a). *L'accès aux soins courants et préventifs des personnes en situation de handicap en France : Résultats de l'enquête Handicap-santé*. IRDES.

Penneau, A., Pichetti, S., & Sermet, C. (2015b). L'hébergement en institution favorise l'accès aux soins des personnes de moins de 60 ans en situation de handicap en France. *Questions d'économie de la santé*, (207), p.1-7.

Radke, J., & Mu, L. (2000). Spatial Decompositions, Modeling and Mapping Service Regions to Predict Access to Social Programs. *Geographic Information Sciences*, *6*(2), 105-112. https://doi.org/10.1080/10824000009480538

Ravaud, J.-F., Letourmy, A., & Ville, I. (2002). *Les méthodes de délimitation de la population handicapée : L'approche de l'enquête de l'Insee. Vie quotidienne et santé*. https://doi.org/10.2307/1535058

Rican, S., Vaillant, Z., Bochaton, A., & Salem, G. (2014). Inégalités géographiques de santé en France. *Les Tribunes de la santé*, *n° 43*(2), 39-45. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/seve.043.0039

Roduit, S. (2020). *Aux frontières de l'accès aux soins : Pratiques de tri et parcours de vie de personnes sans assurance-maladie à Genève*. ResearchGate. https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:137686

Safon, M.-O., & Suhard, V. (2023). L'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap. *Rapport Irdes*, 333.

Solar, O., & Irwin, A. (2010). *A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health*. https://www.who.int/publications/i/item/9789241500852

SPF. (2024, mai 22). *Littératie en santé : Rapport de l'étude Health Literacy Survey France 2020-2021*. https://www.santepubliquefrance.fr/docs/enquetesetudes/litteratie-en-sante-rapport-de-letude-health-literacy-survey-france-2020-2021

Tudor Hart, J. (1971). The inverse care law. *Originally published as Volume 1, Issue 7696*, *297*(7696), 405-412. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(71)92410-X

Vidal, P., & Le Hir, S. (2023). La crise de l'offre de soins peut-elle être amortie par la téléconsultation territoriale ? Premiers enseignements pour la Normandie. *Géographie, économie, société*, *Vol. 25*(4), 567-598. Cairn.info. https://doi.org/10.3166/ges.2023.0025

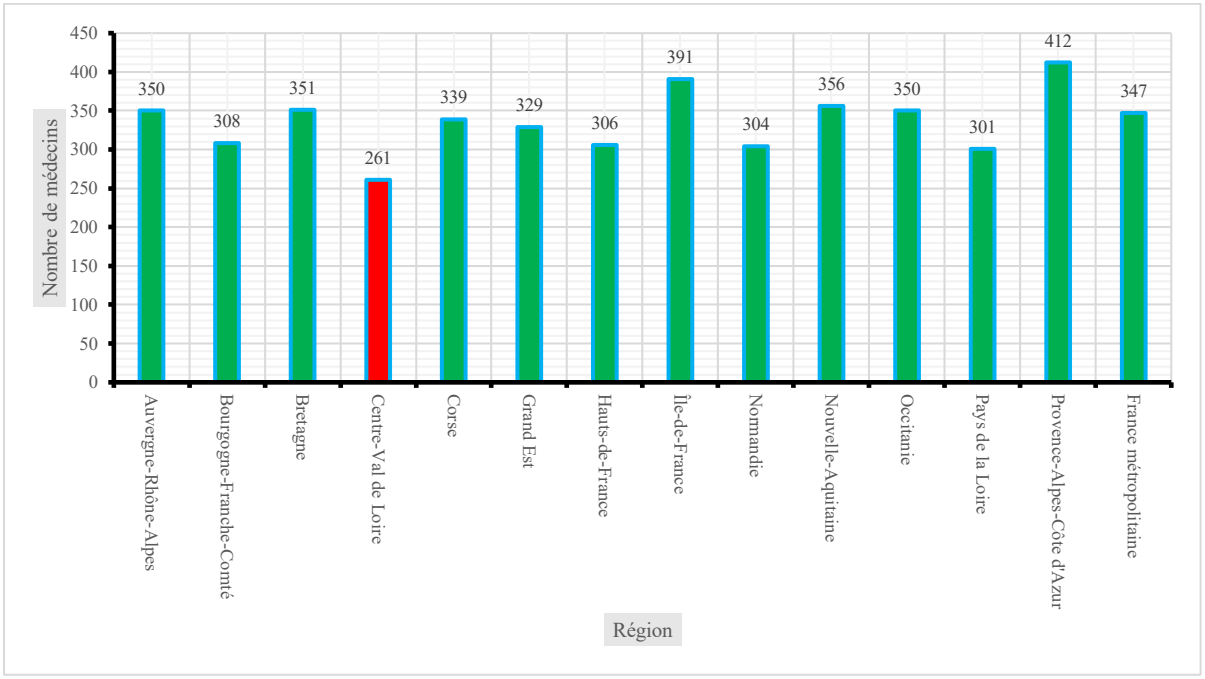
Vigneron, E. (2013). Inégalités de santé, inégalités de soins dans les territoires français. *Les Tribunes de la santé*, *n° 38*(1), 41-53. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/seve.038.0041

Wang, F., & Luo, W. (2005). Assessing spatial and nonspatial factors for healthcare access : Towards an integrated approach to defining health professional shortage areas. *Health & Place*, *11*(2), 131-146. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2004.02.003

Winance, M. (2024). Handicap. In M. Bouvet, F. Chossière, M. Duc, & E. Fisson (Éds.), *Catégoriser : Lexique de la construction sociale des différences* (p. 321-333). ENS Éditions. https://doi.org/10.4000/128qn

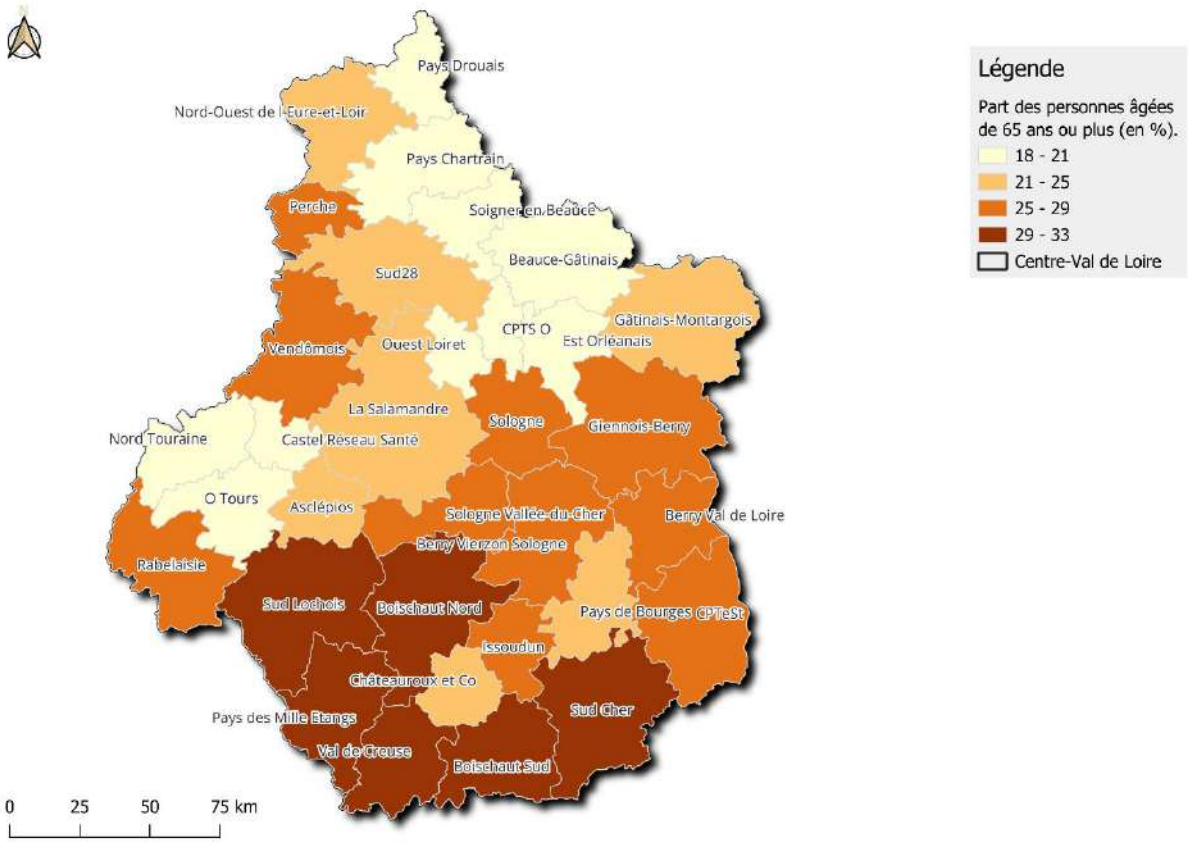
Annexes

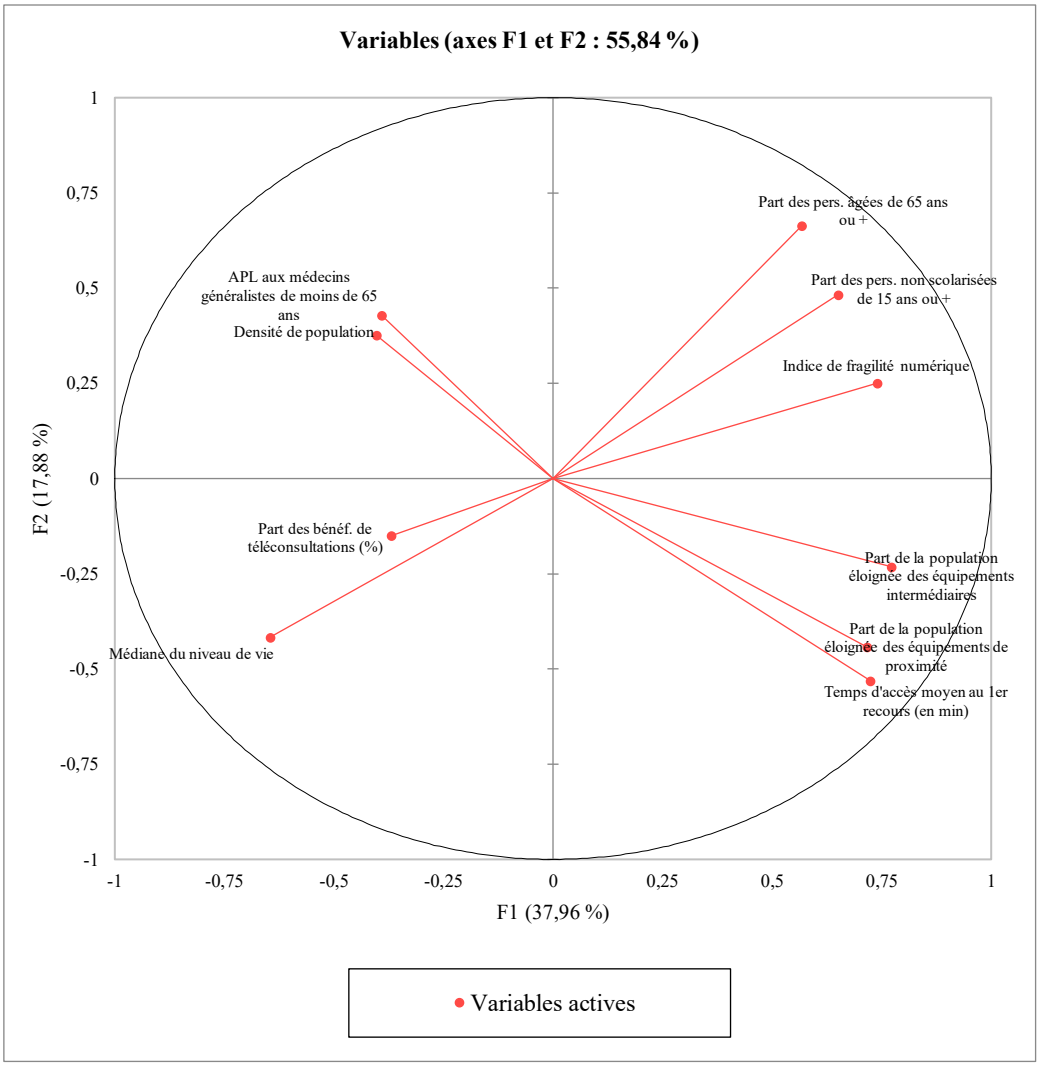
Annexe 1 : Nombre de médecins (ensemble) pour 100000 habitants - 1e janvier 2025

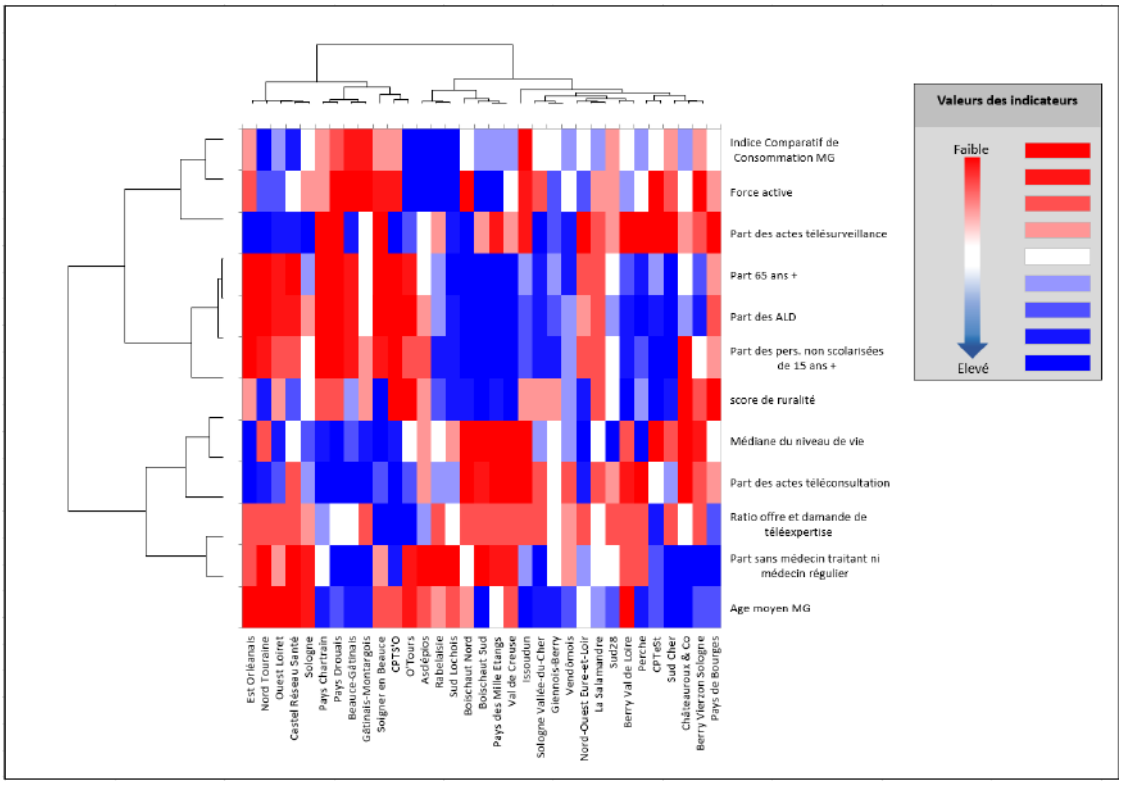


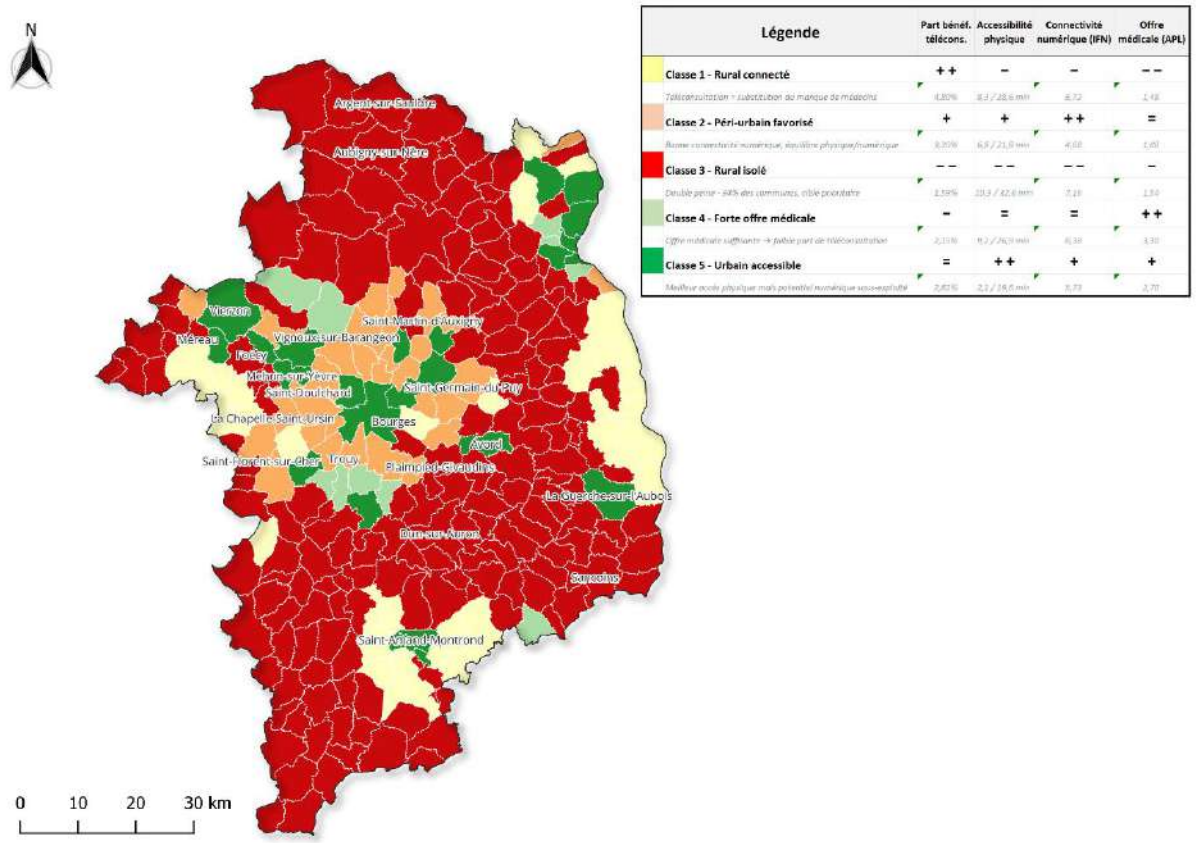
Sources : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), ASIP-Santé RPPS, traitements Drees ; Insee, Estimations de population.

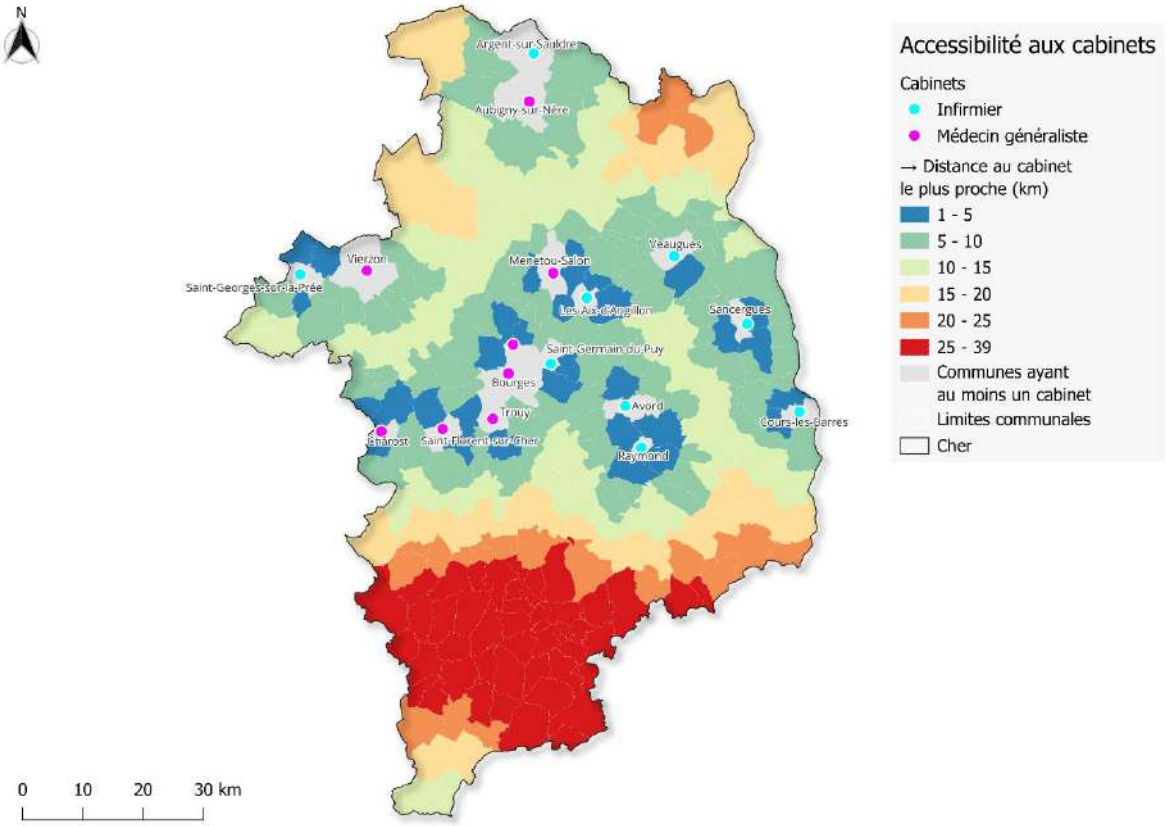
Réalisation : Gora NDOYE, le 24/11/2025

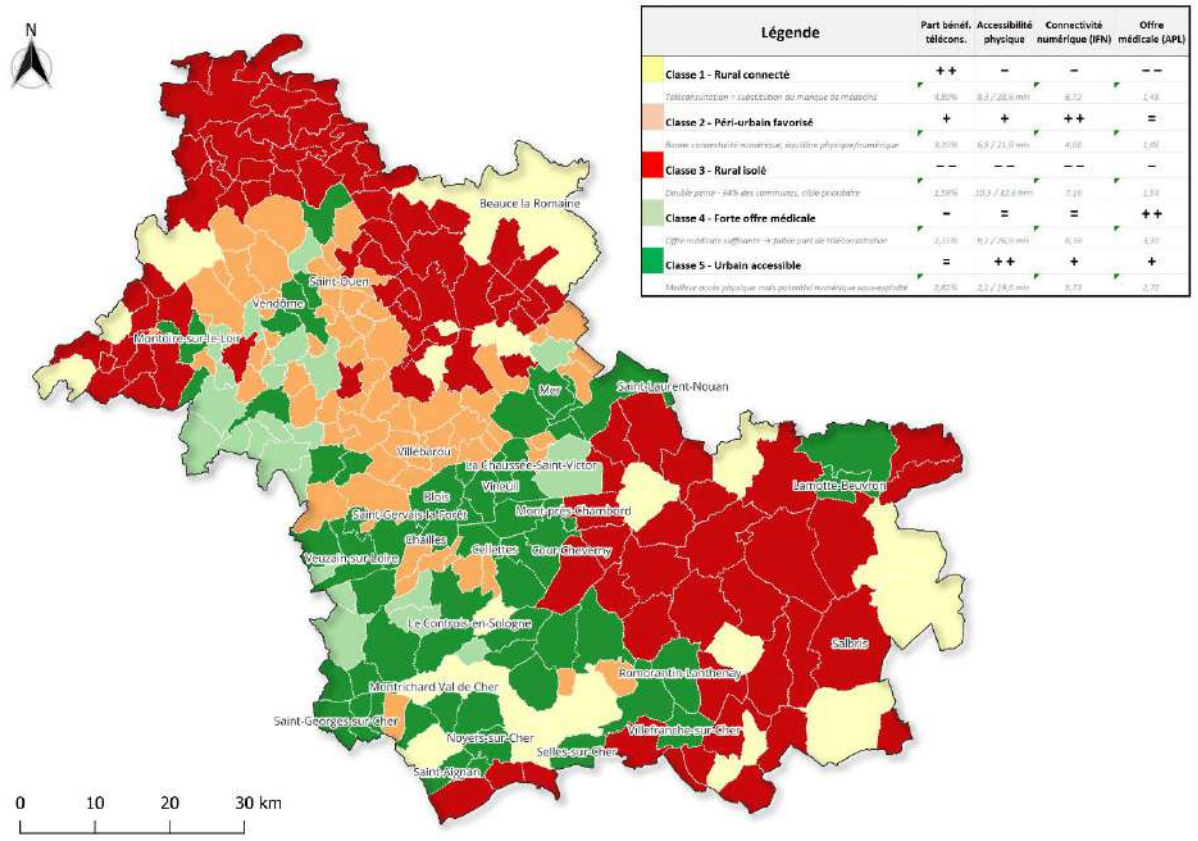


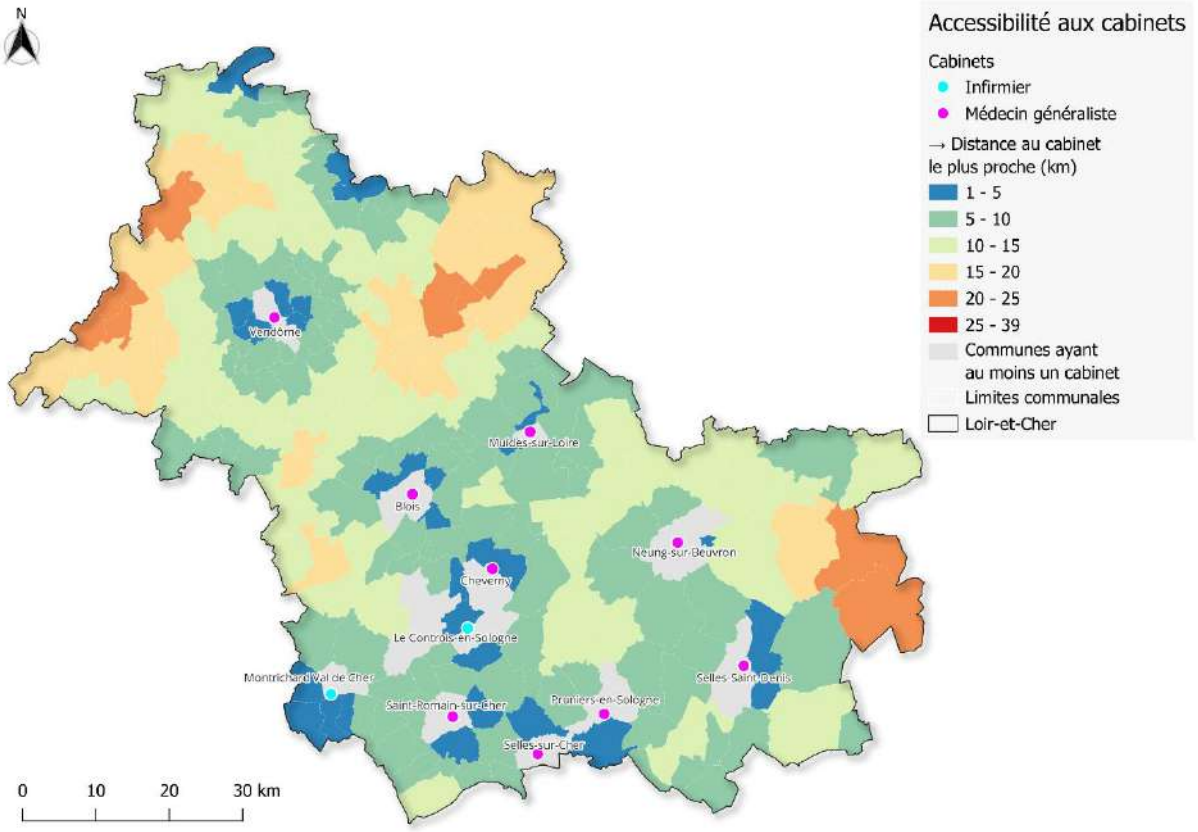

Variables (axes F1 et F2 : 55,84 %)
F2 (17,88 %)
F1 (37,96 %)
1
0,75
0,5
0,25
0
-0,25
-0,5
-0,75
-1
-1
-0,75
-0,5
-0,25
0
0,25
0,5
0,75
1
Part des pers. âgées de 65 ans ou +
Part des pers. non scolarisées de 15 ans ou +
Indice de fragilité numérique
APL aux médecins généralistes de moins de 65 ans
Densité de population
Part des bénéf. de téléconsultations (%)
Part de la population éloignée des équipements intermédiaires
Part de la population éloignée des équipements de proximité
Médiane du niveau de vie
Temps d'accès moyen au 1er recours (en min)
Variables actives

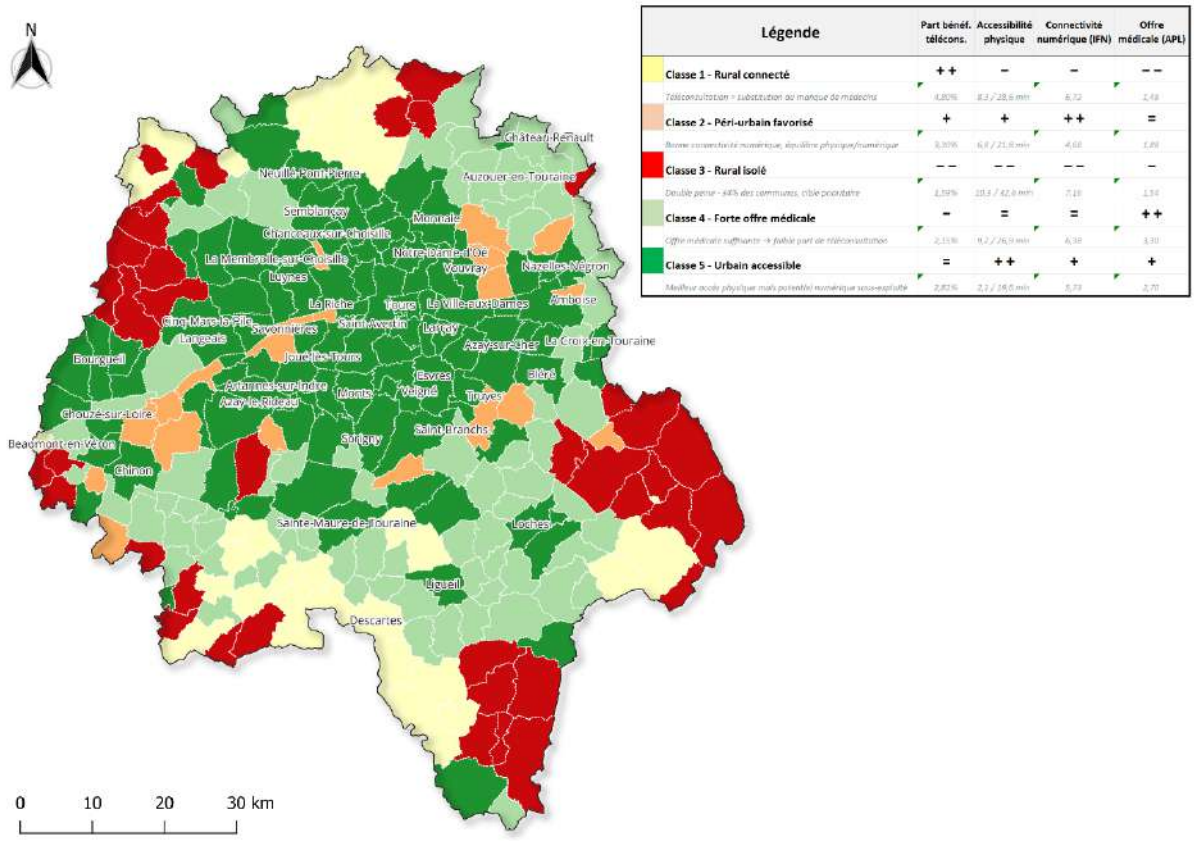

Valeurs des indicateurs
Faible
Elevé
Indice Comparatif de Consommation MG
Force active
Part des actes télésurveillance
Part 65 ans +
Part des ALD
Part des pers. non scolarisées de 15 ans +
score de ruralité
Médiane du niveau de vie
Part des actes téléconsultation
Ratio offre et damande de téléexpertise
Part sans médecin traitant ni médecin régulier
Age moyen MG
Est Orléanais
Nord Touraine
Ouest Loiret
Castel Réseau Santé
Sologne
Pays Chartrain
Pays Drouais
Beauce-Gâtinais
Gâtinais-Montargois
Solgner en Beauce
CPTSYO
CTours
Accépos
Rabelaise
Sud Lochois
Boischaut Nord
Boischaut Sud
Pays des Mille Etangs
Val de Creuse
Issoudun
Sologne Vallée-du-Cher
Giennois-Berry
Vendômois
Nord-Ouest Eure-et-Loir
La Salamandre
Sud28
Berry Val de Loire
Perche
CPTeSt
Sud Cher
Châteauroux & Co
Berry Vierzon Sologne
Pays de Bourges

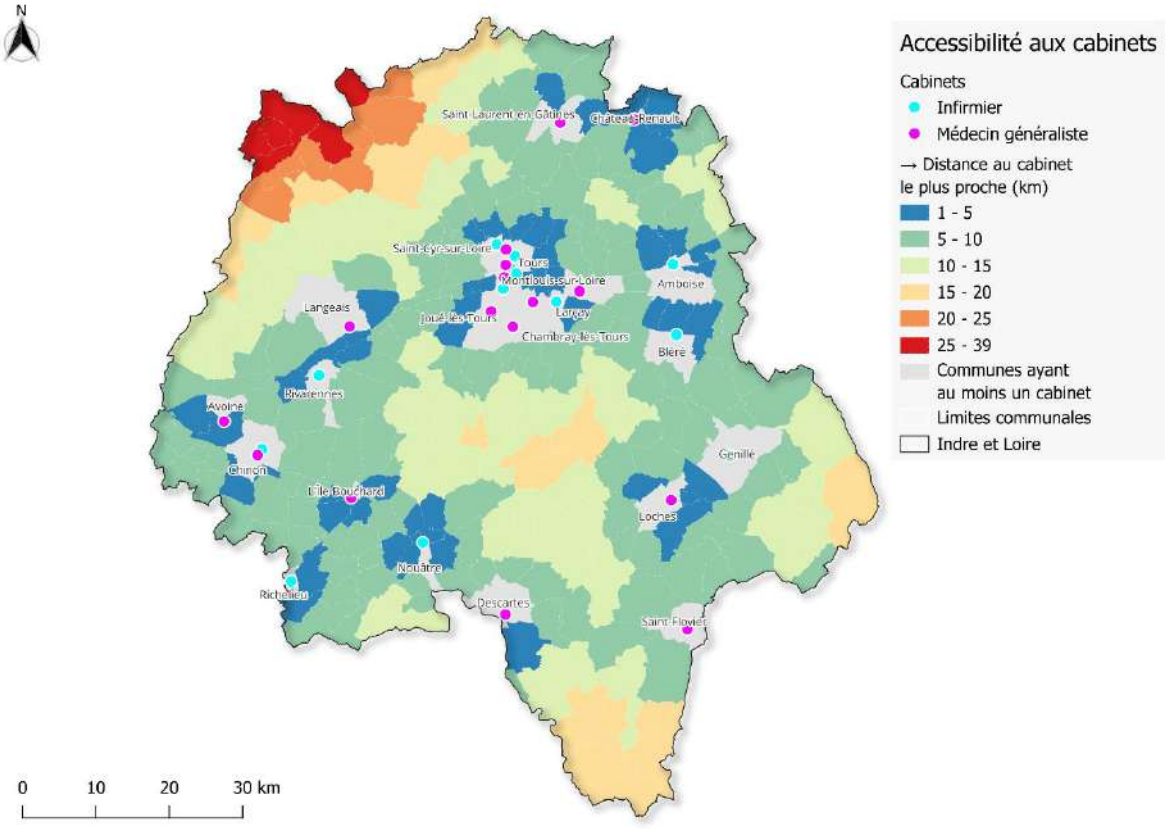

Légende
Part bénéf. télécons.
Accessibilité physique
Connectivité numérique (IFN)
Offre médicale (APL)
Classe 1 - Rural connecté
++
−
−
− −
Classe 2 - Péri-urbain favorisé
+
+
++
=
Classe 3 - Rural isolé
− −
− −
− −
−
Classe 4 - Forte offre médicale
−
=
=
++
Classe 5 - Urbain accessible
=
++
+
+
N
Argent-sur-Sauldre
Aubigny-sur-Nère
Vierzon
Méreau
Vignoux-sur-Barangeon
Foëcy
Mehun-sur-Yèvre
Saint-Doulchard
Saint-Germain-du-Puy
La Chapelle-Saint-Ursin
Bourges
Avord
Saint-Florent-sur-Cher
Trouy
Plaimpied-Givaudins
La Guerche-sur-l'Aubois
Bom-sur-Auron
Sancoins
Saint-Amand-Montrond
0
10
20
30 km


N
Argent-sur-Sauldre
Aubigny-sur-Nère
Vierzon
Saint-Georges-sur-la-Prée
Menetou-Salon
Veaugues
Les Aix-d'Angillon
Sancergues
Saint-Germain-du-Puy
Bourges
Avord
Trouy
Cours-les-Barres
Charost
Saint-Florent-sur-Cher
Raymond
0
10
20
30 km
Accessibilité aux cabinets
Cabinets
Infirmier
Médecin généraliste
→ Distance au cabinet le plus proche (km)
1 - 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 39
Communes ayant au moins un cabinet
Limites communales
Cher


Légende
Part bénéf. télécons.
Accessibilité physique
Connectivité numérique (IFN)
Offre médicale (APL)
Classe 1 - Rural connecté
++
−
−
− −
Classe 2 - Péri-urbain favorisé
+
+
++
=
Classe 3 - Rural isolé
− −
− −
− −
−
Classe 4 - Forte offre médicale
−
=
=
++
Classe 5 - Urbain accessible
=
++
+
+
N
Beauce la Romaine
Saint-Ouen
Vendôme
Montoire-sur-le-Loir
Mer
Saint-Laurent-Nouan
Villebarou
La Chaussée-Saint-Victor
Vineuil
Blois
Lamotte-Beuvron
Saint-Gervais-la-Forêt
Mont-près-Chambord
Chailles
Veuzain-sur-Loire
Cellettes
Cour-Cheverny
Le Controis-en-Sologne
Salbris
Romorantin-Lanthenay
Montrichard Val de Cher
Saint-Georges-sur-Cher
Noyers-sur-Cher
Villefranche-sur-Cher
Selles-sur-Cher
Saint-Aignan
0
10
20
30 km


N
Accessibilité aux cabinets
Cabinets
Infirmier
Médecin généraliste
→ Distance au cabinet le plus proche (km)
1 - 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 39
Communes ayant au moins un cabinet
Limites communales
Loir-et-Cher
Vendôme
Mulsans-sur-Loire
Blois
Neung-sur-Beuvron
Cheverny
Le Controis-en-Sologne
Montrichard Val de Cher
Selles-Saint-Denis
Saint-Romain-sur-Cher
Pruniers-en-Sologne
Selles-sur-Cher
0
10
20
30 km


Légende
Part bénéf. télécons.
Accessibilité physique
Connectivité numérique (IFN)
Offre médicale (APL)
Classe 1 - Rural connecté
++
−
−
− −
Téléconsultation = substitution au manque de médecins
4,80%
8,3 / 28,6 min
6,72
1,48
Classe 2 - Péri-urbain favorisé
+
+
++
=
Bonne connectivité numérique, équilibre physique/numérique
3,39%
6,8 / 21,8 min
4,68
1,89
Classe 3 - Rural isolé
− −
− −
− −
−
Double peine - 44% des communes, cible prioritaire
1,59%
10,3 / 42,6 min
7,18
1,34
Classe 4 - Forte offre médicale
−
=
=
++
Offre médicale suffisante → faible part de téléconsultation
2,15%
9,2 / 26,9 min
6,38
1,91
Classe 5 - Urbain accessible
=
++
+
+
Meilleur accès physique mais potentiel numérique sous-exploité
2,81%
2,1 / 16,0 min
5,73
2,70
N
Château-Renault
Neuillé-Pont-Pierre
Auzouer-en-Touraine
Semblançay
Mettray
Chanceaux-sur-Choisille
La Membrolle-sur-Choisille
Notre-Dame-d'Oé
Vouvray
Nazelles-Négron
Luynes
La Riche
Tours
Le Ville-aux-Dames
Amboise
Cinq-Mars-la-Pile
Savonnières
Saint-Avertin
Larçay
Langeais
Azay-sur-Cher
La Croix-sur-Touraine
Bourgueil
Joué-les-Tours
Esvres
Bléré
Artannes-sur-Indre
Vernou
Vallgué
Tauxyes
Azay-le-Rideau
Chouzé-sur-Loire
Saint-Branchs
Sorigny
Beaumont-en-Véron
Chinon
Sainte-Maure-de-Touraine
Loches
Ligueil
Descartes
0
10
20
30 km


N
Saint-Laurent-en-Gâtines
Château-Renault
Saint-Cyr-sur-Loire
Tours
Montbazon-sur-Loire
Amboise
Langeais
Joué-les-Tours
Larçay
Chambray-lès-Tours
Bléré
Rivarennes
Avoine
Genillé
Chinon
L'Ile-Bouchard
Loches
Noyant
Richelieu
Descartes
Saint-Flovier
0
10
20
30 km
Accessibilité aux cabinets
Cabinets
Infirmier
Médecin généraliste
→ Distance au cabinet le plus proche (km)
1 - 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 39
Communes ayant au moins un cabinet
Limites communales
Indre et Loire

Page retirée de la version publique

Elle présentait l'annexe qui liste, commune par commune, les 180 assurés sans solution de transport en commun praticable, d'après des données de l'Assurance Maladie.

Elle est retirée pour protéger ces personnes. Hors des passages signalés ainsi, le mémoire est identique à la version soutenue.

Page 90 de la version originale

Page retirée de la version publique

Elle présentait la suite de cette annexe, d'après des données de l'Assurance Maladie.

Elle est retirée pour protéger ces personnes. Hors des passages signalés ainsi, le mémoire est identique à la version soutenue.

Page 91 de la version originale

Fin de l'annexe des assurés sans solution de transport en commun praticable : retirée de la version publique.

Caractéristiques d'accessibilité déclarées par les professionnels référencés en Centre-Val de Loire (n = 225)

Caractéristique déclarée	Effectif	Part (%)
Places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite à proximité	197	87,6
Site entièrement de plain-pied	166	73,8
Sanitaires accessibles à disposition du public	158	70,2
Consultations à domicile proposées	136	60,4
Guichet bas ou bureau accessible en fauteuil	111	49,3
Praticien formé ou expérimenté dans la prise en charge du handicap	60	26,7
Entrée secondaire spécifique dédiée aux personnes à mobilité réduite	27	12,0
Ascenseur	13	5,8